

Bunga Rampai

DASAR-DASAR PRAKTIK KEPERAWATAN

PANDUAN SEDERHANA UNTUK ASUHAN DI FASILITAS KESEHATAN



Halimatussakdiah • Zikran • Asni Hasaini • Yoanita Hijriyati
Agus Sumarno • Sri Wahyuni

Editor : Novi Herawati

BUNGA RAMPAI

DASAR-DASAR PRAKTIK KEPERAWATAN: PANDUAN SEDERHANA UNTUK ASUHAN DI FASILITAS KESEHATAN

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Zikran, S.Kep., M.Kep.

Asni Hasaini, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep, M.Biomed.

Ns. Agus Sumarno, S.Kep., M.Pd.

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Editor:

Ns. Novi Herawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J.



Bunga Rampai Dasar-Dasar Praktik Keperawatan: Panduan Sederhana untuk Asuhan di Fasilitas Kesehatan

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Zikran, S.Kep., M.Kep.

Asni Hasaini, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep, M.Biomed.

Ns. Agus Sumarno, S.Kep., M.Pd.

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Editor:

Ns. Novi Herawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-72-1

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Bunga Rampai Dasar-Dasar Praktik Keperawatan: Panduan Sederhana untuk Asuhan di Fasilitas Kesehatan disusun sebagai pegangan ringkas bagi mahasiswa dan perawat pemula dalam memahami serta menerapkan langkah-langkah dasar asuhan keperawatan di layanan primer maupun rumah sakit. Dalam praktik sehari-hari, perawat dituntut memberikan pelayanan yang aman, beretika, berpusat pada pasien, dan tetap efektif meski dihadapkan pada keterbatasan waktu maupun sumber daya. Karena itu, buku ini menghadirkan materi yang sederhana, sistematis, dan aplikatif agar pembaca dapat membangun fondasi kompetensi klinis serta komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga.

Materi buku disajikan runtut sesuai daftar isi. Chapter 1 membahas konsep dasar keperawatan dalam pelayanan kesehatan, meliputi ruang lingkup, filosofi, paradigma, peran perawat, pendekatan patient centred care, serta edukasi pasien dalam asuhan. Chapter 2 menguraikan pengkajian pasien secara sederhana melalui pemeriksaan tanda-tanda vital, penggalan riwayat kesehatan, dan observasi dasar sebagai langkah awal penentuan masalah. Selanjutnya, Chapter 3 memaparkan diagnosis keperawatan yang umum muncul di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit, sehingga pembaca memiliki acuan dalam mengidentifikasi respon pasien secara tepat.

Untuk mendukung praktik sehari-hari, buku ini melanjutkan pada keterampilan intervensi dan edukasi. Chapter 4 menjelaskan intervensi keperawatan dasar—personal hygiene, mobilisasi, nutrisi, dan eliminasi—beserta integrasi, evaluasi, dan kolaborasi dalam pelaksanaannya. Chapter 5 menekankan pendidikan kesehatan sederhana bagi pasien dan keluarga, termasuk prinsip, metode, media, dan evaluasi edukasi, serta peran perawat sebagai edukator. Chapter 6 menutup dengan manajemen nyeri ringan—sedang menggunakan teknik nonfarmakologis yang dapat diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan, berikut kelebihan, keterbatasan, serta strategi penerapan di lapangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai panduan praktis untuk memperkuat asuhan keperawatan dasar yang aman, manusiawi, dan bermutu.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN DALAM PELAYANAN

KESEHATAN	1
------------------------	----------

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.	1
---	---

A. Pendahuluan/Prolog	1
-----------------------------	---

B. Tujuan.....	2
----------------	---

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Keperawatan	4
---	---

D. Filosofi Keperawatan.....	5
------------------------------	---

E. Paradigma Keperawatan.....	6
-------------------------------	---

F. Peran Perawat.....	9
-----------------------	---

G. Pelayanan Kesehatan berpusat pada pasien (Patient Centred Care)	10
--	----

H. Edukasi Kepada pasien dalam Asuhan Keperawatan.....	15
--	----

I. Simpulan.....	17
------------------	----

J. Referensi.....	18
-------------------	----

CHAPTER 2 PENGKAJIAN PASIEN SECARA SEDERHANA: VITAL SIGN, RIWAYAT KESEHATAN DAN OBSERVASI DASAR

Ns. Zikran, S.Kep., M.Kep.	23
---------------------------------	----

A. Pendahuluan.....	23
---------------------	----

B. Vital Sign (Tanda-Tanda Vital)	24
---	----

C. Riwayat Kesehatan.....	27
---------------------------	----

D. Observasi Dasar	29
--------------------------	----

E. Simpulan.....	33
------------------	----

F. Referensi.....	33
-------------------	----

CHAPTER 3 DIAGNOSA KEPERAWATAN UMUM YANG SERING MUNCUL DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER DAN RS

Asni Hasaini	35
--------------------	----

A. Konsep Diagnosis Keperawatan	35
---------------------------------------	----

B. Diagnosis Keperawatan Umum di Rumah Sakit.....	39
---	----

C. Diagnosis Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Primer	55
--	----

D. Simpulan.....	57
------------------	----

E. Referensi.....	58
F. Glosarium.....	59

CHAPTER 4 INTERVENSI KEPERAWATAN DASAR: PERSONAL HYGIENE, MOBILISASI, NUTRISI, ELIMINASI.....61

Ns. Yoanita Hijriyati, S.kep., M.Biomed.....	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Intervensi Keperawatan: Personal Hygiene	62
C. Intervensi Keperawatan: Mobilisasi	65
D. Intervensi Keperawatan: Nutrisi	67
E. Intervensi Keperawatan: Eliminasi.....	69
F. Integrasi, Evaluasi, dan Kolaborasi dalam Intervensi Keperawatan Dasar.....	71
G. Simpulan.....	73
H. Daftar Referensi	74

CHAPTER 5 PENDIDIKAN KESEHATAN SEDERHANA BAGI PASIEN DAN KELUARGA78

Ns. Agus Sumarno, S.Kep., M.Pd.....	78
A. Pendahuluan.....	78
B. Konsep Dasar Pendidikan Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga.....	79
C. Tujuan Pendidikan Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga.....	81
D. Pendidikan kesehatan berbasis keluarga	81
E. Peran Pendidikan Kesehatan dalam Peningkatan Kemandirian Pasien dan Keluarga.....	82
F. Pendidikan Kesehatan dalam Konteks Pasien dan Keluarga.....	83
G. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kesehatan Sederhana Bagi Pasien dan Keluarga.....	84
H. Peran Pasien dan Keluarga dalam Proses Edukasi	87
I. Penerapan Pendidikan Kesehatan Sederhana pada Kasus pasien dan keluarga.....	88
J. Metode dan Media Pendidikan Kesehatan dalam Praktik Keperawatan.....	89
K. Evaluasi Pendidikan Kesehatan	90
L. Peran Perawat sebagai Edukator.....	91
M. Simpulan.....	92
N. Referensi.....	93

CHAPTER 6 MANAJEMEN NYERI RINGAN–SEDANG DENGAN TEKNIK NONFARMAKOLOGIS	95
Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Konsep Dasar Nyeri.....	96
C. Konsep Manajemen Nyeri Nonfarmakologis.....	100
D. Jenis-Jenis Teknik Nonfarmakologis	103
E. Implementasi Teknik Nonfarmakologis di Fasilitas Kesehatan.....	106
F. Kelebihan dan Keterbatasan Teknik Nonfarmakologis	108
G. Tantangan dan Strategi Penerapan Teknik Nonfarmakologis di Lapangan.....	112
H. Simpulan.....	114
I. Referensi.....	117
J. Glosarium.....	122
PROFIL PENULIS	123

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Pelayanan keperawatan merupakan fondasi utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang tidak sekadar memberikan bantuan medis, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasien secara holistik, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sebagai profesi yang berkembang secara global, Profesi keperawatan berakar pada nilai kemanusiaan (*caring*) dan proses ilmiah dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang profesional. Konsep dasar keperawatan mencakup sejarah, falsafah, teori, serta landasan praktik yang memandu perawat dalam memberikan asuhan yang berkualitas dan efektif dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Pemahaman kuat terhadap konsep-konsep ini menjadi kunci untuk menerapkan asuhan keperawatan secara konsisten dalam konteks klinik maupun komunitas (Ole Martin Nordaunet et al., 2023).

Selain itu, Profesi keperawatan dipandang sebagai disiplin ilmu dan profesi yang memiliki identitas khusus melalui standar praktik, kompetensi profesional, serta etika keperawatan yang terintegrasi. Melalui pendekatan profesi, perawat tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga mendukung klien dan keluarganya untuk mencapai kemandirian dalam aktivitas sehari-hari serta kesejahteraan secara keseluruhan. Konsep ini menekankan pentingnya perawat dalam kolaborasi inter multidisipliner demi mencapai hasil pelayanan kesehatan yang optimum dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks dan dinamis (Jumbri et al., 2023).

Dalam pelaksanaan praktik di berbagai pelayanan kesehatan, Pelayanan keperawatan juga mencakup pemahaman tentang *fundamental care*, yakni intervensi dasar yang meliputi kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilitas, higiene, dan hubungan klinis antara perawat dan klien, yang seluruhnya berperan penting dalam keselamatan serta kualitas layanan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam literatur keperawatan, konsep esensial ini tetap berpusat pada hubungan terapeutik dan kontinuitas asuhan yang

berdampak langsung terhadap pengalaman klien secara klinis dan psikososial (Cao et al., 2023).

Akhirnya, teori dan model keperawatan menjadi kerangka konseptual yang membantu tenaga profesional keperawatan dalam merancang, menerapkan, serta mengevaluasi asuhan secara sistematis. Teori seperti *caring theory* dan model-model konseptual lainnya tidak hanya memperkaya landasan akademik, tetapi juga memperluas wawasan perawat tentang bagaimana fenomena kesehatan dan kesejahteraan pasien dapat dipahami serta ditanggapi secara holistic dan pelayanan yang berpusat pada pasien (Patient centered care). Dengan landasan teori dan bukti ilmiah, perawat mampu meningkatkan mutu praktik keperawatan dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu keperawatan di era modern pelayanan Kesehatan (Pamungkas et al., 2025).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan bab ini didasarkan pada kebutuhan institusi pendidikan keperawatan, dosen, dan mahasiswa dalam mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif, sistematis, dan bermutu. Bab ini disusun sebagai panduan pembelajaran yang membantu pencapaian indikator Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) secara terukur dan berkelanjutan. Penjabaran tujuan secara lebih rinci disajikan pada uraian berikut.

1. Tujuan bagi Dosen

- a. Sebagai pedoman pembelajaran
Memberikan kerangka konseptual yang sistematis bagi dosen dalam menyusun, menyampaikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran konsep dasar keperawatan secara terstruktur dan berkesinambungan sesuai kebutuhan mahasiswa.
- b. Mendukung pengembangan kurikulum
Sebagai panduan dalam pengembangan dan penyelarasan kurikulum pendidikan keperawatan dengan standar nasional dan kebutuhan pelayanan kesehatan terkini.
- c. Memfasilitasi integrasi teori dan praktik
Membantu dosen mengaitkan konsep, teori, dan falsafah keperawatan dengan praktik asuhan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan Kesehatan baik Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Komunitas.
- d. Mendorong pembelajaran berbasis bukti

Menyediakan landasan ilmiah bagi dosen dalam menerapkan *evidence-based teaching* dan mengintegrasikan hasil penelitian keperawatan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di lahan praktik.

e. Memperkuat peran dosen sebagai fasilitator profesionalisme

Memotivasi dosen dalam menanamkan nilai etika, tanggung jawab profesional, dan identitas perawat sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan humanis dalam tatanan Pendidikan keperawatan.

2. Tujuan bagi Mahasiswa

a. Memahami konsep dasar keperawatan secara komprehensif

Membantu dan mengarahkan mahasiswa memahami pengertian, ruang lingkup, dan peran keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

b. Membangun dasar berpikir kritis tentang keperawatan

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis mahasiswa dalam memahami hubungan antara konsep, teori, dan praktik keperawatan.

c. Menjadi landasan dalam mempelajari asuhan keperawatan

Menyiapkan mahasiswa untuk memahami proses keperawatan dan penerapannya pada mata kuliah lanjutan serta praktik klinik di rumah sakit, klinik, Puskesmas dan komunitas.

d. Menumbuhkan sikap profesional dan etis

Membentuk sikap tanggung jawab, etika, dan nilai *caring* sebagai karakter utama perawat dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada individu keluarga dan masyarakat.

e. Meningkatkan kesiapan menghadapi praktik klinik dan dunia kerja

Membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar yang kuat agar mampu beradaptasi dan berkontribusi secara aktif dalam pelayanan kesehatan berbasis tim pada semua tatanan pelayanan Kesehatan di masyarakat.

3. Tujuan bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

a. Mendukung pencapaian visi dan misi institusi

Pencapaian pembelajaran yang selaras dengan visi institusi dalam menghasilkan lulusan perawat yang kompeten, profesional, dan beretika dalam pelayanan Kesehatan di masyarakat.

b. Menjadi acuan standar pembelajaran keperawatan

Menyediakan referensi akademik yang terstruktur dan seragam sebagai pedoman pembelajaran konsep dasar keperawatan di seluruh program studi keperawatan.

- c. Memperkuat implementasi kurikulum berbasis OBE
Mendukung penerapan *Outcome-Based Education* dengan menyediakan materi yang relevan untuk pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- d. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan lulusan
Membantu institusi Pendidikan Keperawatan untuk memastikan kualitas pembelajaran melalui materi yang sistematis, berbasis bukti ilmiah, dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan praktik keperawatan secara global.
- e. Mendukung akreditasi dan penjaminan mutu internal
Menjadi dokumen akademik pendukung dalam proses akreditasi program studi sebagai bukti kreativitas dosen dan evaluasi mutu pendidikan keperawatan secara berkelanjutan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Keperawatan

Keperawatan merupakan sebuah profesi dan disiplin ilmu yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui praktik pelayanan yang holistik dan berpusat pada klien. Menurut definisi dari *International Council of Nurses* (ICN), keperawatan adalah sebuah profesi yang berdedikasi untuk menjunjung hak setiap orang memperoleh standar kesehatan tertinggi melalui komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kolaboratif, aman, berbudaya, dan berorientasi pada klien. Profesi ini tidak hanya berfokus pada perawatan kondisi sakit tetapi juga mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perlindungan keselamatan pasien, serta advokasi akses layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan (Horton-deutsch et al., 2025).

Seorang perawat merupakan tenaga kesehatan yang terdidik secara formal, memiliki kompetensi ilmiah dan keterampilan praktik, serta diatur oleh standar profesional dan kode etik dalam pelaksanaan praktiknya. Organisasi profesi seperti *Persatuan Perawat Nasional Indonesia* (PPNI) juga memainkan peran penting dalam pengembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia melalui penetapan standar praktik, pendidikan berkelanjutan, serta advokasi peran perawat dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. PPNI berkomitmen memfasilitasi perawat agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau di berbagai tatanan kesehatan, serta meningkatkan kompetensi anggotanya sesuai kebutuhan masyarakat sesuai kebutuhan (O M Nordaunet et al., 2024).

Ruang lingkup keperawatan mencakup berbagai bentuk asuhan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di berbagai tingkat pelayanan Kesehatan, meliputi layanan primer, layanan sekunder dan tersier

(*primary, secondary, tertiary care*). Selain itu asuhan promotif difokuskan pada upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, seperti pendidikan kesehatan dan advokasi hidup sehat. Sementara itu, asuhan preventif diarahkan pada pencegahan timbulnya penyakit melalui kegiatan imunisasi, pemeriksaan berkala, dan deteksi dini faktor risiko kesehatan. Sementara disisi lain, asuhan kuratif berfokus pada pengobatan dan perawatan klinis untuk kondisi sakit, sedangkan rehabilitatif bertujuan memulihkan fungsi dan kualitas hidup setelah sakit atau cedera (Purisima et al., 2024).

Dalam pelaksanaan praktik sehari-hari di berbagai pusat layanan, peran perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan secara menyeluruh pada semua fase kehidupan dan lingkungan kesehatan tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Keperawatan beroperasi dalam berbagai konteks, seperti di rumah sakit, klinik, puskesmas, hingga komunitas. Kegiatan pelayanan melibatkan kolaborasi inter profesional kesehatan lain untuk mencapai hasil kesehatan optimal. Pendekatan ini menekankan penyelenggaraan asuhan yang terintegrasi, berbasis bukti (*evidence-based practice*), serta berorientasi pada keselamatan dan kebutuhan klien dalam konteks sosialnya (Fahriyyan et al., 2025).

D. Filosofi Keperawatan

Filosofi keperawatan berakar pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk utuh dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling terkait. Dalam konteks ini, keperawatan tidak hanya berfokus pada penyakit atau gejala klinis, tetapi juga pada keseluruhan pengalaman hidup individu sebagai manusia yang berharga (*holistic care*). Holisme berarti perawat memperhatikan keseluruhan kondisi pasien, bukan sekadar bagian tubuh yang sakit, sehingga asuhan keperawatan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan holisme sebagai fondasi filosofis yang memandu praktik keperawatan di berbagai konteks pelayanan Kesehatan (Ewunetu, 2023).

Nilai martabat manusia (*human dignity*) merupakan inti dari filosofi keperawatan yang mengakui bahwa setiap individu layak untuk diperlakukan dengan hormat tanpa memandang latar belakang, kondisi kesehatan, status sosial, atau budaya (*integritas persona*). Respek terhadap martabat mengharuskan perawat memperlakukan pasien secara manusiawi, menghormati privasi dan pilihan mereka dalam proses perawatan, serta menjaga otonomi pasien dalam setiap keputusan kesehatan (*autonomy*). Nilai ini tidak hanya menjadi prinsip etika, tetapi juga menjadi pedoman dalam komunikasi terapeutik dan pengambilan keputusan klinis bersama pasien (Correia et al., 2025).

Aspek empati dan caring merupakan manifestasi praktis dari filosofi keperawatan yang menekankan kemampuan perawat untuk memahami perspektif dan emosi pasien serta meresponsnya dengan penuh perhatian dan kepedulian (*compassionate care*). Caring tidak sekadar tindakan teknis, tetapi mencakup kehadiran autentik, mendengarkan secara aktif, serta membangun hubungan terapeutik yang mendukung proses perawatan untuk mengoptimalkan penyembuhan pasien. Empati dan caring memungkinkan perawat menciptakan lingkungan yang menunjang rasa aman dan nyaman bagi pasien, sehingga pengalaman perawatan menjadi lebih bermakna dan efektif (Shahriari et al., 2013).

Nilai profesional keperawatan mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas dalam setiap tindakan keperawatan. Tanggung jawab berarti perawat harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan perilaku profesionalnya serta mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan ilmiah dan standar praktik yang profesional. Akuntabilitas memperkuat komitmen perawat untuk memberikan asuhan yang aman dan berkualitas tinggi, sambil mengakui konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan selama praktik keperawatan. Nilai ini menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan dan melindungi keselamatan pasien selama berada dalam konteks pelayanan di rumah sakit, klinik, Puskesmas bahkan komunitas (Cemp et al., 2024).

Keadilan sosial merupakan nilai profesional lain yang melekat pada praktik keperawatan, di mana perawat dipanggil untuk memperlakukan semua pasien secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Keadilan dalam keperawatan mencakup akses pelayanan yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat serta advokasi bagi klien yang mungkin menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan. Ketika nilai keadilan diterapkan secara konsisten, praktik keperawatan tidak hanya memastikan pemenuhan kebutuhan individu pasien, tetapi juga berkontribusi terhadap sistem pelayanan kesehatan yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

E. Paradigma Keperawatan

Paradigma keperawatan merupakan kerangka konseptual fundamental yang membedakan ilmu keperawatan dengan disiplin ilmu lain, dimana profesi ini dipahami melalui hubungan terintegrasi antara empat konsep utama: *manusia (person)*, *kesehatan (health)*, *lingkungan (environment)*, dan *keperawatan (nursing)* itu sendiri. Paradigma bukan sekadar teori tunggal, tetapi sebuah cara pandang holistik yang memandu praktik profesional dan penelitian dalam keperawatan dan menjadi landasan pemikiran bahwa setiap tindakan keperawatan harus

memperhatikan keterkaitan keempat konsep ini secara simultan. Keempat unsur tersebut membentuk *metaparadigma* keperawatan. istilah yang dipopulerkan dan dijadikan acuan dalam pengembangan model dan teori keperawatan modern yang berorientasi pada pelayanan klien secara keseluruhan (*holistic care*) serta konteks sosial-budaya mereka (Purisima et al., 2024).

Dalam paradigma keperawatan, manusia (individu) dipandang sebagai entitas biopsikosial-spiritual yang *unik, utuh, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan internal dan eksternal*. Manusia bukan hanya makhluk biologis yang sakit atau sehat, tetapi juga makhluk sosial, emosional, dan spiritual yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan (*well-being*) yang optimal (*holistic human being*). Perspektif ini menempatkan manusia sebagai penerima asuhan kesehatan yang aktif, yang memiliki perasaan, nilai, dan tujuan hidup tertentu, sehingga keperawatan tidak hanya memperbaiki kondisi fisiologis, melainkan juga memperhatikan pengalaman, makna, dan preferensi pasien dalam setiap fase kehidupan (Ilkafah et al., 2023).

Konsep kesehatan (*health*) dalam paradigma keperawatan dilihat sebagai rentang kontinu antara sehat dan sakit, bukan sekadar ketiadaan penyakit, tetapi mencakup kondisi kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang dinamis. Kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kemampuan individu beradaptasi terhadap stresor internal dan eksternal serta interaksi mereka dengan lingkungan. Dalam konteks praktik keperawatan, pemahaman terhadap konsep kesehatan ini memungkinkan perawat menyusun rencana asuhan yang tidak hanya fokus pada penyembuhan gangguan klinis tetapi juga pada pencegahan komplikasi, pemberdayaan klien dan keluarga, serta promosi gaya hidup sehat berdasarkan kebutuhan dan tujuan hidup pasien.

Konsep lingkungan (*environment*) mencakup seluruh kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi status kesehatan individu, mulai dari lingkungan fisik seperti tempat tinggal, iklim, kebersihan, hingga lingkungan sosial-kultural yang meliputi norma, nilai, serta dukungan keluarga dan komunitas. Lingkungan berinteraksi dengan klien secara terus-menerus dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan kesehatan (*homeostasis*), kemampuan adaptasi, serta respons terhadap asuhan keperawatan. Paradigma keperawatan menekankan bahwa perawat harus menilai lingkungan secara menyeluruh untuk menciptakan kondisi yang mendukung proses penyembuhan, mempercepat pemulihan, serta mengurangi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi klien.



Gambar 1.1: Paradigma Keperawatan

Pada gambar 1, dapat kita lihat bahwa, keperawatan (nursing) sebagai konsep dalam paradigma bukan hanya tindakan teknis pemberian obat atau prosedur klinis, tetapi sebuah profesi yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah, nilai etika, dan tindakan terapeutik yang disusun untuk meningkatkan kesehatan manusia di tengah realitas lingkungan sosial dan kondisi kesehatannya. Konsep ini mengintegrasikan komponen teori, praktik, penelitian, dan pendidikan keperawatan yang saling berkaitan dalam memberikan asuhan yang holistik dan *patient-centered*. Hubungan antar empat unsur ini bersifat dinamis dan saling mempengaruhi tentang pemahaman bahwa manusia dan kesehatannya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dan keperawatan merespon kompleksitas ini melalui pendekatan intervensi yang komprehensif, adaptif, serta berorientasi pada pencapaian hasil kesehatan yang optimal bagi individu dan masyarakat (Kvist et al., 2024).

Asuhan keperawatan merupakan inti dari praktik keperawatan profesional yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien secara holistik, terstruktur, dan berkesinambungan. Secara umum, asuhan keperawatan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan ilmiah yang dilakukan perawat meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna membantu individu, keluarga, atau masyarakat dalam mempertahankan atau memulihkan kesehatan serta mencegah penyakit. Asuhan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan dan etika yang menegaskan pentingnya *caring*, komunikasi terapeutik, serta keterlibatan klien dalam seluruh tahapan asuhan. Asuhan keperawatan merupakan pendekatan yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan seni praktik yang bertujuan meningkatkan keselamatan, mutu, dan pengalaman pasien dalam mengoptimalkan adaptasi dari sakit menjadi sehat seutuhnya (Nursalam, 2020).

F. Peran Perawat

Beberapa peran perawat yang dikemukakan oleh beberapa sumber antara lain seperti uraian berikut ini

1. Peran sebagai Pemberi Asuhan (Care Provider)

Perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan memberikan asuhan langsung kepada klien yang bersifat komprehensif, mencakup pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan individu. Peran ini mengintegrasikan pendekatan holistik, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Salah satu tujuannya yaitu memaksimalkan hasil kesehatan dan meminimalkan komplikasi klinis. Dalam konteks pelayanan kesehatan kontemporer, pemberi asuhan tidak hanya fokus pada penyembuhan penyakit tetapi juga pada promosi kesehatan dan pencegahan komplikasi, sehingga perawat menjadi pemberi pelayanan utama dalam penyelenggaraan layanan yang aman dan berkualitas terhadap pasien (O M Nordaunet et al., 2024).

2. Peran sebagai Pendidik (Educator)

Selain pemberi asuhan, perawat juga berfungsi sebagai pendidik kesehatan yang bertanggung jawab meningkatkan pemahaman pasien, keluarga, dan masyarakat tentang kondisi kesehatan, manajemen perawatan penyakit, pencegahan komplikasi, serta keterampilannya untuk perawatan berkelanjutan di rumah. Pendidikan ini meliputi penggunaan obat-obatan, tata laksana dan tindakan untuk mengatasi gejala, perubahan gaya hidup, dan strategi hidup sehat yang didasarkan pada tingkatan literasi. Peran ini penting untuk memberdayakan klien agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kesehatannya dan mendukung pemulihan yang berkesinambungan (Pamungkas et al., 2025).

3. Peran sebagai Advokat Pasien (Patient Advocate)

Sebagai advokat pasien, perawat memberikan dukungan dan perlindungan terhadap hak serta kebutuhan pasien, termasuk menjembatani komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lain untuk memastikan keputusan klinis yang diambil mencerminkan preferensi pasien. Advokasi ini meliputi pembelaan hak atas informasi yang akurat, privasi, persetujuan tindakan, dan layanan yang layak sesuai standar etika dan hukum. Peran ini semakin penting di era kompleksitas layanan modern dan global, di mana

advokasi membantu memperkuat suara pasien dalam perencanaan dan penerapan asuhan kesehatan Peran sebagai Kolaborator (Collaborator).

Kolaborasi merupakan peran kunci di mana perawat bekerja secara interprofesional dengan dokter, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, dan profesional kesehatan lain untuk menyusun rencana asuhan yang terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Melalui proses kolaboratif, tim kesehatan dapat berbagi pengetahuan, menyelaraskan prioritas perawatan, dan mengatasi kompleksitas kasus klinis yang memerlukan kompetensi dari berbagai disiplin. Pendekatan interprofesional ini terbukti meningkatkan kualitas layanan dan hasil kesehatan secara keseluruhan karena menggabungkan berbagai perspektif professional (Jumbri et al., 2023) .

4. Peran sebagai Manajer Asuhan (Care Manager)

Sebagai manajer asuhan, perawat memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi, mengoordinasikan, dan mengawasi proses pemberian asuhan keperawatan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, puskesmas, dan layanan komunitas. Peran manajer ini mencakup penyusunan jadwal, alokasi sumber daya, pengembangan standar operasional, serta evaluasi mutu layanan untuk memastikan kontinuitas asuhan yang aman, efektif, dan efisien. Kemampuan manajemen ini penting untuk meningkatkan kinerja tim, mengatasi hambatan layanan, dan memastikan standar mutu terpenuhi secara konsisten (Mabunda et al., 2024)

5. Peran sebagai Peneliti (Researcher)

Perawat juga berperan sebagai peneliti yang mengembangkan dan menerapkan pengetahuan baru melalui penelitian keperawatan untuk memajukan praktik klinis dan kebijakan layanan kesehatan. Peran ini mencakup penyusunan desain penelitian, pengumpulan serta analisis data, dan penerapan hasil riset untuk meningkatkan *evidence-based practice* (EBP) dan hasil klinis pasien. Penelitian keperawatan membantu memperkuat dasar ilmiah intervensi keperawatan, meningkatkan kualitas asuhan, dan memberi kontribusi pada literatur keperawatan global (*nurse scientist* sebagai model riset lanjutan).

G. Pelayanan Kesehatan berpusat pada pasien (Patient Centred Care)

Pelayanan kesehatan berpusat pada pasien (patient centre care) merupakan pendekatan pelayanan yang menempatkan pasien sebagai fokus utama dalam seluruh proses asuhan, mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelayanan. Dalam pendekatan ini, pasien dipandang sebagai individu yang

utuh dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Pelayanan tidak hanya diarahkan pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai, preferensi, serta keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Pendekatan ini penting karena mampu membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan pasien, yang menjadi dasar utama terciptanya pelayanan yang aman, manusiawi, dan bermutu (Fang, 2025).

Penerapan pelayanan kesehatan berpusat pada pasien memberikan manfaat yang nyata baik bagi petugas kesehatan maupun pasien. Bagi pasien, pendekatan ini meningkatkan pemahaman terhadap kondisi kesehatan, rasa aman, kepuasan, serta kepatuhan terhadap rencana asuhan. Sementara bagi petugas kesehatan, pelayanan berpusat pada pasien membantu proses asuhan menjadi lebih terarah, komunikatif, dan kolaboratif, sehingga mengurangi kesalahan tindakan, konflik, dan beban kerja yang tidak efektif. Dengan menjadikan pasien sebagai mitra dalam asuhan, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Untuk memahami dan melaksanakan tugas dipelayanan dengan baik, dapat dipahami beberapa materi berikut ini (Keperawatan et al., 2025).

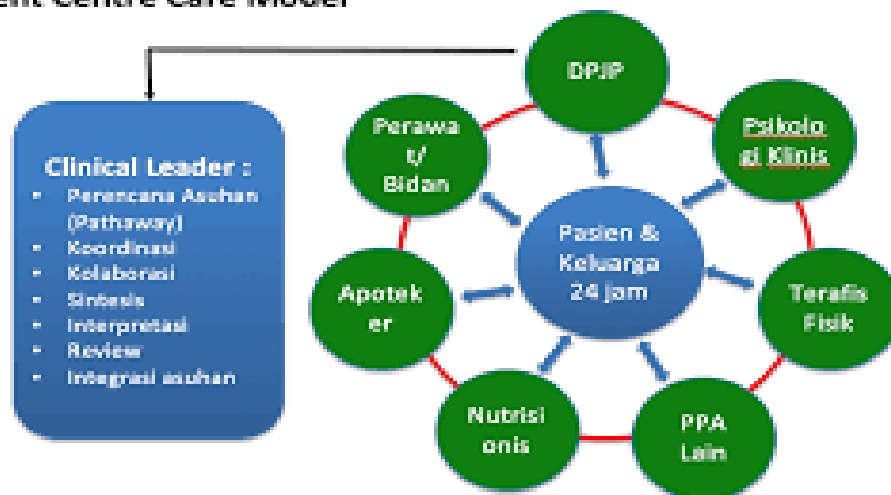
1. Konsep Dasar Patient-Centred Care (PCC)

Patient-Centred Care (PCC) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat utama dalam proses asuhan, bukan sekadar objek tindakan medis semata. Pendekatan ini menekankan bahwa seluruh aspek perawatan, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Pelaksanaannya harus disesuaikan dengan nilai, kebutuhan, preferensi, dan kondisi unik setiap individu pasien. Tindakan yang dilakukan pada pasien, tidak dilakukan secara generik atau hanya berdasarkan protokol medis, tetapi dikembangkan berdasarkan dialog dan kolaborasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan (Hong & Moliterno, 2020).

PCC juga memandang pasien sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan klinis yang berkaitan dengan kesehatannya, sehingga keputusan yang diambil bukan semata mata atas nama tenaga kesehatan tetapi berdasarkan pemahaman bersama yang menghormati hak dan pilihan pasien. Hal ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa pelayanan yang menghormati preferensi dan nilai pasien dapat meningkatkan kepuasan pasien, keterlibatan pasien dalam perawatan, dan pengalaman pasien secara keseluruhan (Care et al., 2025).

Pendekatan ini menuntut perubahan cara kerja petugas kesehatan, dari yang bersifat individual dan profesi-sentris menjadi kolaboratif dan berorientasi pada pasien. Setiap keputusan klinis sebaiknya melibatkan pasien dan keluarga secara aktif melalui komunikasi yang jelas, empatik, dan dua arah. Dengan demikian, pasien memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kesehatannya dan turut berperan dalam pengambilan keputusan terkait perawatan saat ini dan mendatang. Selain itu praktik pelayanan sehari-hari, PCC membantu meningkatkan keselamatan pasien, kepatuhan terhadap terapi dan menurunkan kejadian tidak diinginkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan, terutama pada layanan primer dan rumah sakit. Untuk Memahami PCC lebih lanjut, dapat diperhatikan gambar berikut ini.

Patient Centre Care Model



Gamabar 1.1: Patient centre care model

2. Pasien dan Keluarga sebagai Pusat Asuhan (24 Jam)

Pada gambar 1, digambarkan bahwa pasien dan keluarga berada di pusat lingkaran, menandakan bahwa seluruh pelayanan kesehatan harus berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh selama 24 jam. Pasien dipandang sebagai individu utuh yang memiliki aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keluarga juga diakui sebagai bagian penting dalam proses penyembuhan, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan dan perawatan lanjutan di rumah (Ewunetu, 2023).

Keterlibatan keluarga sangat penting dalam meningkatkan kontinuitas asuhan, khususnya pada pasien dengan penyakit kronis, lansia, dan anak. Petugas kesehatan perlu memberikan edukasi yang jelas kepada keluarga

mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai setiap saat, terutama pada kelompok rentan. Dengan keterlibatan aktif keluarga, risiko kesalahan perawatan dan kegagalan tindak lanjut dapat diminimalkan (Hong & Moliterno, 2020).

Dalam panduan praktik sederhana, petugas kesehatan dianjurkan untuk selalu melibatkan pasien dan keluarga dalam diskusi rencana asuhan, menghargai pendapat mereka, serta memastikan informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini terbukti meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan serta keberlanjutan pelayanan Kesehatan (Bayoumy et al., 2024).

3. Peran Clinical Leader dalam Asuhan Terpadu

Clinical leader dalam model ini berperan sebagai pengarah utama asuhan pasien, yang memastikan bahwa pelayanan berjalan terkoordinasi, aman, dan sesuai kebutuhan pasien. Clinical leader dapat berasal dari profesi tertentu sesuai konteks layanan (misalnya dokter atau perawat), dengan tugas utama memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan pasien secara menyeluruh (Puchalski et al., 2020).

Peran clinical leader mencakup koordinasi antarprofesi, pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, serta memastikan komunikasi yang efektif di dalam tim. Clinical leader juga bertanggung jawab mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, memantau perkembangan kondisi pasien, dan menyesuaikan rencana asuhan bila terjadi perubahan klinis. Selain itu pimpinan tim ini dapat memodifikasi tindakan sesuai kebutuhan pasien dan keluarganya (Kvist et al., 2024).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan praktik asuhan pelayanan sehari-hari, perlu digarisbawahi bahwa keberadaan clinical leader sangat membantu petugas kesehatan dalam bekerja secara sistematis dan terarah. Adanya kepemimpinan klinis yang baik dan profesional, pelayanan kepada pasien menjadi lebih terintegrasi, mengurangi duplikasi tindakan, serta meningkatkan mutu dan keselamatan asuhan pasien sesuai standar (Nutbeam & Lloyd, 2021).

4. Peran Tim Interprofesional dalam Patient-Centred Care

Pelaksanaan asuhan dengan pendekatan model ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan diberikan oleh tim interprofesional yang terdiri dari DPJP, perawat/bidan, apoteker, nutrisisionis, terapis fisik, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap profesi memiliki peran dan kompetensi yang berbeda,

namun saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pasien secara holistik. Kolaborasi interprofesional memungkinkan penanganan pasien secara komprehensif, mulai dari diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, hingga dukungan psikososial. Peran petugas sesuai keahlian dan keilmuannya seperti, apoteker berperan dalam menjamin keamanan dan ketepatan penggunaan obat, nutrisisionis mendukung pemenuhan gizi, sementara psikolog klinis membantu aspek kesehatan mental pasien. Kolaborasi ini terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Reeves et al., 2017).

Dalam panduan sederhana ini, diharapkan bahwa petugas kesehatan, kerja tim interprofesional perlu didasari komunikasi yang terbuka, saling menghargai peran, dan fokus pada tujuan bersama yaitu keselamatan dan kesejahteraan pasien. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan kerja tenaga kesehatan.

5. Koordinasi dan Kolaborasi dalam Pelayanan Berkelanjutan

Garis penghubung antarprofesi dalam model asuhan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan. Pelayanan tidak dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing profesi, tetapi saling terintegrasi sepanjang perjalanan pasien, mulai dari pelayanan awal hingga tindak lanjut di rumah (Edgman-levitan & Schoenbaum, 2021). Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan pasien ditangani secara menyeluruh dan konsisten di setiap tahapan pelayanan. Koordinasi yang baik memungkinkan alur informasi antarpetugas berjalan lancar dan berkesinambungan. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa pelayanan yang terkoordinasi merupakan kunci utama dalam penerapan pelayanan berpusat pada pasien dan peningkatan mutu layanan kesehatan (Ferrell, 2019).

Koordinasi dan kolaborasi yang efektif berperan penting dalam mencegah kesalahan komunikasi, duplikasi tindakan, serta keterlambatan pelayanan. Dalam praktik sehari-hari, koordinasi dapat dilakukan melalui diskusi tim interprofesional, pencatatan asuhan yang sistematis, dan penggunaan sistem rujukan yang jelas. Dokumentasi yang terintegrasi membantu setiap petugas memahami peran dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Selain itu, komunikasi yang terstruktur antarprofesi mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan aman. Literatur terkini menunjukkan bahwa kolaborasi tim yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keselamatan pasien dan efisiensi pelayanan (Reeves et al., 2017).

Panduan sederhana ini menekankan bahwa setiap petugas kesehatan memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi secara efektif dan

mendokumentasikan asuhan dengan baik. Komunikasi yang jelas dan konsisten antarpetugas membantu menjaga kesinambungan pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan. Dengan koordinasi yang kuat, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih aman, efisien, dan terarah. Pendekatan ini juga meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diterima. Pelayanan kesehatan yang terkoordinasi dan kolaboratif terbukti mendukung pencapaian asuhan yang berpusat pada pasien serta peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan (Correia et al., 2025).

H. Edukasi Kepada pasien dalam Asuhan Keperawatan

Edukasi kepada pasien dalam asuhan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang bertujuan membantu pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan, rencana perawatan, serta peran mereka dalam proses penyembuhan. Edukasi yang baik memungkinkan pasien memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan pemahamannya. Pendekatan ini penting karena pasien yang teredukasi dengan baik cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perawatan diri. Edukasi pasien bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi merupakan proses komunikasi terapeutik yang berkelanjutan (Puchalski et al., 2020).

Selain itu, edukasi yang efektif meningkatkan pemahaman, rasa percaya diri, kepatuhan terhadap pengobatan, serta kemampuan dalam mengenali tanda bahaya dan melakukan perawatan mandiri. Sementara bagi petugas kesehatan, edukasi pasien membantu memperlancar proses asuhan, mengurangi kesalahpahaman, serta mencegah kejadian yang tidak diinginkan akibat kurangnya informasi. Edukasi yang terstruktur juga mendukung efisiensi pelayanan karena pasien dan keluarga lebih siap menjalani perawatan dan tindak lanjut. Oleh karena itu, edukasi pasien merupakan strategi penting untuk menciptakan asuhan yang aman, efektif, dan berkelanjutan oleh petugas Kesehatan (Haggerty et al., 2022).

1. Langkah-Langkah Edukasi dan Komunikasi dalam Asuhan

Sebelum melakukan edukasi kepada pasien dan keluarganya, perlu dipahami langkah-langkah sebelum edukasi. Langkah pertama dalam edukasi dan komunikasi asuhan adalah melakukan pengkajian kebutuhan informasi pasien dan keluarga. Petugas kesehatan perlu memahami tingkat pendidikan, kondisi psikologis, budaya, serta kemampuan pasien dalam menerima informasi kesehatan. Edukasi yang diberikan tanpa mempertimbangkan konteks pasien

berisiko tidak dipahami dan tidak diterapkan dengan baik, sehingga tujuan asuhan tidak tercapai.

Langkah kedua adalah menyampaikan informasi secara jelas, terstruktur, dan empatik. Petugas kesehatan dianjurkan menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari istilah medis yang rumit, serta memastikan informasi disampaikan secara bertahap. Komunikasi yang baik tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dengan pasien dan keluarga, dengan harapan tujuan dan maksud edukasi dapat dipahami dengan baik oleh pasien dan keluarga (Silverman et al., 2022).

Langkah ketiga adalah melibatkan pasien dan keluarga secara aktif dalam proses komunikasi. Pasien perlu diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta mengekspresikan kekhawatiran terkait kondisi kesehatannya. Keterlibatan aktif ini merupakan inti dari pendekatan patient-centered care dan terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap rencana asuhan (Edgman-levitan & Schoenbaum, 2022).

Langkah keempat adalah melakukan evaluasi pemahaman pasien melalui metode seperti *teach-back*, yaitu meminta pasien mengulangi kembali informasi yang telah disampaikan dengan kata-katanya sendiri. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa edukasi benar-benar dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pasien (Rn et al., 2023).

2. Penerapan Edukasi dan Komunikasi dalam Praktik Asuhan

Dalam praktik sehari-hari, edukasi dan komunikasi harus dilakukan sejak awal kontak pelayanan, mulai dari pendaftaran, pengkajian, hingga tindak lanjut asuhan. Setiap interaksi antara petugas kesehatan dan pasien merupakan kesempatan untuk memberikan edukasi kesehatan yang bermakna, baik terkait kondisi penyakit, tindakan yang akan dilakukan, maupun pencegahan komplikasi. Penerapan edukasi yang efektif menuntut petugas kesehatan untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan kondisi pasien. Pada pasien akut, edukasi difokuskan pada informasi penting dan keselamatan, sedangkan pada pasien kronis, edukasi dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap. Pendekatan ini membantu pasien memahami perannya dalam pengelolaan kesehatan jangka panjang (Ferrell, 2019).

Komunikasi dalam asuhan juga harus bersifat interprofesional, artinya setiap anggota tim kesehatan menyampaikan pesan yang konsisten dan saling mendukung. Ketidaksinkronan informasi antar petugas dapat membingungkan pasien dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan. Oleh karena itu,

koordinasi komunikasi menjadi bagian penting dalam penerapan asuhan berpusat pada pasien (Reeves et al., 2017).

Selain itu, edukasi dan komunikasi perlu didokumentasikan sebagai bagian dari asuhan. Dokumentasi yang baik membantu memastikan kesinambungan pelayanan dan menjadi dasar evaluasi keberhasilan edukasi. Pencatatan ini juga mendukung keselamatan pasien dan akuntabilitas profesional petugas Kesehatan.

3. Media Edukasi dan Komunikasi

Penggunaan media edukasi merupakan alat bantu penting untuk memperkuat pesan yang disampaikan secara lisan. Media yang sederhana seperti leaflet, poster, dan lembar balik sangat efektif digunakan di fasilitas kesehatan karena mudah dipahami dan dapat dibaca ulang oleh pasien dan keluarga. Selain penggunaan media cetak, media audiovisual seperti video edukasi dan animasi singkat semakin banyak digunakan karena mampu menyampaikan informasi secara lebih menarik dan interaktif. Media ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan prosedur, penggunaan obat, atau perubahan gaya hidup, terutama bagi pasien dengan keterbatasan membaca (Nutbeam & Lloyd, 2021).

Dalam konteks pelayanan modern, media digital seperti pesan singkat, aplikasi kesehatan, dan platform daring juga dapat dimanfaatkan untuk edukasi dan tindak lanjut pasien. Penggunaan media digital memungkinkan komunikasi berkelanjutan antara petugas kesehatan dan pasien, khususnya dalam pemantauan penyakit kronis dan kepatuhan terapi. Namun demikian, pemilihan media edukasi harus disesuaikan dengan kondisi fasilitas kesehatan dan karakteristik pasien. Media yang efektif adalah media yang mudah diakses, relevan, dan mendukung komunikasi dua arah. Petugas kesehatan tetap berperan utama dalam menjelaskan dan mengklarifikasi informasi yang disampaikan melalui media tersebut (Correia et al., 2025).

I. Simpulan

Issue utama pelaksanaan asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan menekankan bahwa pelayanan harus diberikan secara aman, sistematis, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Penerapan pelayanan kesehatan berpusat pada pasien memperkuat prinsip tersebut dengan menempatkan pasien dan keluarga sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan asuhan. Pendekatan ini mendorong petugas kesehatan untuk tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga memperhatikan nilai, preferensi, serta kondisi

individual pasien. Harapannya, asuhan yang diberikan menjadi lebih manusiawi, responsif, dan bermakna bagi pasien. Integrasi prinsip dasar asuhan dan patient centred care merupakan fondasi penting dalam peningkatan mutu pelayanan di fasilitas Kesehatan di seluruh dunia.

Edukasi kepada pasien dalam asuhan menjadi penguat utama dari penerapan pelayanan berpusat pada pasien. Melalui edukasi yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan, pasien dan keluarga dapat memahami kondisi kesehatan, rencana perawatan, serta peran mereka dalam proses penyembuhan. Edukasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien, tetapi juga membantu petugas kesehatan dalam menciptakan komunikasi yang lebih baik, mencegah kesalahan, dan meningkatkan keselamatan pasien. Oleh karena itu, penerapan prinsip dasar asuhan, pelayanan berpusat pada pasien, dan edukasi pasien harus berjalan secara selaras dan berkesinambungan agar tercapai pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan pasien dan keluarga.

J. Referensi

-
- Bayoumy, S. A., Ghazi, C. M., & Abdrbo, A. A. (2024). *Impact of Patient-Centred Care and Work Environment on Adverse Patient Events in Intensive Care Units among Nurses: A Cross-Sectional Correlational Design*. 16(October), 21–35. <https://doi.org/10.31674/mjn.2024.v16isupp1.003>
- Cao, H., Song, Y., Wu, Y., Du, Y., He, X., Chen, Y., & Wang, Q. (2023). What is nursing professionalism? a concept analysis. *BMC Nursing*, 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-01161-0>
- Care, P., Vithana, K. V. G. S. G., Asurakkody, T. A., & Warnakulasuriya, S. S. P. (2025). Overview of spiritual care instruments and its domains: a scoping review. *BMC Palliative Care*, 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01750-1>
- Cemp, J., Tengah, P., Rw, R. T., Tim, C. P., Putih, K. C., & Jakarta, K. (2024). *Philosophies Teori Konsep Keperawatan Jean Watson "Caring" Rinezia Rinza Farizal Irna Nursanti dan kemanusiaan terhadap proses , fenomena dan pengalaman perawatan manusia . Ilmu caring .* 2(1).
- CORE COMPETENCIES FOR PROFESSIONAL NURSING EDUCATION THE ESSENTIALS*: (2021).
- Correia, T., Martins, M. M., Barroso, F., Pinho, L., & Valentim, O. (2025). *Patient and Family-Centered Care to Promote Inpatient Safety: An Exploration of Nursing Care and Management Processes*. 1–19.

- Edgman-levitan, S., & Schoenbaum, S. C. (2021). *Patient-centered care: achieving higher quality by designing care through the patient 's eyes*. 1–5.
- Ewunetu, M. (2023). *Patients ' Perception of Patient-Centered Care and Associated Factors Among Patients Admitted in Private and Public Hospitals: A Comparative Cross-Sectional Study*. April.
- Fahriyyan, A., Wiji, D., Sari, P., & Issroviatiningrum, R. (2025). *Hubungan Peran Perawat sebagai Edukator dengan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman Nyaman Pasien*. 3.
- Fang, C. (2025). *Development , Validity , and Reliability of Three Instruments to Assess Holistic Care from Different Perspectives*. June, 3647–3671.
- Ferrell, B. (2019). *National Consensus Project Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care: Implications for Oncology Nursing*. 151–153. <https://doi.org/10.4103/apjon.apjon>
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., & Adair, C. E. (n.d.). *Continuity of care: a multidisciplinary review*. 1219–1221.
- Hong, C. S., & Moliterno, J. (2020). *The Patient-Centered Approach: A Review of the Literature and Its Application for Acoustic Neuromas*. 280–286.
- Horton-deutsch, S., Coach, C., Willis, D. G., Llasus, L., Coach, C., Beck, M., Coach, C., Trainer, H., Fankhauser, K., Leader, C., Ambrosio-mawhirter, D., & Watson, J. (2025). Weaving Caring Science into the AACN Essentials: A cross-impact analysis and resource guide. *Journal of Professional Nursing*, 56(April 2024), 36–48. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2024.11.001>
- Ilkafah, I., Pangestu, A., Tyas, M., & Rachmawaty, R. (2023). *The ethical principles and caring behavior of Indonesian nurses m er ci us e on us e m er*. 11.
- Jumbri, M., Setiawan, H., & Rizany, I. (2023). *Peran Perawat Sebagai Edukator , Kolaborator , dan Koordinator dalam Integrated Discharge Planning sesuai SNARS di RSD Idaman Kota Banjarbaru*. 3.
- Keperawatan, A., Centered, P., Dalam, C., Gawat, P., Di, D., & Salatiga, R. (2025). *Asuhan keperawatan patinet - centered care dalam pelayanan gawat darurat di rsud salatiga*. 8, 39–41.
- Kvist, L., Rn, A., Lassen, A. T., & Rn, D. N. (2024). *Receiving person- - centred care in a hospital — - A qualitative study of socially marginalised patients ' experiences of social nursing*. February 2023, 220–230. <https://doi.org/10.1111/scs.13212>

- Mabunda, N. F., Masondo, I. G., Beer, A. G. M., & Health, S. M. (2024). *Nurses ' understanding of quality documentation: A qualitative study in a Mental Health Institution*. 1–8.
- Nordaunet, O M, Gjevjon, E. R., Olsson, C., Aagaard, H., & Borglin, G. (2024). What about the fundamentals of nursing — its interventions and its continuity among older people in need of home - or facility - based care: a scoping review. *BMC Nursing*, 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01675-1>
- Nordaunet, Ole Martin, Gjevjon, E. R., Olsson, C., Aagaard, H., & Borglin, G. (2023). *Fundamental nursing care focusing on older people ' s needs and continuity of term care: a scoping review protocol*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069798>
- Nursalam. (2020). *Metodologi Keperawatan* (Vol. 13, Issue 1).
- Nutbeam, D., & Lloyd, J. E. (2021). *Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant of Health*. 159–173.
- Pamungkas, L. J., Az-zahra, R. I. P., & Permana, D. T. (2025). *Peran Perawat dalam Shared Decision Making untuk Pasien Penyakit Kronis: Suatu Tinjauan Sistematis 2015 – 2025*. 5(2), 1667–1678.
- Puchalski, C., Jafari, N., Buller, H., Haythorn, T., Jacobs, C., & Ferrell, B. (2020). *Interprofessional Spiritual Care Education Curriculum: A Milestone toward the Provision of Spiritual Care*. 23(6). <https://doi.org/10.1089/jpm.2019.0375>
- Purisima, E. M., Oliber, B., Jr, A., Locsin, R. C., Montayre, J., & Nero, F. D. (2024). *Reframing the environment domain of the nursing metaparadigm: Exploring space , place , and technology*. 10(6), 614–623.
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., Zwarenstein, M., Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). *Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes (Review)*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>. www.cochranelibrary.com
- Rn, T. H., Manager, R., & Kuha, S. (2023). *Patients ' experiences of patient- - centred care in hospital setting: A systematic review of qualitative studies*. January, 1001–1015. <https://doi.org/10.1111/scs.13174>
- Shahriari, M., Mohammadi, E., Abbaszadeh, A., & Bahrami, M. (2013). *Nursing ethical values and definitions: A literature review*. 18(1), 1–8.

Silverman, J., Kurtz, S., & Draper, J. (n.d.). *Skills for Communicating with Patients Third Edition Skills for Communicating with Patients Third Edition*.

CHAPTER 2

PENGKAJIAN PASIEN SECARA SEDERHANA: VITAL SIGN, RIWAYAT KESEHATAN DAN OBSERVASI DASAR

□ Ns. Zikran, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Pengkajian pasien merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses asuhan keperawatan maupun pelayanan Kesehatan (Potter & Perry, 2010; Xiong, 2025). Pengkajian bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi fisik, psikologis, sosial, serta spiritual pasien. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan diagnosis, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi (Alsadaan, 2026; Potter & Perry, 2010).

Menurut *World Health Organization* (WHO), penilaian kondisi kesehatan secara sistematis membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini masalah kesehatan serta mencegah komplikasi. Selain itu, standar praktik keperawatan yang dikembangkan oleh *American Nurses Association* (ANA) menekankan bahwa pengkajian merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan yang harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan (Black & Hawks, 2014; Potter & Perry, 2010).

Pengkajian adalah langkah pertama dan paling krusial dalam proses keperawatan yang bertujuan mengumpulkan data secara sistematis (Black & Hawks, 2014). **Dasar Pengambilan Keputusan:** Data yang akurat dari pengkajian menjadi dasar untuk merumuskan diagnosis dan menentukan rencana tindakan medis atau keperawatan yang tepat. **Keamanan Pasien (Patient Safety):** Pengkajian awal membantu mengidentifikasi risiko (seperti alergi atau risiko jatuh) guna mencegah kesalahan medis dan meningkatkan [keselamatan pasien](#) (Sarangi, 2012).

Pendekatan Holistik: Pengkajian tidak hanya melihat fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasien untuk memberikan asuhan yang menyeluruh. **Efisiensi Layanan:** Dengan data awal yang lengkap, tenaga kesehatan dapat memprioritaskan masalah kesehatan yang paling mendesak (seperti prinsip ABCDE: *Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*). Secara sederhana, pengkajian pasien dapat difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu: vital sign (tanda-tanda vital), riwayat kesehatan, dan observasi dasar (Black & Hawks, 2014; Potter & Perry, 2010).

B. Vital Sign (Tanda-Tanda Vital)

Vital sign merupakan untuk menilai kondisi fisiologis pasien. Pemeriksaan tanda vital membantu mendeteksi adanya infeksi, gangguan kardiovaskular, gangguan pernapasan, maupun kondisi kegawatdaruratan dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Tanda-tanda vital adalah pengukuran fungsi-fungsi dasar tubuh. Tanda-tanda vital berguna dalam mendeteksi masalah keperawatan pasien dan dapat diukur di lingkungan medis, di rumah, di lokasi keadaan darurat medis, atau pelayanan Kesehatan yang lain (Potter & Perry, 2010).

Tanda-tanda vital (vital signs/TTV) adalah pengukuran fungsi fisiologis dasar tubuh yang krusial untuk menilai status kesehatan, mendeteksi masalah medis, dan memantau respons terhadap pengobatan. Empat komponen utamanya meliputi suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah. Berikut adalah konsep utama dari tanda-tanda vital (Black & Hawks, 2014; Muttaqin, 2012; Potter & Perry, 2010):

1. **Tekanan Darah (Blood Pressure):** Mengukur kekuatan darah pada dinding arteri saat jantung memompa (sistolik) dan istirahat (diastolik). Normal: <120/80 mmHg.
2. **Denyut Nadi (Heart Rate/Pulse):** Frekuensi detak jantung per menit (bpm). Normal dewasa: 60-100 bpm.
3. **Laju Pernapasan (Respiratory Rate):** Jumlah napas per menit. Normal dewasa: 12-20 kali per menit.
4. **Suhu Tubuh (Body Temperature):** Tingkat panas tubuh. Suhu tubuh normal dapat berkisar dari 97,8 derajat F (atau Fahrenheit, setara dengan 36,5 derajat C, atau Celsius) hingga 99 derajat F (37,2 derajat C) untuk orang dewasa yang sehat.

Ada 4 tanda-tanda vital utama yang secara rutin dipantau oleh para profesional medis dan penyedia layanan kesehatan meliputi (Christensen & Anderson, 2016; Muttaqin, 2012; Potter & Perry, 2010):

1. Suhu tubuh

Suhu tubuh normal seseorang bervariasi tergantung pada jenis kelamin, aktivitas terkini, konsumsi makanan dan cairan, waktu dalam sehari, dan, pada wanita, tahap siklus menstruasi. Suhu tubuh normal dapat berkisar dari 97,8 derajat F (atau Fahrenheit, setara dengan 36,5 derajat C, atau Celsius) hingga 99 derajat F (37,2 derajat C) untuk orang dewasa yang sehat. Suhu tubuh seseorang dapat diukur dengan salah satu cara berikut:

- a. **Secara oral:** Suhu dapat diukur melalui mulut menggunakan termometer kaca klasik, atau termometer digital modern yang menggunakan probe elektronik untuk mengukur suhu tubuh.

- b. **Secara rektal:** Suhu yang diukur secara rektal (menggunakan termometer kaca atau digital) cenderung 0,5 hingga 0,7 derajat Fahrenheit lebih tinggi daripada saat diukur melalui mulut.
- c. **Ketiak:** Suhu dapat diukur di bawah lengan menggunakan termometer kaca atau digital. Suhu yang diukur dengan cara ini cenderung 0,3 hingga 0,4 derajat Fahrenheit lebih rendah daripada suhu yang diukur melalui mulut.
- d. **Dengan telinga:** Termometer khusus dapat dengan cepat mengukur suhu gendang telinga, yang mencerminkan suhu inti tubuh (suhu organ dalam).
- e. **Melalui kulit:** Termometer khusus dapat dengan cepat mengukur suhu kulit di dahi (Wangdi et al., 2025).

2. Denyut nadi

Denyut nadi adalah pengukuran detak jantung, atau jumlah detak jantung per menit. Saat jantung memompa darah melalui arteri, arteri akan mengembang dan menyempit mengikuti aliran darah. Mengukur denyut nadi tidak hanya mengukur detak jantung, bisa juga mengukur irama jantung dan kekuatan denyut nadi (Wangdi et al., 2025).

Denyut nadi normal untuk orang dewasa sehat berkisar antara 60-100/menit. Denyut nadi dapat berfluktuasi dan meningkat karena olahraga, penyakit, cedera, dan emosi. Wanita berusia 12 tahun ke atas, secara umum, cenderung memiliki detak jantung yang lebih cepat daripada pria. Atlet, seperti pelari, yang banyak melakukan latihan kardiovaskular, mungkin memiliki detak jantung mendekati 40 denyut per menit dan tidak mengalami masalah (Potter & Perry, 2010).

Saat jantung memompa darah melalui arteri, Anda dapat merasakan denyutnya dengan menekan arteri dengan kuat, yang terletak dekat permukaan kulit di titik-titik tertentu pada tubuh. Denyut nadi dapat ditemukan di sisi leher, di bagian dalam siku, atau di pergelangan tangan. Bagi kebanyakan orang, paling mudah untuk memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan. Jika Anda menggunakan bagian bawah leher, pastikan untuk tidak menekan terlalu keras, dan jangan pernah menekan denyut nadi di kedua sisi bagian bawah leher secara bersamaan untuk mencegah penyumbatan aliran darah ke otak. Saat memeriksa denyut nadi, yaitu (Potter & Perry, 2010; Wiseman et al., 2024):

- a. Dengan menggunakan ujung jari pertama dan kedua, tekan dengan kuat namun lembut pada arteri hingga Anda merasakan denyut nadi.
- b. Mulailah menghitung denyut nadi ketika jarum detik jam berada di angka 12.
- c. Hitung denyut nadi Anda selama 60 detik (atau selama 15 detik lalu kalikan empat untuk menghitung denyut per menit).

- d. Saat menghitung, jangan terus-menerus melihat jam, tetapi konsentrasikan perhatian pada denyut nadi.

3. Laju pernapasan (kecepatan bernapas)

Laju pernapasan adalah jumlah napas yang diambil seseorang per menit. Laju ini biasanya diukur saat seseorang sedang beristirahat dan hanya melibatkan penghitungan jumlah napas selama satu menit dengan menghitung berapa kali dada terangkat. Laju pernapasan dapat meningkat saat demam, sakit, dan kondisi medis lainnya. Saat memeriksa pernapasan, penting juga untuk memperhatikan apakah seseorang mengalami kesulitan bernapas. Laju pernapasan normal untuk orang dewasa saat istirahat berkisar antara 12 hingga 16 napas per menit (Black & Hawks, 2014; Muttaqin, 2012; Smeltzer & Bare, 2013).

4. Tekanan darah

Tekanan darah adalah kekuatan darah yang mendorong dinding arteri selama kontraksi dan relaksasi jantung. Setiap kali jantung berdetak, ia memompa darah ke dalam arteri, sehingga tekanan darah tertinggi terjadi saat jantung berkontraksi. Ketika jantung rileks, tekanan darah menurun (DiGiulio et al., 2014; Potter & Perry, 2010).

Dua angka dicatat saat mengukur tekanan darah. Angka yang lebih tinggi, atau tekanan sistolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang lebih rendah, atau tekanan diastolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri saat jantung beristirahat dan terisi darah. Baik tekanan sistolik maupun diastolik dicatat sebagai "mm Hg" (milimeter merkuri). Pencatatan ini menunjukkan seberapa tinggi kolom merkuri dalam alat pengukur tekanan darah manual kuno (disebut manometer merkuri atau sphygmomanometer) terangkat oleh tekanan darah. Saat ini, kantor dokter Anda lebih cenderung menggunakan alat pengukur sederhana berupa jarum penunjuk untuk pengukuran ini (Black & Hawks, 2014; Potter & Perry, 2010).

Tekanan darah tinggi, atau hipertensi, secara langsung meningkatkan risiko serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Dengan tekanan darah tinggi, arteri mungkin memiliki peningkatan resistensi terhadap aliran darah, menyebabkan jantung memompa lebih keras untuk mengedarkan darah (Potter & Perry, 2010).

Tekanan darah dikategorikan sebagai normal, meningkat, atau tekanan darah tinggi stadium 1 atau stadium 2 (Wangdi et al., 2025; Xiong, 2025):

- a. Tekanan darah normal** = sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80 (120/80).

- b. Tekanan darah tinggi** = tekanan sistolik 120 hingga 129 **dan** tekanan diastolik kurang dari 80.
- c. Tekanan darah tinggi stadium 1** = ditandai dengan tekanan sistolik 130 hingga 139 **atau** tekanan diastolik antara 80 hingga 89.
- d. Tekanan darah tinggi stadium 2** = terjadi ketika tekanan sistolik 140 atau lebih tinggi **atau** tekanan diastolik 90 atau lebih tinggi.

American Heart Association (AHA) merekomendasikan pedoman berikut untuk pemantauan tekanan darah di rumah (Potter & Perry, 2010):

- a. Jangan merokok atau minum kopi selama 30 menit sebelum mengukur tekanan darah Anda.
- b. Pergilah ke kamar mandi sebelum tes.
- c. Bersantailah selama 5 menit sebelum melakukan pengukuran.
- d. Duduklah dengan punggung disangga (jangan duduk di sofa atau kursi empuk). Letakkan kaki Anda di lantai dan jangan disilangkan. Letakkan lengan Anda di permukaan datar yang kokoh (seperti meja) dengan bagian atas lengan sejajar dengan jantung. Letakkan bagian tengah manset tepat di atas lekukan siku. Periksa buku panduan monitor untuk ilustrasi.
- e. Lakukan beberapa pengukuran. Saat mengukur, lakukan 2 hingga 3 pengukuran dengan jeda satu menit dan catat semua hasilnya.
- f. Ukur tekanan darah Anda pada waktu yang sama setiap hari, atau sesuai anjuran penyedia layanan kesehatan Anda.
- g. Catat tanggal, waktu, dan hasil pengukuran tekanan darah.
- h. Bawalah catatan tersebut ke janji temu medis Anda berikutnya. Jika alat pengukur tekanan darah Anda memiliki memori internal, cukup bawa alat pengukur tersebut ke janji temu Anda berikutnya.
- i. Hubungi penyedia layanan kesehatan Anda jika Anda mendapatkan beberapa hasil pengukuran tekanan darah tinggi. Jangan takut dengan satu hasil pengukuran tekanan darah tinggi, tetapi jika Anda mendapatkan beberapa hasil pengukuran tinggi, periksakan diri ke penyedia layanan kesehatan Anda.
- j. Jika tekanan darah mencapai sistolik (angka atas) 180 atau lebih tinggi ATAU diastolik (angka bawah) 110 atau lebih tinggi, segera cari pertolongan medis darurat.

C. Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasien (autoanamnesis) atau keluarga (alloanamnesis). Data yang dikaji meliputi (Black & Hawks, 2014; Muttaqin, 2012; Potter & Perry, 2010):

1. Keluhan utama

Keluhan utama adalah alasan utama atau masalah paling mendesak yang menyebabkan pasien mencari pertolongan medis, biasanya berupa gejala fisik atau keluhan subjektif, seperti nyeri, demam, atau sesak napas. Ini merupakan langkah awal krusial dalam anamnesa untuk menentukan diagnosis dan prioritas tindakan perawatan (Potter & Perry, 2010).

2. Riwayat penyakit sekarang

Riwayat Kesehatan Sekarang (RKS) atau *History of Present Illness* (HPI) adalah komponen dalam pengkajian keperawatan/medis yang mendokumentasikan secara rinci mengenai keluhan utama pasien saat ini. RKS memberikan detail kronologis mengenai kapan gejala mulai dirasakan, lokasi, intensitas, serta faktor yang memperberat atau meringankan keluhan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, perawat menggunakan pendekatan mnemonic PQIRST:

- a. P (Provoking/Palliative): Faktor yang memicu (*provoke*) atau meringankan (*palliative*) gejala.
- b. Q (Quality/Quantity): Kualitas atau deskripsi rasa sakit/gejala (misalnya: tajam, tumpul, tertusuk, atau menyebar).
- c. R (Region/Radiation): Lokasi spesifik tubuh yang terasa sakit dan apakah nyeri tersebut menyebar ke area lain.
- d. S (Severity/Scale): Tingkat keparahan atau skala nyeri (misalnya: menggunakan skala 1-10).
- e. T (Timing/Time): Kapan gejala mulai dirasakan, seberapa sering terjadi (frekuensi), dan berapa lama keluhan berlangsung (Muttaqin, 2012; Potter & Perry, 2010; Smeltzer & Bare, 2013).

3. Riwayat penyakit dahulu

Riwayat kesehatan dahulu adalah komponen pengkajian keperawatan/medis yang mencatat data subjektif komprehensif mengenai penyakit masa lalu, pengobatan, alergi, operasi, dan riwayat imunisasi pasien. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi risiko, mendiagnosis penyakit saat ini, dan merencanakan perawatan yang tepat berdasarkan riwayat kesehatan pasien (Black & Hawks, 2014).

4. Riwayat penyakit keluarga

Riwayat penyakit keluarga adalah catatan medis sistematis mengenai kondisi kesehatan, penyakit genetik, dan kebiasaan hidup kerabat dekat (tiga

generasi: orang tua, saudara, kakek-nenek, paman/bibi). Ini merupakan alat diagnostik penting untuk mengidentifikasi risiko penyakit (seperti kanker, diabetes, hipertensi, jantung) yang diturunkan, memprediksi onset awal, dan memungkinkan tindakan pencegahan sejak dini (Potter & Perry, 2010).

5. Riwayat alergi

Teori riwayat alergi dalam dunia medis menjelaskan bagaimana seseorang menjadi sensitif dan bereaksi berlebihan terhadap zat-zat tertentu (alergen) di lingkungan. Alergi tidak terjadi secara spontan, melainkan hasil dari kombinasi **faktor genetik (keturunan)** dan **faktor lingkungan (paparan)** yang memicu respons imun (Black & Hawks, 2014; Smeltzer & Bare, 2013).

6. Riwayat pengobatan

Teori riwayat pengobatan (*medication history*) adalah proses sistematis untuk mendapatkan informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini mengenai seluruh obat—baik resep, non-resep (bebas), suplemen, maupun obat herbal—yang pernah dan sedang dikonsumsi oleh pasien. Tujuan utama dari riwayat pengobatan adalah meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*) dengan mencegah kesalahan pengobatan (*medication errors*) saat transisi perawatan (misalnya masuk rumah sakit atau keluar rumah sakit) (Muttaqin, 2012; Potter & Perry, 2010).

D. Observasi Dasar

Observasi dalam dasar keperawatan adalah proses pengumpulan data secara sadar, sistematis, dan disengaja menggunakan pancaindra (penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan) untuk memantau perilaku, keadaan fisik, dan lingkungan pasien guna mengidentifikasi masalah kesehatan. Observasi adalah komponen krusial dalam tahap pengkajian keperawatan (DiGiulio et al., 2014). Observasi dasar dilakukan dengan melihat dan menilai kondisi umum pasien secara langsung, meliputi (Potter & Perry, 2010; Price & Wilson, 2011; Smeltzer & Bare, 2013):

1. Keadaan umum

Teori keadaan umum dalam medis adalah penilaian subjektif dan objektif secara cepat mengenai kemampuan pasien merespon lingkungan, kesadaran, serta kondisi fisik secara keseluruhan. Kriteria utamanya meliputi tingkat kesadaran (kompos mentis hingga koma) dan respons fisik (baik, lemah, atau berat) (Potter & Perry, 2010; Price & Wilson, 2011):

- a. Pengkajian Kemampuan Merespon: Menilai seberapa baik pasien merespon lingkungan sekitarnya. Keadaan umum baik ditandai dengan respon positif dan tidak ada ketergantungan fisik, sedangkan keadaan lemah ditandai dengan kurangnya respon dan keterbatasan mobilitas (Smeltzer & Bare, 2013).
- b. Pemeriksaan Fisik (Inspeksi): Bagian dari pemeriksaan fisik dasar (inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi) yang memberikan gambaran awal kesehatan pasien sebelum pemeriksaan lebih spesifik (Black & Hawks, 2014).

2. Tingkat kesadaran

Nilai tingkat kesadaran diukur menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) dengan rentang skor 3 (koma/terendah) hingga 15 (sadar penuh/tertinggi). Penilaian didasarkan pada respons mata (1-4), verbal (1-5), dan motorik (1-6). Skor 13-15 menunjukkan cedera ringan, 9-12 sedang, dan 3-8 berat/koma (DiGiulio et al., 2014; Potter & Perry, 2010; Price & Wilson, 2011).

- a. **Composmentis**: Sadar sepenuhnya, responsif.
- b. **Apatis**: Segan/acuh tak acuh.
- c. **Somnolen**: Mengantuk, mudah dibangunkan.
- d. **Delirium**: Kacau motorik, berteriak, disorientasi.
- e. **Semikoma**: Reaksi hanya pada rangsang nyeri.
- f. **Koma**: Tidak sadar sama sekali, tidak ada respon.

Nilai GCS dapat dinilai dengan rentang nilai sebagai berikut (Potter & Perry, 2010):

- a. **Compos Mentis (Sadar Penuh)**: GCS 14-15.
- b. **Apatis (Acuh tak acuh)**: GCS 12-13.
- c. **Delirium (Gelisah/Disorientasi)**: GCS 10-11.
- d. **Somnolen (Mengantuk/Mudah dibangunkan)**: GCS 7-9.
- e. **Sopor (Mengantuk berat/Hanya respon nyeri)**: GCS 5-6.
- f. **Semi Koma (Respon nyeri lemah)**: GCS 4.
- g. **Koma (Tidak ada respon)**: GCS 3.

Komponen Penilaian GCS (Black & Hawks, 2014; Potter & Perry, 2010; Smeltzer & Bare, 2013):

- a. **Respon Mata (Eye - E)**: Spontan (4), Terhadap Suara (3), Terhadap Nyeri (2), Tidak Ada (1).
- b. **Respon Verbal (Verbal - V)**: Orientasi Baik (5), Bingung (4), Kata-kata tidak tepat (3), Suara tidak jelas/mengerang (2), Tidak Ada (1).

- c. **Respon Motorik (Motor - M):** Mengikuti perintah (6), Melokalisir nyeri (5), Menghindar nyeri/fleksi (4), Fleksi Abnormal/Dekortikasi (3), Ekstensi Abnormal/Deserebrasi (2), Tidak Ada (1).

3. Warna kulit

Pengkajian warna kulit bertujuan menilai vaskularisasi, oksigenasi, dan pigmen, dilakukan di bawah pencahayaan alami/terang dengan inspeksi menyeluruh. Pemeriksaan fokus pada perubahan warna (pucat, sianosis, ikterus, eritema), keseragaman pigmen, dan keberadaan lesi, terutama pada area terpapar matahari atau kuku. Warna normal bervariasi sesuai etnis. Berikut adalah poin-poin penting dalam pengkajian warna kulit (Black & Hawks, 2014; DiGiulio et al., 2014; Potter & Perry, 2010; Price & Wilson, 2011):

- a. **Pemeriksaan Dasar:** Perhatikan warna dasar kulit, kelembapan, suhu, dan turgor.
- b. **Variasi Warna Abnormal:**
- **Pucat (Pallor):** Menandakan kurangnya aliran darah atau anemia (tampak putih/abu-abu pada kulit gelap, putih pucat pada kulit terang).
 - **Sianosis (Kebiruan):** Menandakan kurangnya oksigenasi, sering dicek pada kuku, bibir, atau mukosa mulut.
 - **Ikterus/Jaundice (Kuning):** Menandakan penyakit hati, paling jelas di sklera dan kulit.
 - **Eritema (Kemerahan):** Menandakan peradangan, infeksi, atau peningkatan sirkulasi darah.
 - **Hiperpigmentasi/Hipopigmentasi:** Bercak gelap atau terang yang tidak merata.
- c. **Pengkajian Kulit Gelap:** Peningkatan melanin memberikan perlindungan UV lebih tinggi, namun menyulitkan deteksi infeksi/eritema. Gunakan perabaan (suhu/nyeri) untuk membantu.
- d. **Teknik Tambahan:**
- **Pengisian Kapiler (Capillary Refill):** Normalnya kembali dalam <3 detik.
 - **Skala Fitzpatrick:** Sering digunakan untuk mengklasifikasikan respons kulit terhadap sinar matahari.

4. Postur dan pergerakan

Pengkajian postur dan pergerakan adalah proses evaluasi sistematis terhadap sikap tubuh (statis) dan pola gerakan (dinamis) seseorang untuk mengidentifikasi ketidaksejajaran, keterbatasan fungsional, atau risiko cedera musculoskeletal. Pengkajian ini penting untuk mendeteksi dini gangguan

muskuloskeletal (MSDs), terutama pada pekerja yang melakukan gerakan berulang atau beban manual (Potter & Perry, 2010).

5. Kebersihan diri

Pengkajian personal hygiene merupakan proses sistematis mengevaluasi kemampuan pasien dalam merawat dirinya sendiri seperti mandi, oral hygiene, rambut, kuku, dan berpakaian), serta kondisi kebersihan tubuh secara umum untuk mencegah infeksi dan meningkatkan kesejahteraan fisik/psikologis. Pengkajian mencakup riwayat kebiasaan, pemeriksaan fisik terfokus dan tingkat kemandirian pasien (Black & Hawks, 2014; Potter & Perry, 2010; Smeltzer & Bare, 2013).

6. Ekspresi wajah dan respons terhadap lingkungan

Pengkajian ekspresi wajah dan respons terhadap lingkungan merupakan komponen krusial dalam pemeriksaan status mental dan keperawatan holistik untuk menilai kondisi emosional, kognitif, dan neurologis pasien. Pengkajian ini umumnya dilakukan melalui observasi langsung (windshield survey/observasi perilaku) dan wawancara. Berikut adalah panduan pengkajian ekspresi wajah dan respons lingkungan (Black & Hawks, 2014; Potter & Perry, 2010; Smeltzer & Bare, 2013):

- a. Pengkajian Ekspresi Wajah (Afek) : Ekspresi wajah memberikan petunjuk tentang suasana perasaan (*mood*) dan afek (ekspresi emosi yang terlihat) pasien.
- b. Ketepatan (Appropriateness): Apakah ekspresi wajah sesuai dengan situasi atau apa yang diceritakan? (Contoh: tertawa saat menceritakan hal sedih menandakan afek tidak sesuai).
- c. Intensitas: Apakah ekspresi emosi tumpul (*blunted*), datar (*flat*), atau berlebihan?.
- d. Konsistensi: Apakah ekspresi wajah berubah-ubah sesuai topik atau kaku?
- e. Jenis Ekspresi: Amati adanya tanda kecemasan, depresi, ketakutan, amarah, kesedihan, atau kegembiraan.
- f. Karakteristik Fisik: Amati ketegangan otot wajah (misalnya, dahi berkerut, rahang terkutup), atau adanya tanda nyeri seperti menyeringai.
- g. Kasus Khusus: Pada pasien demensia atau gangguan jiwa berat, seringkali terjadi penurunan ekspresi wajah spontan.

7. Pengkajian Respons terhadap Lingkungan

Respons lingkungan menilai kemampuan pasien berinteraksi dengan dunia di sekitarnya dan beradaptasi dengan stressor (DiGiulio et al., 2014; Potter & Perry, 2010; Smeltzer & Bare, 2013; Stuart, 2016).

- a. Kontak Mata: Apakah pasien melakukan kontak mata yang wajar, menghindari, atau menatap tajam?
- b. Perhatian/Atensi: Apakah pasien menyadari kehadiran perawat atau rangsangan di sekitarnya? (Contoh: sadar saat dipanggil, melihat ke arah suara).
- c. Reaksi terhadap Stimulus: Bagaimana respons pasien terhadap stimulus visual atau auditori? (Contoh: mondar-mandir tegang vs. tenang, acuh tak acuh vs. sangat ketakutan).
- d. Orientasi: Apakah pasien berorientasi pada waktu, tempat, dan orang di sekitarnya?
- e. Interaksi Sosial: Apakah pasien menarik diri (isolasi sosial), agresif, atau kooperatif?

E. Simpulan

Pengkajian pasien secara sederhana mencakup pemeriksaan vital sign, penggalian riwayat kesehatan, dan observasi dasar. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pengkajian yang dilakukan secara sistematis dan akurat akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien.

F. Referensi

- Alsadaan, N. (2026). *Effects of a nurse-led mindfulness-based intervention on stress and emotional well-being in hospitalized school-aged children: a mixed-methods quasi-experimental study*.
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Keperawatan medikal bedah: Manajemen klinis untuk hasil yang diharapkan* (8th ed.). Jakarta, Indonesia: Pentasada Media Edukasi.
- Christensen, V., & Anderson, J. (2016). *Evidence-based Synthesis Program Technology Assessment: EarlySense for Monitoring Vital Signs in Hospitalized Patients*.
- DiGiulio, M., Jackson, D., & Keogh, J. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah*. Yogyakarta, Indonesia: Rapha Publishing.

- Muttaqin, A. . (2012). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Pernafasan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2010). *Buku ajar fundamental keperawatan: Konsep proses, dan praktik* (4th ed.). Jakarta, Indonesia: EGC.
- Price, S. ., & Wilson, L. . (2011). *Konsep Klinis Proses - Proses Penyakit* (6th ed.). Jakarta: EGC.
- Sarangi. (2012). *Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal* (12th ed.). Jakarta, Indonesia: EGC.
- Stuart, G. . (2016). *Prinsip Dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Singapore: Elsevier.
- Wangdi, S., Guragai, K., Namgay, P., & Dorji, J. (2025). *Improving initial vital signs assessment and documentation in the emergency department of regional hospital , Bhutan: quality improvement project*. 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmj-2024-003151>
- Wiseman, T., Kennedy, B., Kourouche, S., & Curtis, K. (2024). *The impact of whole of patient nursing assessment frameworks on hospital inpatients: A scoping literature review*. November 2023, 3448–3463. <https://doi.org/10.1111/jan.16025>
- Xiong, B. (2025). *Patient Experiences of Hospital Care in the Context of Comprehensive Care Delivery: A Mixed Method Study*. 6907–6923. <https://doi.org/10.1111/jan.16826>

CHAPTER 3

DIAGNOSA KEPERAWATAN UMUM YANG SERING MUNCUL DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER DAN RS

Asni Hasaini

A. Konsep Diagnosis Keperawatan

1. Definisi Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan komponen mendasar dalam perumusan strategi terapi yang sesuai yang bertujuan untuk mencapai keadaan kesehatan yang optimal . Ini berfungsi sebagai dasar untuk pemilihan rencana aksi keperawatan, yang merupakan tanggung jawab yang melekat pada profesi keperawatan (diratifikasi pada Konferensi NANDA Kesembilan; direvisi pada 2009, 2013, 2019, dan 2023). Selanjutnya, diagnosis keperawatan juga dapat dikonseptualisasikan sebagai evaluasi klinis yang dirancang untuk mengidentifikasi tanggapan klien, apakah itu berkaitan dengan individu, keluarga, atau komunitas, terhadap tantangan terkait kesehatan atau perjalanan hidup yang dihadapi, apakah tantangan ini aktual atau potensial (Tim Pokja PPNI, 2017).

SDKI mewakili standar diagnostik yang memfasilitasi pengambilan keputusan klinis dalam domain keperawatan, menekankan faktor-faktor seperti keramahan pengguna, kejelasan dalam penalaran diagnostik, kelengkapan kategori diagnostik, serta kepatuhan terhadap standar bahasa (Nurhesti et al., n.d.). Selain itu, SDKI adalah standar diagnosis keperawatan yang dikembangkan oleh PPNI, yang menggabungkan diagnosis keperawatan berdasarkan kerangka kerja NANDA, ICNP, dan Carpenito. SDKI terdiri dari 148 diagnosis keperawatan yang selaras dengan label diagnostik NANDA. Selain itu, SDKI mewujudkan pendekatan inovatif oleh perawat Indonesia untuk menerapkan perawatan keperawatan praktis yang sesuai dengan budaya lokal, konteks situasional, dan kondisi yang berlaku di Indonesia. Perawat diantisipasi untuk memberikan perawatan komprehensif kepada klien, terlepas dari status kesehatan mereka, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Respons klien bermanifestasi sebagai reaksi mereka terhadap tantangan kesehatan dan lintasan kehidupan (NANDA Internasional, 2024).

Masalah yang berhubungan dengan kesehatan berkaitan dengan respons klien terhadap fenomena kesehatan dan penyakit, sementara proses kehidupan mencakup kontinum dari konsepsi, kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, hingga fase akhir hidup dan mati, yang semuanya memerlukan diagnosis keperawatan dan dapat ditangani atau dimodifikasi melalui intervensi keperawatan yang ditargetkan (Christensen & Kenney, 2009; Seaback, 2009) dalam (Polopadang & Hidayah, 2019; Sulistyawati & Hilfida, 2025). Metodologi ini memastikan bahwa perawat memberikan perawatan holistik yang berpusat pada pasien yang selaras dengan dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu. Diagnosis keperawatan secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis perawat, dengan praktik pencatatan yang digunakan oleh perawat untuk secara sistematis mengkomunikasikan hasil analisis dan penilaian data dalam format standar (Fahrurozi & Kurniawan, 2021).

Praktik ini mempromosikan komunikasi yang efektif di antara para profesional kesehatan. Penerapan terminologi standar sangat penting untuk pemahaman kolektif tentang tantangan keperawatan dan strategi perawatan pasien di seluruh tim interdisipliner (Polopadang & Hidayah, 2019). Selain itu, pemanfaatan terminologi standar dan kode mendukung inisiatif penelitian dengan memfasilitasi studi tentang respons pasien yang mempertahankan definisi dan indikator diagnostik yang konsisten di berbagai pengaturan, lingkungan perawatan, dan negara (Sumarni & Dkk, 2022). Diagnosis keperawatan berfungsi sebagai elemen dasar dalam identifikasi intervensi keperawatan yang diperlukan untuk pencapaian hasil yang diantisipasi (Hasan & Mulyanto, 2022). Sementara sebagian besar individu berkenalan dengan diagnosis medis, yang melibatkan identifikasi penyakit, gangguan kesehatan, atau cedera berdasarkan tanda dan gejala yang dapat diamati yang dialami oleh pasien (Paulina & Dkk, 2024), banyak yang tetap tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa perawat juga terlibat dalam proses diagnostik, meskipun dengan fokus yang berbeda dari diagnosis medis.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan diagnosis keperawatan yang tepat menghasilkan prediktabilitas yang unggul dalam dimensi kritis, seperti durasi perawatan dan tingkat penerimaan kembali ke rumah sakit, dibandingkan dengan ketergantungan semata-mata pada diagnosis medis (Ackley et al., 2017; Agostino et al., 2018; Sanson et al., 2019; Zeffiro et al., 2020). Perawat memenuhi peran penting dalam menjaga keselamatan pasien, memberikan pendidikan kesehatan, meningkatkan kemampuan pasien untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat, dan secara empatik terlibat dengan pengalaman khas klien (Ackley et al., 2017). SDKI dengan demikian berfungsi

sebagai referensi penting dalam perumusan diagnosis yang akurat, serta dalam mendukung penerapan intervensi keperawatan yang sesuai untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan.

Penentuan diagnosis keperawatan yang salah dapat secara signifikan mempengaruhi kemungkinan ketidakakuratan selama persiapan dan pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan oleh mahasiswa keperawatan. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan komplikasi dalam mencapai hasil yang menguntungkan dalam perawatan pasien. Strategi yang layak untuk mengurangi risiko kesalahan diagnostik dalam keperawatan memerlukan kebutuhan bagi siswa untuk dididik dalam memanfaatkan beragam sumber daya untuk merumuskan diagnosis yang akurat (NANDA Internasional, 2024). Di antara metodologi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakakuratan diagnostik adalah penerapan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia bersama teks Diagnosis Keperawatan yang otoritatif, karena kesalahan diagnosis sering muncul dari sumber data yang tidak dapat diandalkan (Hasan & Mulyanto, 2022).

2. Tujuan Diagnosis Keperawatan

Tujuan dari diagnosis keperawatan menurut (Fahrurrozi & Kurniawan, 2021; Hasan & Mulyanto, 2022) adalah sebagai berikut :

- a. memungkinkan perawat untuk menganalisis dan mensintesis data yang telah dikelompokkan dalam pola kesehatan,
- b. untuk mengidentifikasi masalah, faktor penyebab masalah, kemampuan klien untuk dapat mencegah atau memecahkan masalah
- c. untuk mengidentifikasi respons klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan

3. Komponen Diagnosis Keperawatan

Komponen-komponen dalam pernyataan diagnosis keperawatan menurut Asmadi (2008) dalam (Polopadang & Hidayah, 2019), meliputi masalah (*problem*), penyebab (*etiology*), dan data (sign and *symptom*). Untuk memudahkan biasanya disingkat dengan kata PES.

- a. Masalah (*problem*) Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan yang menggambarkan perubahan status kesehatan pasien. Perubahan status tersebut menyebabkan timbulnya masalah.
- b. Penyebab (*etiology*) Pernyataan etiologi mencerminkan penyebab dari masalah kesehatan pasien yang memberi arah bagi intervensi keperawatan. Etiologi tersebut dapat terkait dengan aspek patofisiologis, psikososial, tingkah laku, perubahan situasional gaya hidup, usia perkembangan, juga

faktor budaya dan lingkungan. Frase “berhubungan dengan” (*related to*) berfungsi untuk menghubungkan masalah keperawatan dengan pernyataan etiologi.

c. Data (*sign and symptom*)

Data diperoleh selama tahap pengkajian sebagai bukti adanya masalah kesehatan pada pasien. Data merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Penggunaan frase “ditandai oleh” menghubungkan etiologi dengan data.

4. Klasifikasi Diagnosis Keperawatan berdasarkan SDKI

Sistem klasifikasi *International Classification for Nursing Practice* (ICNP) lebih komprehensif daripada sekadar diagnosis keperawatan, yang mencakup tiga aspek utama dalam praktik keperawatan diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam ICNP, diagnosis keperawatan dikelompokkan menjadi lima kategori utama menurut (Tim Pokja PPNI, 2017), yakni :

- a. Fisiologis, berkaitan dengan pernapasan, sirkulasi darah, nutrisi, kebutuhan cairan elektrolit, dan seterusnya
- b. Psikologis, berkaitan dengan kenyamanan, rasa sakit, pertumbuhan dan juga perkembangan
- c. Perilaku, berkaitan dengan kebersihan individu, kebiasaan, edukasi dan informasi
- d. Relasional, berkaitan dengan hubungan sosial dengan orang lain
- e. Lingkungan, berkaitan dengan keamanan dan proteksi

Klasifikasi tersebut membantu perawat dalam memahami dan menangani berbagai kebutuhan klien dengan lebih baik.

5. Jenis Diagnosis Keperawatan

Terdapat dua jenis diagnosis keperawatan, yakni (Carpenito, 2013)

a. Diagnosis negatif

Menjadi acuan dalam memberikan intervensi keperawatan yang memiliki tujuan menyembuhkan, memulihkan, atau mencegah penyakit. Terdapat dua jenis diagnosis negatif, yaitu:

- 1) Diagnosis aktual, mencerminkan masalah isu kesehatan yang dihadapi klien saat ini, dengan adanya tanda-tanda atau gejala utama yang dikenali dan divalidasi.

- 2) Diagnosis risiko, menggambarkan potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada klien karena adanya faktor risiko, meskipun belum ada tanda-tanda atau gejala yang muncul
- b. Diagnosis positif
Diagnosis ini dikenal dengan diagnosis promosi kesehatan yang menunjukkan keinginan dan motivasi klien dalam meningkatkan kondisi kesehatannya (Tim Pokja PPNI, 2017).

B. Diagnosis Keperawatan Umum di Rumah Sakit

Diagnosis keperawatan yang umum dan sering muncul di Rumah Sakit dalam buku ini berdasarkan kategori dan subkategori diagnosis keperawatan pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Adapun diagnosis keperawatan umum di Rumah Sakit diuraikan sebagai berikut (Tim Pokja PPNI, 2017):

1. Kategori Fisiologis

- a. Subkategori Respirasi

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif (D.0001)

Definisi

Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.

Penyebab

Fisiologis

- 1) Spasme jalan napas
- 2) Hipersekresi jalan napas
- 3) Disfungsi neuromuskuler
- 4) Benda asing dalam jalan napas
- 5) Adanya jalan napas buatan
- 6) Sekresi tertahan
- 7) Hiperplasia dinding jalan napas
- 8) Proses infeksi
- 9) Respon alergi
- 10) Efek agen farmakologis (mis.anastesi)

Situasional

- 1) Merokok aktif
- 2) Merokok pasif
- 3) Terpajan polutan

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

(tidak tersedia)

Objektif

- 1) Batuk tidak efektif
- 2) Tidak mampu Batuk
- 3) Sputum berlebih
- 4) Mengi, *wheezing* dan/atau ronkhi kering
- 5) Mekonium di jalan napas (pada neonatus)

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- 1) Dispnea
- 2) Sulit bicara
- 3) Ortopnea

Objektif

- 1) Gelisah
- 2) Sianosis
- 3) Bunyi napas menurun
- 4) Frekuensi napas berubah
- 5) Pola napas berubah

Kondisi Klinis Terkait

- 1) *Gullian barre syndrome*
- 2) Sklerosis multipel
- 3) *Myasthenia gravis*
- 4) Prosedur diagnostic (mis. Bronkospi, *transesophageal, echocardiography [TEE]*)
- 5) Depresi sites saraf pusat
- 6) Cedera kepala
- 7) Stroke
- 8) Sindrom aspirasi mekonium
- 9) Infeksi saluran nafas

b. Subkategori Sirkulasi

Penurunan Curah Jantung (D.0008)

Definisi

Ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh

Penyebab

- 1) Penurunan irama jantung

- 2) Perubahan frekuensi jantung
- 3) Perubahan kontraktilitas
- 4) Perubahan *preload*
- 5) Perubahan *afterload*

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- 1) Perubahan irama jantung (palpitasi)
- 2) Perubahan *preload* (lelah)
- 3) Perubahan *afterload* (*dyspnea*)
- 4) Perubahan kontraktilitas (*Paroxysmal nocturnal dyspnea/ PND*), *ortopnea*, batuk)

Objektif

- 1) Perubahan irama jantung
 - a) Brakardia/ takikardia
 - b) Gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi
- 2) Perubahan *preload*
 - a) Edema
 - b) Distensi vena jugularis
 - c) Central venous pressure
 - d) Hepatomegali
- 3) Perubahan *afterload*
 - a) Tekanan darah meningkat/ menurun
 - b) Nadi perifer teraba lemah
 - c) Capillary refill time >3detik
 - d) Oliguria
 - e) Warna kulit pucat dan/atau sianosis
- 4) Perubahan kontraktilitas
 - a) Terdengar suara jantung S3 dan/atau S4
 - b) Ejection fraction (EF) menurun

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- 1) Perubahan *preload* (tidak tersedia)
- 2) Perubahan *afterload* (tidak tersedia)
- 3) Perubahan kontraktilitas (tidak tersedia)
- 4) Perilaku/ emosional (cemas dan gelisah)

Objektif

- 1) Perubahan *preload*
 - a) Murmur jantung

- b) Berat badan bertambah
 - c) *Pulmonary artery wedge pressure* (PAWP) menurun
- 2) Perubahan afterload
 - a) *Pulmonary vascular resistance* (PVR) menurun/ meningkat
 - b) *Systematic vascular resistance* (SVR) menurun/ meningkat
- 3) Perubahan kontraktilitas
 - a) *Cardiac index* (CI) menurun
 - b) *Left ventricular stroke work index* (LVSWI) menurun
 - c) *Stroke volume index* (SVI) menurun
- 4) Perilaku/ emosional (tidak tersedia)

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Gagal jantung kongestif
- 2) Sindrom koroner akut
- 3) Stenosis mitral
- 4) Regurgitasi mitral
- 5) Stenosis aorta
- 6) Regurgitasi aorta
- 7) Stenosis trikuspidal
- 8) Regurgitasi trikuspidal
- 9) Stenosis pulmonal
- 10) Regurgitasi pulmonal
- 11) Aritmia
- 12) Penyakit jantung bawaan

c. Subkategori Nutrisi dan Cairan

Defisit nutrisi (D.0019)

Definisi

Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme

Penyebab

- 1) Ketidakmampuan menelan makanan
- 2) Ketidakmampuan mencerna makanan
- 3) Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi
- 4) Peningkatan kebutuhan metabolisme
- 5) Faktor ekonomi (mis. finansial tidak mencukupi)
- 6) Faktor psikologis (mis. stress, keengganan untuk makan)

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- 1) Beban badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal

Gejala dan Tanda Minor**Subjektif**

- 1) Cepat kenyang setelah makan
- 2) Kram/ nyeri abdomen
- 3) Nafsu makan menurun

Objektif

- 1) Bising usus hiperaktif
- 2) Otot pengunyah lemah
- 3) Otot menelan lemah
- 4) Membrane mukosa pucat
- 5) Sariawan
- 6) Serum albumin turun
- 7) Rambut rontok berlebihan
- 8) Diare

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Stroke
- 2) Parkinson
- 3) *Mobius syndrome*
- 4) *Cerebral palsy*
- 5) *Cleft lip*
- 6) *Cleft palate*
- 7) *Amyotrophic lateral sclerosis*
- 8) Kerusakan neuromuscular
- 9) Luka bakar
- 10) Kanker
- 11) Infeksi
- 12) AIDS
- 13) Penyakit Crohn's
- 14) Enterokolitis
- 15) Fibrosis kistik

d. Subkategori Eliminasi**Gangguan Eliminasi Urin (D.0040)****Definisi**

Disfungsi eliminasi urin

Penyebab

1. Penurunan kapasitas kandung kemih
2. Iritasi kandung kemih
3. Penurunan kemampuan menyadari tanda-tanda gangguan kandung kemih
4. Efek tindakan medis dan diagnostic (mis. operasi ginjal, operasi sauran kemih, anestesi dan obat-obatan)
5. Kelemahan otot pelvis
6. Ketidakmampuan mengakses toilet (mis. immobilisasi)
7. Hambatan lingkungan
8. Ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan eliminasi
9. Outlet kandung kemih tidak lengkap (mis. anomali saluran kemih kongenital)
10. Imaturitas (pada anak usia <3 tahun)

Gejala dan Tanda Mayor**Subjektif**

1. Desakan berkemih (urgensi)
2. Urin menetes (dribbling)
3. Sering buang air kecil
4. Nokturia
5. Mengompol
6. Enuresis

Objektif

1. Distensi kandung kemih
2. Berkemih tidak tuntas (*heritancy*)
3. Volume residu urin meningkat

Gejala dan Tanda Minor**Subjektif**

(Tidak tersedia)

Objektif

(Tidak tersedia)

Kondisi Klinis Terkait

1. Infeksi ginjal dan saluran kemih
2. Hiperglikemia
3. Trauma
4. Kanker
5. Cedera//tumor/infeksi medulla spinalis
6. Neuropati diabetikum

7. Neuropati alkoholik
 8. Stroke
 9. Parkinson
 10. Skeloris multiple
 11. Obat alpha adrenergik
- e. Subkategori Aktivitas dan Istirahat
- Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)***

Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ektremitas secara mandiri.

Penyebab

- 1) Kerusakan integritas struktur tulang
- 2) Perubahan metabolisme
- 3) Ketidakbugaran fisik
- 4) Penurunan kendali otot
- 5) Penurunan massa otot
- 6) Penurunan kekuatan otot
- 7) Keterlambatan perkembangan
- 8) Kekakuan sendi
- 9) Kontraktur
- 10) Malnutrisi
- 11) Gangguan muskuluskeletal
- 12) Indeks massa tubuh di atas persentil ke-75 sesuai usia
- 13) Efek agen farmakologis
- 14) Program pembatasan gerak
- 15) Nyeri
- 16) Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
- 17) Kecemasan
- 18) Gangguan kognitif
- 19) Keengganan melakukan pergerakan
- 20) Gangguan sensoripresepsi

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- 1) Mengeluh sulit menggerakkan ektremitas

Objektif

- 1) Kekuatan otot menurun
- 2) Rentang gerak (ROM) menurun

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- 1) Nyeri saat bergerak
- 2) Enggan melakukan pergerakan
- 3) Merasa cemas saat bergerak

Objektif

- 1) Sendi kaku
- 2) Gerakan tidak terkoordinasi
- 3) Gerakan terbatas
- 4) Fisik lemah

Kondisi Klinik Terkait

- 1) Stroke
- 2) Cedera medulla spinalis
- 3) Trauma
- 4) Fraktur
- 5) Osteoarthritis
- 6) Osteomalasia
- 7) Keganasan

f. Subkategori Neurosensori

Risiko Disfungsi Neurovaskuler Perifer (D.0067)**Definisi**

Berisiko mengalami gangguan sirkulasi, sensasi dan pergerakan pada ekstremitas

Faktor Risiko

- 1) Hiperglikemia
- 2) Obstruksi vaskuler
- 3) Fraktur
- 4) Imobilisasi
- 5) Penekanan mekanis (mis. torniket, gips, balutan, restrain)
- 6) Pembedahan ortopedi
- 7) Trauma
- 8) Luka bakar

Kondisi Klinik Terkait

- 1) Diabetes mellitus
- 2) Obstruksi vaskuler
- 3) Fraktur
- 4) Pembedahan ortopedi
- 5) Trauma

6) Luka bakar

g. Subkategori Reproduksi dan Seksualitas

Kesiapan Persalinan (D.0070)

Definisi

Pola mempersiapkan, mempertahankan dan memperkuat proses kehamilan dan persalinan serta perawatan bayi baru lahir.

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- 1) Menanyakan keinginan untuk menerapkan gaya hidup yang tepat untuk persalinan
- 2) Menyatakan keinginan untuk menerapkan penatalaksanaan gejala ketidaknyamanan selama persalinan
- 3) Menyatakan rasa percaya diri menjasi persalinan

Objektif

(Tidak tersedia)

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- 1) Menunjukkan perilaku proaktif selama persiapan persalinan

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Status kesehatan ibu sehat
- 2) Status kesehatan janin sehat

2. Kategori Psikologis

a. Subkategori Nyeri dan Kenyamanan

Gangguan Rasa Nyaman (D.0074)

Definisi

Perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan dan social. Diagnosis ini ditegakkan apabila rasa tidak nyaman muncul tanpa ada cedera jaringan.

Penyebab

- 1) Gejala penyakit
- 2) Kurang pengendalian situasional/ lingkungan
- 3) Ketidakadekuatan sumber daya (mis. dukungan finansial, social, dan pengetahuan)
- 4) Kurangnya privasi

- 5) Gangguan stimulus lingkungan
- 6) Efek samping terapi (mis. medikasi, radiasi, kemoterapi)
- 7) Gangguan adaptasi kehamilan

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Mengeluh tidak nyaman

Objektif

Gelisah

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- 1) Mengeluh sulit tidur
- 2) Tidak mampu rileks
- 3) Mengeluh kedinginan/ kepanasan
- 4) Merasa gatal
- 5) Mengeluh mual
- 6) Mengeluh lelah

Objektif

- 1) Menunjukkan gejala distress
- 2) Tampak merintih/ menangis
- 3) Pola eliminasi berubah
- 4) Postur tubuh berubah
- 5) iritabilitas

Kondisi Klinis Terkait

- 1) penyakit kronis
- 2) keganasan
- 3) distress psikologis
- 4) kehamilan

b. Subkategori Integritas Ego

Ansietas (D.0080)

Definisi

Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat ansietas bahaya yang memungkinkan individu melakukan individu melakukan untuk menghadapi ancaman.

Penyebab

- 1) Krisis situasional
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi
- 3) Krisis maturasi

- 4) Ancaman terhadap konsep diri
- 5) Ancaman terhadap kematian
- 6) Kekhawatiran mengalami kegagalan
- 7) Disfungsi sistem keluarga
- 8) Hubungan orang tua-anak tidak memuaskan
- 9) Faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir)
- 10) Penyalahgunaan zat
- 11) Terpapar bahaya lingkungan (mis. toksin, polutan, dan lain-lain)
- 12) Kurang terpapar informasi

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- 1) Merasa bingung
- 2) Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi
- 3) Sulit konsentrasi

Objektif

- 1) Tampak gelisah
- 2) Tampak tegang
- 3) Sulit tidur

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- 1) Mengeluh pusing
- 2) Anoreksia
- 3) Palpitasi
- 4) Merasa tidak berdaya

Objektif

- 1) Frekuensi napas meningkat
- 2) Frekuensi nadi meningkat
- 3) Tekanan darah meningkat
- 4) Diaphoresis
- 5) Tremor
- 6) Muka tampak pucat
- 7) Suara bergetar
- 8) Kontak mata buruk
- 9) Sering berkemih
- 10) Berorientasi pada masa lalu

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Penyakit kronis progresif (mis. kanker, penyakit autoimun)
- 2) Penyakit akut

- 3) Hospitalisasi
- 4) Rencana operasi
- 5) Kondisi diagnosis penyakit belum jelas
- 6) Penyakit neurologis
- 7) Tahap tumbuh kembang

c. Subkategori Pertumbuhan dan Perkembangan

Gangguan Tumbuh Kembang (D.0106)

Definisi

Kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usianya.

Penyebab

- 1) Efek ketidakmampuan fisik
- 2) Keterbatasan lingkungan
- 3) Inkonsistensi respon
- 4) Pengabaian
- 5) Terpisah dari orang tua dan/atau orang terdekat
- 6) Defisiensi stimulus

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- 1) Tidak mampu melakukan keterampilan atau khas sesuai usia (fisik, bahasa, motorikm psikososial)
- 2) Pertumbuhan fisik terganggu

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- 1) Tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia
- 2) Afek datar
- 3) Respon social lambat
- 4) Kontak mata terbatas
- 5) Nafsu makan menurun
- 6) Lesu
- 7) Mudah marah
- 8) Regresi
- 9) Pola tidur terganggu (pada bayi)

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Hipotiroidisme
- 2) Sindrom gagal tumbuh
- 3) Leukemia
- 4) Defisiensi hormone pertumbuhan
- 5) Demensia
- 6) Delirium
- 7) Kelainan jantung bawaan
- 8) Penyakit kronis
- 9) Gangguan kepribadian

3. Kategori Perilaku

- a. Subkategori Kebersihan Diri

Defisit Perawatan Diri (D.0109)

Definisi

Tidak mampu melakukan atau menyesuaikan aktivitas perawatan diri.

Penyebab

- 1) Gangguan muskuluskeletal
- 2) Gangguan neuromuscular
- 3) Kelemahan
- 4) Gangguan psikologis
- 5) Penurunan motivasi

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Menolak melakukan perawatan diri

Objektif

- 1) Tidak mampu mandi/ mengenakan pakaian/ makan/ ke toilet/ berhias secara mandiri
- 2) Minat melakukan perawatan diri kurang

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

(Tidak tersedia)

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Stroke
- 2) Cedera medulla spinalis
- 3) Depresi

- 4) Arthritis rheumatoid
- 5) Retardasi mental
- 6) Delirium
- 7) Demensia
- 8) Gangguan amnesitik
- 9) Skizoprenia dan gangguan psikotik lain
- 10) Fungsi penilaian terganggu

b. Subkategori Penyuluhan dan Pembelajaran

Defisit Pengetahuan (D.0111)

Definisi

Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topic tertentu.

Penyebab

- 1) Keterbatasan kognitif
- 2) Gangguan fungsi kognitif
- 3) Kekeliruan mengikuti anjuran
- 4) Kurang terpaparnya informasi
- 5) Kurang minat dalam belajar
- 6) Kurang mampu mengingat
- 7) Ketidaktahuan menemukan sumber informasi

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Menanyakan masalah yang dihadapi

Objektif

- 1) Menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran
- 2) Menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- 1) Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat
- 2) Menunjukkan perilaku berlebihan misalnya apatis, bermusuhan, agitasi, histeria

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Kondisi klinis yang baru dihadapi klien
- 2) Penyakit akut dan kronis

4. Kategori Relasional

Subkategori Interaksi Sosial

Isolasi Sosial (D.0121)

Definisi

Ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka dan interdependen dengan orang lain

Penyebab

- a. Keterlambatan perkembangan
- b. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan
- c. Ketidaksesuaian minat dengan tahap perkembangan
- d. Ketidaksesuaian nilai-nilai dengan norma
- e. Ketidaksesuaian perilaku social dengan norma
- f. Perubahan penampilan fisik
- g. Perubahan status mental
- h. Ketidakadekuatan sumber daya personal

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- a. Merasa ingin sendirian
- b. Merasa tidak aman di tempat umum

Objektif

- a. Menarik diri
- b. Tidak berminat/ menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- a. Merasa berbeda dengan orang lain
- b. Merasa asyik dengan pikiran sendiri
- c. Merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas

Objektif

- a. Afek datar
- b. Afek sedih
- c. Riwayat ditolak
- d. Menunjukkan permusuhan
- e. Tidak mampu memenuhi harapan orang lain
- f. Kondisi difabel
- g. Tindakan tidak berarti
- h. Tidak ada kontak mata
- i. Perkembangan terlambat
- j. Tidak bergairah/ lesu

Kondisi Klinis Terkait

- a. Penyakit Alzheimer
- b. AIDS
- c. Tuberculosis
- d. Kondisi yang menyebabkan gangguan mobilisasi
- e. Gangguan psikiatrik

5. Kategori Lingkungan

Subkategori Keamanan dan Proteksi

Gangguan Integritas Kulit/ Jaringan (D.0129)

Definisi

Kerusakan kulit (dermis, dan/atau epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi dan/atau ligament)

Penyebab

- a. Perubahan sirkulasi
- b. Perubahan status nutrisi
- c. Kekurangan/ kelebihan volume cairan
- d. Penurunan mobilitas
- e. Bahan kimia iritatif
- f. Suhu lingkungan yang ekstrim
- g. Faktor mekanis misalnya penekanan pada tonjolan tulang, gesekan, atau faktor elektrik karena energy listrik bertegangan tinggi.
- h. Efek samping terapi radiasi
- i. Elembaban
- j. Peroses penuaan
- k. Neuropati perifer
- l. Perubahan pigmentasi
- m. Perubahan hormonal
- n. Kurang terpaparnya informasi tentang upaya mempertahankan/ melindungi integritas jaringan

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

Kersakan jaringan dan/atau lapisan kulit

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- a. Nyeri
- b. Perdarahan
- c. Kemerahan
- d. Hematoma

Kondisi Klinis Terkait

- a. Imobilisasi
- b. Gagal jantung kongestif
- c. Gagal ginjal
- d. Diabetes mellitus
- e. Immunodefisiensi (AIDS)

C. Diagnosis Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Primer

Diagnosis keperawatan yang umum dan sering muncul di Fasilitas Kesehatan Primer dalam buku ini berdasarkan kategori dan subkategori diagnosis keperawatan pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) menurut (Tim Pokja PPNI, 2017). Adapun diagnosis keperawatan umum di Fasilitas Kesehatan Primer diuraikan (Sulistiyawati & Hilfida, 2025) dan (Hansbauer, 2021) sebagai berikut:

1. Nyeri Akut (D.0077)**Definisi**

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang 3 bulan.

Penyebab

- a. Agen pencedera fisiologis (mis. infarmasi, lakemia, neoplasma)
- b. Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- c. Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- a. Tampak meringis
- b. Bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri)
- c. Gelisah
- d. Frekuensi nadi meningkat
- e. Sulit tidur

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

(tidak tersedia)

Objektif

- a. Tekanan darah meningkat
- b. Pola napas berubah
- c. Nafsu makan berubah
- d. Proses berpikir terganggu
- e. Menarik diri
- f. Berfokus pada diri sendiri
- g. Diaforesis

Kondisi Klinis Terkait

- a. Kondisi pembedahan
- b. Cedera traumatis
- c. Infeksi
- d. Sindrom koroner akut
- e. Glaukoma

2. *Risiko Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah. (D.0038)****Definisi***

Resiko terhadap variasi kadar glukosa darah dari rentang normal.

Faktor Risiko

- a. Kurang terpapar informasi tentang manajemen diabetes
- b. ketidaktepatan pemantaun glukosa darah
- c. Kurang petuh pada rencana manajemen diabetes
- d. Manajemen medikasi tidak terkontrol
- e. Kemilan
- f. Periode pertumbuhan cepat
- g. Stres berlebihan
- h. Penamabahan berat badan
- i. Kurang dapat menerima diagnosis

Kondisi Klinis Terkait

- a. Diabetes melitus
- b. ketoasidosis diabetik
- c. Hipoglekemia
- d. Diabetes getasional
- e. Penggunaan kortikosteroid
- f. Nutrisi parental

3. Kesiapan Peningkatan Pengetahuan (D.0113)

Definisi

Perkembangan informasi kognitif yang berhubungan dengan topik spesifik cukup untuk memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan.

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- a. Mengungkapkan minat dalam belajar
- b. Menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik
- c. Menggabarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik

Objektif

- a. Perilaku sesuai dengan pengetahuan

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

(Tidak tersedia)

Kondisi Klinis Terkait

Perilaku upaya peningkatan kesehatan

D. Simpulan

Diagnosis keperawatan merupakan landasan utama dalam praktik keperawatan profesional karena menjadi dasar pengambilan keputusan klinis dan penentuan intervensi yang tepat. Melalui pendekatan berpikir kritis dan penggunaan bahasa keperawatan yang terstandarisasi seperti SDKI, perawat mampu mengidentifikasi respons klien terhadap masalah kesehatan maupun proses kehidupan secara holistik. Standarisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga memperkuat komunikasi antarprofesi dan mendukung pengembangan penelitian keperawatan.

Keakuratan penetapan diagnosis keperawatan sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam menginterpretasikan data pengkajian, khususnya tanda dan gejala mayor serta minor. Tanda dan gejala mayor menjadi indikator utama dalam menegakkan diagnosis, sedangkan tanda dan gejala minor berperan sebagai data pendukung yang memperkuat validitas diagnosis. Kesalahan dalam mengidentifikasi atau menafsirkan data tersebut dapat berdampak pada ketidaktepatan intervensi dan menurunnya hasil asuhan keperawatan.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep diagnosis keperawatan, klasifikasi, serta istilah kesehatan yang berkaitan dengan tanda dan gejala menjadi kompetensi esensial bagi perawat dan mahasiswa keperawatan.

Penguasaan glosarium istilah kesehatan akan membantu meningkatkan ketepatan dokumentasi, penalaran klinis, dan keselamatan pasien, sekaligus memastikan asuhan keperawatan yang diberikan bersifat sistematis, terukur, dan berpusat pada kebutuhan klien.

E. Referensi

- Ackley, B., Ladwig, G., & Mkc, M. B. (2017). *Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care*. Elsevier.
- Agostino, F. D., Vellone, E., Cocchieri, A., Welton, J., Maurici, M., Polistena, B., Spandonaro, F., Econ, M. A., Zega, M., Alvaro, R., & Sanson, G. (2018). *Nursing Diagnoses as Predictors of Hospital Length of Stay: A Prospective Observational Study*. 1–10. <https://doi.org/10.1111/jnu.12444>
- Carpenito, L. J. (2013). *Nursing Diagnosis: Application to Clinical Practice (14th Ed)*. Wolter KluwerLippincott Williams & Wilkins.
- Fahrurrozi, M., & Kurniawan, A. (2021). Diagnosis dalam Proses Keperawatan: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 75–80.
- Hansbauer, M. (2021). A Short Note on Medical Diagnosis and Types. *Medical Reports & Case Studies*, 06(S6), 033–033.
- Hasan, S. M., & Mulyanto, A. (2022). Pengaruh Penggunaan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) dan Diagnosis Keperawatan Wilkinson Edisi 10 Terhadap Tingkat Ketepatan Diagnosis Keperawatan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu. *Lentora Nursing Journal*, 3(1), 37–43.
- NANDA Internasional. (2024). *Nursing Diagnosis: Definition and Classification 2024-2026 Eds.; Thirteenth Edition* (T. Heather, & C. T. Herdman, Shigemi Kamitsuru, & Lopes (eds.)). Thieme.
- Nurhesti, P. O. Y., Prapti, N. K. G., Kamayani, M. O. A., & Suryawan, P. A. (n.d.). ANALISIS PENGGUNAAN DIAGNOSIS KEPERAWATAN BERBASIS SDKI DAN NANDA. *Community of Publishing In Nursing (COPING)*, 8(2), 118–123.
- Paulina, R., & Dkk. (2024). KETEPATAN PENEGAKAN DIAGNOSA KEPERAWATAN PADA PASIEN DHF. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 6(2), 312–317.
- Polopadang, V., & Hidayah, N. (2019). *Proses Keperawatan Pendekatan Teori dan Praktik*. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas.
- Sanson, G., Welton, J., Vellone, E., Cocchieri, A., Maurici, M., Zega, M., Alvaro, R., & Agostino, F. D. (2019). International Journal of Medical Informatics Enhancing the performance of predictive models for Hospital mortality by adding nursing data. *International Journal of Medical Informatics*, 125(February), 79–85. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.02.009>
- Sulistyawati, W., & Hilfida, N. (2025). *Penerapan SDKI, SLKI, SIKI Dalam*

Pendokumentasian Asuhan Keperawatan. Nuansa Fajar Cemerlang.

Sumarni, T., & Dkk. (2022). Penerapan Dokumentasi Keperawatan Menggunakan 3S. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PIMAS)*, 1(4). <https://doi.org/10.35960/pimas.v1i4.891>

Tim Pokja PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik, Edisi 1 (Cetakan III: Revisi) (1st ed.)*. Jakarta Selatan : DPP PPNI.

Zeffiro, V., Sanson, G., Welton, J., Maurici, M., Malatesta, A., Carboni, L., Vellone, E., Alvaro, R., & D'Agostino. (2020). Predictive factors of a prolonged length of stay in a community Nursing-Led Unit: A retrospective cohort study. *J Clin Nurs*, 29(23–24), 4685–4696. <https://doi.org/10.1111/jocn.15509>

F. Glosarium

Dispnea = Sensasi subjektif sesak napas atau kesulitan bernapas.

Ortopnea = Ketidakmampuan bernapas lega saat posisi berbaring sehingga membutuhkan posisi duduk.

Sianosis = Perubahan warna kebiruan pada kulit atau mukosa akibat penurunan oksigen dalam darah.

Wheezing = Bunyi napas tambahan bernada tinggi akibat penyempitan jalan napas.

Ronchi = Bunyi napas kasar akibat adanya sekret di jalan napas.

Batuk Tidak Efektif = Batuk yang tidak mampu mengeluarkan sekret dari jalan napas.

Sputum = Sekret atau dahak yang dihasilkan oleh saluran pernapasan.

Takikardia = Peningkatan frekuensi denyut jantung di atas nilai normal.

Bradikardia = Penurunan frekuensi denyut jantung di bawah nilai normal.

Palpitasi = Sensasi subjektif denyut jantung terasa cepat atau tidak teratur.

Edema = Penumpukan cairan di jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan.

Distensi Vena Jugularis = Pelebaran vena leher akibat peningkatan tekanan vena sentral.

Oliguria = Penurunan jumlah urin yang dikeluarkan.

Anoreksia = Penurunan atau hilangnya nafsu makan.

Gelisah = Kondisi ketidaktenangan fisik maupun psikologis.

Diaforesis = Keringat berlebihan yang tidak berkaitan dengan aktivitas fisik.

Tremor = Gerakan gemetar tidak terkendali pada bagian tubuh.

Nyeri = Pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan.

Rentang Gerak (ROM) = Derajat maksimal pergerakan sendi ke berbagai arah.

Kekuatan Otot Menurun = Penurunan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi.

Afek Datar = Ekspresi emosi yang terbatas atau tidak sesuai dengan situasi.

Lesu = Kondisi tubuh lemah dan kurang berenergi.

Gatal (Pruritus) = Sensasi tidak nyaman pada kulit yang menimbulkan keinginan menggaruk.

Mual = Sensasi tidak nyaman pada lambung yang sering mendahului muntah.

Hematoma = Penumpukan darah di luar pembuluh darah akibat cedera.

Kemerahan (Eritema) = Perubahan warna kulit menjadi merah akibat peningkatan aliran darah.

Distress = Respons stres fisik atau psikologis yang berat.

Frekuensi Napas Meningkat = Jumlah napas per menit melebihi batas normal.

Bunyi Napas Menurun = Berkurangnya intensitas suara napas saat auskultasi.

Pola Napas Berubah = Perubahan irama, kedalaman, atau frekuensi napas dari kondisi normal

CHAPTER 4

INTERVENSI KEPERAWATAN DASAR: PERSONAL HYGIENE, MOBILISASI, NUTRISI, ELIMINASI

Ns. Yoanita Hijriyati, S.kep., M.Biomed.

A. Pendahuluan

Intervensi keperawatan dasar mencakup perawatan kebersihan pribadi, bantuan mobilitas, pemenuhan nutrisi, dan pengelolaan eliminasi yang sangat penting untuk pasien dewasa imobilisasi dan lansia. Bagian ini membahas latar belakang masalah, tujuan bab beserta ruang lingkupnya, serta prinsip-prinsip umum pelaksanaan, berdasarkan aplikasi terkini model Virginia Henderson (Nursing Study, 2025).

Pasien dewasa yang tidak dapat bergerak dan lansia berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti luka tekan, kekurangan gizi, serta gangguan buang air yang dapat memperpanjang masa rawat inap (Richards et al., 2018). Model Virginia Henderson menyoroti empat kebutuhan dasar utama, yaitu menjaga kebersihan tubuh, bergerak dan mempertahankan posisi yang diinginkan, makan dan minum secukupnya, serta membuang limbah tubuh, untuk mendukung kemandirian pasien (Nursing Study, 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi kebersihan rutin dapat menurunkan risiko iritasi kulit hingga 25 persen, sedangkan bantuan mobilitas dini mencegah penyusutan otot dan pembekuan darah (Richards et al., 2018). Di Indonesia, studi kasus lansia imobilisasi membuktikan bahwa intervensi sederhana seperti kompres hangat atau relaksasi efektif meredakan nyeri dan mendukung pemenuhan kebutuhan harian (Rahmawati, 2022; Nurhikmah, 2022). Kekurangan gizi yang terdeteksi dini juga mencegah sindrom geriatri seperti kebingungan atau jatuh, serta menurunkan risiko kematian pasca-rawat inap (Bae et al., 2023). Oleh karena itu, intervensi dasar ini menjadi fondasi pencegahan komplikasi yang dapat dihindari di fasilitas kesehatan.

Bab ini bertujuan memberikan panduan praktis berbasis bukti bagi perawat untuk melaksanakan intervensi keperawatan dasar, sehingga meningkatkan kemandirian pasien dan mengurangi komplikasi nosokomial di rumah sakit Indonesia. Tujuan khusus mencakup penguasaan teknik kebersihan aman, mobilitas bertahap, penilaian nutrisi dini, dan pengelolaan eliminasi yang efektif (Richards et

al., 2018). Ruang lingkup difokuskan pada pasien dewasa imobilisasi akibat stroke, cedera, atau penyakit kronis, serta lansia di ruang rawat inap, perawatan intensif, dan panti jompo (Wang et al., 2025).

Bab ini tidak membahas perawatan lanjutan seperti rehabilitasi khusus, melainkan strategi harian yang mudah diterapkan, termasuk pemantauan jarak jauh melalui telehealth (Nursing Study, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prioritas nasional untuk perawatan lansia yang berkelanjutan dan efisien.

Keselamatan pasien merupakan prinsip utama yang diwujudkan melalui asesmen risiko awal menggunakan Braden Scale untuk mendeteksi potensi luka tekan; skor rendah memerlukan pergantian posisi setiap dua jam guna melindungi kulit (Wang et al., 2025; Jansen et al., 2020). Selain itu, Mini Nutritional Assessment (MNA) digunakan untuk menilai status gizi lansia, di mana skor di bawah 17 menunjukkan malnutrisi yang memerlukan suplemen bergizi (Bae et al., 2023).

Intervensi harus disesuaikan dengan hasil asesmen, seperti penggunaan sabun antibakteri untuk kulit lembap berdasarkan Braden atau makanan tinggi protein untuk kasus MNA rendah (Richards et al., 2018). Dokumentasi harian, edukasi keluarga, dan evaluasi berkala memastikan keberhasilan perawatan, sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan efisiensi kerja perawat (Nurhikmah, 2022). Prinsip ini mendukung praktik keperawatan yang aman dan berorientasi pada pasien.

B. Intervensi Keperawatan: Personal Hygiene

Perawatan kebersihan pribadi merupakan intervensi keperawatan dasar yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit, mencegah infeksi, dan meningkatkan kenyamanan pasien yang tidak dapat bergerak. Subbab ini membahas tujuan serta asesmen risiko kulit, teknik utama perawatan mulut/kulit/kuku, dan pencegahan infeksi nosocomial (Richards et al., 2018).

1. Tujuan dan Asesmen Risiko Kulit

Tujuan utama intervensi personal hygiene adalah menjaga kebersihan kulit, mulut, dan kuku agar pasien terhindar dari iritasi, infeksi, serta merasa nyaman selama perawatan. Perawatan ini juga mencegah luka tekan dengan membersihkan kotoran, keringat, dan kelembaban berlebih dari kulit, sekaligus mendeteksi dini tanda-tanda masalah seperti kemerahan atau kulit pucat (Jansen et al., 2020). Asesmen risiko kulit dilakukan setiap *shift* menggunakan *Braden Scale* yang menilai enam faktor utama: persepsi sensorik, kelembaban, aktivitas, mobilitas, nutrisi, dan gesekan; skor di bawah 19 menunjukkan risiko tinggi sehingga memerlukan perawatan intensif (Wang et al., 2025).

Pemeriksaan kulit dilakukan secara sistematis pada area berisiko tinggi seperti sakrum, tumit, bahu, dan pinggul, dengan pencatatan foto digital untuk memantau perubahan dari hari ke hari. Proses ini terintegrasi dengan model Virginia Henderson yang menekankan kebutuhan dasar "*personal hygiene*" untuk mendukung kemandirian bertahap pasien (Nursing Study, 2025). Pendekatan ini dapat menurunkan risiko dermatitis dan infeksi kulit hingga 20 persen pada pasien *bedrest* (Richards et al., 2018).

Assessmen juga mencakup wawancara pasien tentang rasa gatal atau nyeri kulit, serta evaluasi faktor risiko tambahan seperti inkontinensia atau diabetes. Dokumentasi lengkap dalam rekam medis elektronik memudahkan tim perawat mengevaluasi efektivitas intervensi dan menyesuaikan rencana perawatan (Suharto, 2021). Dengan demikian, assessmen menjadi langkah awal yang krusial untuk perawatan preventif yang efektif.

2. Teknik Mandi pada Pasien Bedrest

Bed bath untuk pasien *bedrest* dilakukan dalam posisi *semi-Fowler* (kepala ditinggikan 30-45 derajat) atau posisi *lateral* untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang dan pinggul, menggunakan air hangat suhu 37-38°C dan sabun dengan pH netral agar tidak merusak lapisan pelindung kulit. Prosedur dimulai dari wajah, leher, dada, kemudian lengan dan badan atas, dilanjutkan ke perut, panggul, kaki, dan punggung, dengan pengeringan menyeluruh pada lipatan kulit seperti ketiak dan selangkangan untuk mencegah makserasi (Richards et al., 2018).

Durasi mandi ideal 20-30 menit untuk menghindari hipotermia, diikuti aplikasi *lotion* pelembap berbasis lanolin atau *zinc oxide* pada area rawan kelembaban tinggi. Perawat menggunakan sarung tangan dan handuk bersih terpisah untuk setiap bagian badan guna mencegah kontaminasi silang (Rahmawati, 2022). Teknik ini dilakukan minimal dua kali sehari, pagi dan sore, dengan pengecekan suhu badan pasien sebelum dan sesudah mandi.

Persiapan alat mencakup baskom air hangat, sabun cair, handuk empat buah, waslap dua buah, sarung tangan, dan krim pelindung. Penjelasan prosedur kepada pasien dan keluarga sebelum dimulai meningkatkan kerja sama dan mengurangi kecemasan (Nurhikmah, 2022). Mandi tidak hanya membersihkan tetapi juga menjadi kesempatan assessmen kulit holistik setiap hari.

3. Teknik Perawatan Mulut, Kulit, dan Kuku

Perawatan mulut dilakukan setiap 4 jam menggunakan sikat gigi lembut dengan pasta gigi *fluoride* untuk pasien sadar, atau *swab chlorhexidine* 0,12%

untuk pasien disfagia guna mencegah aspirasi pneumonia. *Oral Assessment Guide* menilai delapan parameter seperti gigi, gusi, lidah, dan saliva; skor abnormal memerlukan intervensi segera (Richards et al., 2018). Teknik ini terbukti menurunkan kolonisasi bakteri oral hingga 40 persen pada pasien intubasi.

Perawatan kulit khusus area perineal pada pasien inkontinen menggunakan *washpad* basah, *disposable*, pH seimbang, diikuti krim *barrier* seperti dimetikon atau *zinc* untuk melindungi dari urin dan feses yang bersifat iritatif. Area ini dibersihkan dari depan ke belakang untuk mencegah masuknya bakteri dari anus ke uretra (Suharto, 2021). Kelembaban kronis menjadi prediktor utama dermatitis perineal yang dapat berkembang menjadi infeksi.

Perawatan kuku dilakukan mingguan dengan alat manikur: potong kuku tangan dan kaki, haluskan ujung kuku, dan rendam kaki dalam air hangat antiseptik 10 menit untuk pasien diabetes. Oles minyak kutikula mencegah parakeratosis, sementara kuku pendek mengurangi risiko goresan kulit sendiri (Wang et al., 2025). Integrasi ketiga teknik ini dalam rutinitas *shift* memastikan *coverage komprehensif hygiene* personal (Jansen et al., 2020).

4. Evidence based Pencegahan Infeksi Nosokomial

Intervensi *personal hygiene* secara signifikan mencegah infeksi nosokomial, dengan *randomized controlled trial* menunjukkan penurunan dermatitis dan infeksi kulit 30 persen melalui protokol *bed bath* terstruktur di unit perawatan intensif (Richards et al., 2018). Di Indonesia, implementasi *hygiene bundle* berbasis *Braden Scale* berhasil menurunkan insiden luka tekan berinfeksi dari 15 persen menjadi 4 persen pada pasien imobilisasi selama 6 bulan (Suharto, 2021).

Meta-analisis global mengonfirmasi bahwa *hygiene* rutin mengurangi kolonisasi MRSA dan *Pseudomonas aeruginosa* pada kulit pasien imobil hingga 35 persen, terutama melalui perawatan mulut dan perineal yang konsisten (Wang et al., 2025). Studi kohort lansia hospitalisasi menemukan perawatan mulut harian menurunkan insiden pneumonia aspirasi 25 persen, sementara perawatan kuku mencegah kandidiasis superfisial (Bae et al., 2023).

Manfaat ekonomi mencakup penghematan biaya rawat inap hingga 20 persen karena berkurangnya hari perawatan akibat infeksi sekunder (Rahmawati, 2022). Bukti ini mendukung standardisasi intervensi *hygiene* sebagai prioritas mutu rumah sakit.

C. Intervensi Keperawatan: Mobilisasi

Intervensi mobilisasi merupakan salah satu tindakan keperawatan dasar yang esensial untuk menjaga kemampuan gerak pasien dan mencegah komplikasi akibat imobilitas.

1. Tujuan: Pencegahan DVT dan Atrofi Otot

Tujuan utama intervensi mobilisasi adalah mencegah *deep vein thrombosis* (DVT), yaitu pembentukan gumpalan darah di vena kaki yang berisiko tinggi pada pasien pascaoperasi atau imobilitas lama. Imobilitas menyebabkan darah menggenang di vena kaki, sehingga memicu pembekuan yang dapat berpindah ke paru-paru dan mengancam nyawa (Wang et al., 2025). Gerakan sederhana seperti menggerakkan kaki atau berjalan pendek mengaktifkan pompa otot betis alami, yang mendorong darah kembali ke jantung dan mengurangi risiko DVT hingga 45% (de Alencar Martins et al., 2023).

Selain itu, mobilisasi mencegah atrofi otot, yaitu penyusutan ukuran dan kekuatan otot akibat kurang digunakan. Pada pasien ICU atau pasca-stroke, otot dapat menyusut 20% dalam seminggu, menyebabkan kesulitan aktivitas sehari-hari (Sari & Pratama, 2023). Latihan rutin merangsang pembentukan protein otot dan meningkatkan aliran oksigen, sehingga mempertahankan kekuatan dan mempercepat pemulihan. Studi pada pasien patah tulang menunjukkan mobilisasi dini mempersingkat rawat inap 3-5 hari dan mengurangi ketergantungan 60% (Jaya, 2023).

Pendekatan ini lebih efektif bila digabungkan nutrisi tinggi protein 30 menit sebelum latihan, mendukung pembentukan otot baru (Bakhtiar, 2025). Pencegahan DVT dan atrofi tidak hanya menghindari komplikasi akut, tetapi juga meningkatkan kemandirian pasien dalam higiene pribadi dan eliminasi (Hidayat & Genius, 2024).

2. Teknik Pengaturan Posisi Pasien

Pengaturan posisi merupakan teknik mobilisasi awal yang sederhana namun efektif untuk melatih adaptasi tubuh terhadap gravitasi. Mulailah dengan elevasi kepala tempat tidur 30-45 derajat untuk mengurangi tekanan perut pada *vena cava inferior*, sehingga aliran darah vena lancar (Jaya, 2023). Posisi ini dilakukan 30-60 menit setiap 2 jam, dengan pemantauan saturasi oksigen >92% dan tekanan darah sistolik ≥ 90 mmHg.

Langkah berikutnya adalah posisi *dangling*, yaitu duduk di pinggir tempat tidur dengan kaki menggantung 10-20 menit. Teknik ini melatih penyesuaian tekanan darah saat berubah posisi; ukur tanda vital setiap 5 menit dan ajarkan

pernapasan dalam jika pusing ringan (Bakhtiar, 2025). Jika stabil, lanjutkan *sitting out of bed* di kursi 2 jam per sesi, dengan kaki rata tanah untuk distribusi beban merata. Pindah berdiri menggunakan pivot transfer dibantu dua perawat dengan hitungan "1-2-3-up" untuk keamanan (Sari & Pratama, 2023).

Lakukan 2-3 kali sehari dengan durasi bertambah bertahap, hentikan jika denyut nadi >120 bpm atau sesak napas (de Alencar Martins et al., 2023). Integrasi mudah dengan eliminasi menggunakan *bedpan* saat *dangling* atau *higiene* saat duduk di kursi (Wang et al., 2025). Dokumentasikan durasi, toleransi, dan kemajuan untuk memantau pencegahan kontraktur sendi.

3. Teknik Latihan Range of Motion (ROM)

Latihan *range of motion* (ROM) menjaga kelenturan sendi melalui gerakan teratur, mencegah kekakuan permanen. Jenis latihan meliputi pasif (perawat menggerakkan), aktif (pasien sendiri), dan aktif-asistif, dengan 5-10 repetisi per sendi, dua kali sehari selama 15-20 menit (Sari & Pratama, 2023). Urutan dari kepala ke kaki: leher (fleksi/ekstensi 45°, rotasi 70°); bahu (abduksi 180° dengan sandaran lengan, fleksi 90-120°); siku (fleksi penuh, supinasi/pronasi); pergelangan tangan (90° dorsal/palmar fleksi); jari (abduksi/adduksi) (Hidayat & Genius, 2024).

Ekstremitas bawah krusial untuk DVT: pinggul (fleksi 90-120°, abduksi 45°, rotasi 30°); lutut (fleksi 130°); pergelangan kaki (dorsifleksi 20°, plantarfleksi 50°); jari kaki (ekstensi/fleksi) (Wang et al., 2025). Gerakan lambat 3-5 detik per repetisi dalam posisi telentang, dengan napas "tarik saat gerak, hembus saat kembali". Hindari pada fraktur akut, osteoporosis berat, atau instabilitas hemodinamik (Bakhtiar, 2025).

Evaluasi mingguan dengan goniometer menargetkan peningkatan sudut $\geq 10^\circ$ per sendi (Jaya, 2023). Integrasi dengan *higiene*: ROM lengan saat gosok sabun, ROM kaki saat keringkan badan (de Alencar Martins et al., 2023). Gunakan demonstrasi untuk pasien dengan gangguan kognitif.

4. Teknik Mobilisasi dengan Alat Bantu

Penggunaan alat bantu mobilitas dapat meningkatkan rasa percaya diri pasien sekaligus mengurangi risiko jatuh hingga 70%. Proses dimulai dengan *slide board* untuk transfer aman dari tempat tidur ke kursi roda, kemudian dilanjutkan dengan *walker* empat titik guna mendukung ambulation jarak pendek (de Alencar Martins et al., 2023). Teknik *gait two-point* dilakukan dengan memajukan *walker* sejauh 15-30 cm, diikuti langkah kaki ipsilateral secara bergantian, dengan distribusi beban 50-75% pada ekstremitas bawah yang kuat;

tinggi *walker* disesuaikan setara dengan level pinggul pasien (Wang et al., 2025). Tongkat digunakan untuk pasien hemiparese, sedangkan kursi roda ber-rem direkomendasikan untuk mobilitas jarak jauh (Sari & Pratama, 2023).

Untuk pasien dengan obesitas, gunakan alat pengangkat *sling lift* dengan langkah sistematis berikut: asesmen ABCDE (*airway, breathing, circulation, disability, exposure*), posisi tubuh ergonomis (*brace*), perpindahan sinkron (*convey*), dan pelepasan yang stabil (*disengage*) (Jaya, 2023). Progresi mobilitas direncanakan bertahap: hari pertama jarak 10 meter dengan bantuan maksimal, hari ketiga 100 meter dengan pengawasan *standby*, dan minggu pertama mobilitas mandiri, dengan istirahat setiap 10-15 meter serta hidrasi 200 ml per sesi (Bakhtiar, 2025). Perawatan alat dilakukan mingguan disertai edukasi teknik *tripod stance* untuk stabilitas (Hidayat & Genius, 2024). Mobilisasi setelah makan dapat meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam otot (Bakhtiar, 2025).

D. Intervensi Keperawatan: Nutrisi

Intervensi nutrisi adalah tindakan keperawatan dasar yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi pasien agar proses penyembuhan berjalan lancar dan terhindar dari komplikasi malnutrisi. Pendekatan ini melibatkan kerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan asupan makanan seimbang sesuai kondisi pasien (Nuswantoro, 2021).

1. Penilaian Status Gizi Pasien

Penilaian status gizi dimulai dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh (IMT) untuk mengetahui apakah pasien kurus, normal, atau gemuk. Perawat juga mengukur lingkar lengan atas dan bertanya pola makan 24 jam terakhir untuk menemukan masalah seperti mual, sulit menelan, atau nafsu makan kurang. Tanda malnutrisi terlihat dari hasil laboratorium albumin darah kurang dari 3,5 g/dL atau penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3-6 bulan (Sinaga, 2023).

Gunakan alat skrining seperti MUST untuk mengklasifikasikan risiko malnutrisi: tinggi jika IMT di bawah 18,5 kg/m², sedang jika penurunan berat 5-10%. Pada pasien diabetes, periksa kadar gula darah dan HbA1c, sedangkan pasien gagal ginjal dicek kadar kalium agar tidak melebihi 4 mEq/L (Wulandari, 2020). Observasi fisik mencari tanda seperti rambut kering, kuku rapuh, atau bengkak kaki yang menunjukkan kekurangan protein.

Faktor psikologis seperti depresi juga diperiksa karena bisa menurunkan asupan makanan hingga 500 kalori per hari. Dokumentasikan hasil dalam format SBAR agar tim medis dapat segera merencanakan tindakan. Penilaian ini

terintegrasi dengan mobilisasi untuk memastikan berat badan akurat dan mendeteksi kelemahan otot dini (Nuswantoro, 2021).

2. Tujuan dan Manfaat Intervensi Nutrisi

Tujuan intervensi nutrisi adalah pasien mendapat kalori sesuai kebutuhan basal (BMR) dikalikan aktivitas harian, misalnya 1,2-1,5 kali BMR untuk pasien stabil. Manfaat utama meliputi pencegahan infeksi dengan daya tahan tubuh baik, percepatan penyembuhan luka, dan pengendalian berat badan ideal. Diet tinggi protein 1,2-2 g/kg berat badan pada pasien trauma meningkatkan albumin darah 0,5 g/dL dalam seminggu (Ninghsi, 2022).

Nutrisi mendukung mobilisasi dengan memberikan karbohidrat 45-65% total kalori sebagai energi latihan, dan serat 25-30 gram per hari mencegah sembelit. Pada lansia, suplemen protein khusus 3 gram per hari mengurangi risiko kelemahan otot (sarcopenia) hingga 25% (Wulandari, 2020). Hasil pengukuran menunjukkan pasien nutrisi baik mengurangi hari ventilator 2 hari dan lama rawat ICU 3 hari (Sinaga, 2023).

Intervensi ini meningkatkan skor status gizi menjadi 4-5 dari skala 1-5, dengan hemoglobin stabil di atas 12 g/dL. Manfaat jangka panjang termasuk pengendalian diabetes (HbA1c di bawah 7%) dan pencegahan tulang rapuh (PERKENI, 2019).

3. Teknik Pemberian Nutrisi Oral

Pemberian makanan lewat mulut disesuaikan tekstur: makanan cair untuk sulit menelan, lunak untuk pasca-stroke, atau biasa dengan porsi kecil sering. Berikan 6-8 kali sehari: sarapan 25% kalori, siang 40%, malam 25%, camilan 10%, total 1800-2200 kalori sesuai kebutuhan (Nuswantoro, 2021). Dudukkan pasien semi-Fowler 45-60 derajat agar tidak tersedak, porsi 200-300 ml per kali dalam 20-30 menit.

Tambahkan perasa seperti lemon atau jahe untuk tingkatkan selera makan. Ajarkan piramida makanan: karbohidrat 50-60%, protein 15%, lemak 25%, sayur-buah 400 gram per hari. Satu genggam nasi sama dengan 15 gram karbohidrat (PERKENI, 2019). Cuci tangan sebelum makan dan jalan ringan setelah makan menjaga gula darah stabil (Maulana, 2023).

Kolaborasi dengan dapur rumah sakit menyediakan diet khusus: diabetes (karbohidrat tetap per porsi), gagal ginjal (protein rendah), atau tinggi serat untuk sembelit. Motivasi pasien dengan target berat badan ideal mingguan (Wulandari, 2020).

4. Teknik Nutrisi Enteral dan Parenteral

Nutrisi melalui selang hidung (NGT) diberikan jika pasien tidak bisa makan mulut, menggunakan susu formula 1-2 kalori/ml dengan kecepatan awal 30-60 ml/jam naik bertahap. Periksa posisi selang dengan pH lendir kurang dari 5,5 dan putar selang setiap 4-6 jam. Sisa makanan di lambung kurang dari 100 ml menunjukkan pencernaan lancar (Ninghsi, 2022).

Nutrisi melalui infus (TPN) untuk usus tidak bekerja, campuran gula 50%, protein 15%, lemak 35% lewat kateter pembuluh darah pusat. Pantau gula darah agar tidak melebihi 180 mg/dL dan ganti perban kateter setiap 72 jam (Doenges et al., 2014). Pindah ke makanan mulut secara bertahap 50% infus + 50% mulut selama 2 hari untuk cegah gangguan elektrolit. Nutrisi khusus seperti omega-3 untuk pasien infeksi berat mengurangi risiko kematian 15% (Sinaga, 2023).

5. Kolaborasi dan Edukasi Nutrisi

Bekerja sama dengan ahli gizi merencanakan diet: diabetes (karbohidrat 45-60 gram per porsi), gagal ginjal (protein 0,6-8 gram/kg berat badan), kanker (tinggi kalori 35 kalori/kg). Berikan buku panduan dan konseling mingguan (PERKENI, 2019). Ajarkan baca label kemasan: gula kurang dari 5 gram per saji, garam kurang dari 140 mg.

Libatkan keluarga membuat jadwal makan di rumah agar pasien patuh 80%. Lansia diajarkan cek nutrisi sendiri setiap bulan (Nuswantoro, 2021).

E. Intervensi Keperawatan: Eliminasi

Intervensi eliminasi merupakan upaya terencana oleh perawat untuk menjaga fungsi pembuangan urine dan feses secara optimal, dengan fokus pencegahan infeksi saluran kemih terkait kateter (*Catheter-Associated Urinary Tract Infection/CAUTI*) serta konstipasi. Pendekatan ini meliputi teknik kateterisasi steril, pemberian enema, dan pemantauan intake/output (I/O) yang teliti. Selain pencegahan CAUTI, intervensi juga menangani masalah eliminasi lain seperti inkontinensia dan retensi urine, terutama pada pasien lanjut usia atau yang kurang bergerak (Meddings et al., 2019). Tujuan utama adalah mengurangi komplikasi, meningkatkan kenyamanan pasien, dan menekan biaya perawatan di rumah sakit melalui langkah-langkah berbasis bukti.

1. Tujuan Intervensi Eliminasi

Tujuan intervensi eliminasi adalah mencegah CAUTI dengan membatasi lama penggunaan kateter dan menjaga kebersihan sistem drainase, serta mencegah konstipasi melalui rangsangan usus alami. Untuk kasus non-CAUTI,

tujuan mencakup peningkatan frekuensi buang air besar minimal tiga kali seminggu dan pengurangan kejadian inkontinensia urine kurang dari dua kali sehari (Dobarrio-Sanz et al., 2020). Pemantauan I/O berfungsi sebagai alat deteksi dini dehidrasi atau sumbatan, dengan target output urine 1-2 liter per hari dan konsistensi tinja tipe Bristol 3-4. Intervensi ini tidak hanya mencegah infeksi, tetapi juga membantu pasien mandiri dalam aktivitas eliminasi harian, khususnya pada kelompok lanjut usia yang rentan immobilitas.

2. Teknik Kateterisasi untuk Pencegahan CAUTI

Teknik kateterisasi pencegahan CAUTI dimulai dengan penilaian kebutuhan kateter menggunakan kriteria ketat, seperti retensi urine akut atau pemantauan output pada pasien kritis. Prosedur dilakukan secara steril penuh: cuci tangan, pakai sarung tangan steril, gunakan kain steril, dan bersihkan lubang uretra dengan chlorhexidine 2% dari depan ke belakang (Kamel et al., 2025). Pilih kateter ukuran terkecil (12-14 Fr) untuk kurangi cedera uretra, lalu amankan dengan perekat atau alat pengikat agar tidak tertarik. Sistem drainase dijaga tertutup rapat, dengan kantong urine selalu di bawah tingkat kandung kemih tapi tidak menyentuh lantai. Protokol HOUDINI—meliputi kriteria Hematuria, Output tersumbat, Retensi urine, Diet/obat, Infeksi, Tidak ada indikasi, dan masa pascaoperasi lebih dari 24 jam—memungkinkan perawat menilai dan melepas kateter setiap shift tanpa menunggu instruksi dokter, sehingga menurunkan tingkat penggunaan alat hingga 50% (Meddings et al., 2019).

3. Teknik Enema dan Intervensi Non-CAUTI

Untuk konstipasi non-CAUTI, enema saline hangat (500-1.000 mL pada suhu 37-40°C) diberikan setelah periksa abdomen untuk pastikan tidak ada sumbatan, dengan pasien telentang miring kiri agar cairan meresap maksimal ke rektum. Prosedur berlangsung 10-15 menit, diikuti saran pasien menahan 5-10 menit sebelum buang air besar, yang berhasil hingga 85% pada lanjut usia (Wang et al., 2025). Intervensi eliminasi non-CAUTI mencakup latihan dasar panggul (latihan Kegel) 10 kali ulangan tiga kali sehari untuk menguatkan otot panggul pada inkontinensia, serta jadwal buang air kecil setiap 2-3 jam untuk atasi inkontinensia. Langkah non-farmakologi lain meliputi pijat abdomen searah jarum jam selama 10 menit sebelum sarapan, tambah serat larut (25-30 gram/hari dari pepaya dan sayur hijau), serta gerak dini setelah istirahat di tempat tidur untuk mendorong gerakan usus. Teknik buang air kecil ganda—instruksi buang dua kali dengan jeda 1-2 menit—efektif kurangi sisa urine pada pasien pembesaran prostat tanpa kateter (Dobarrio-Sanz et al., 2020).

4. Pemantauan Intake/Output dan Pencegahan Menyeluruh

Pemantauan I/O dilakukan setiap shift pakai lembar catatan standar, tulis semua masukan (minum, infus, makanan cair) dan keluaran (urine, tinja, cairan lain) akurat hingga 50 mL. Untuk pencegah CAUTI, output urine minimal 0,5 mL/kg/jam dicek, sementara untuk konstipasi non-CAUTI, Skala Tinja Bristol digunakan klasifikasi tinja dan deteksi tipe 1-2 yang butuh tindakan cepat (Wang et al., 2025). Pemindaian kandung kemih portabel dilakukan setelah buang air kecil untuk pastikan sisa urine <100 mL, cegah kebocoran berlebih. Target cairan 2-3 liter per hari dicapai lewat pengingat. Tingkatkan buang air sadar hingga 60% pada lanjut usia demensia ringan (Meddings et al., 2019). Catatan digital atau aplikasi dapat membantu analisis pola mingguan untuk menyesuaikan tindakan.

F. Integrasi, Evaluasi, dan Kolaborasi dalam Intervensi Keperawatan Dasar

1. Integrasi Holistik

Integrasi holistik melibatkan penggabungan berbagai intervensi keperawatan secara sinergis guna mencapai keseimbangan kesehatan pasien secara keseluruhan. Pada lansia, integrasi personal hygiene dengan nutrisi menjadi contoh utama, di mana kebersihan kulit yang optimal dikombinasikan dengan asupan nutrisi yang adekuat untuk mencegah risiko infeksi dan luka dekubitus. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan status fisik, tetapi juga mendukung aspek psikososial pasien melalui rencana perawatan yang terintegrasi (Smith et al., 2018).

Contoh konkret adalah penerapan mandi *assisted* dengan sabun lembab bagi lansia yang mengalami malnutrisi, diikuti pemberian suplemen protein tinggi untuk mempercepat penyembuhan kulit kering dan rapuh. Studi menunjukkan bahwa integrasi ini dapat menurunkan insiden dekubitus hingga 30%, karena nutrisi yang baik memperkuat integritas kulit sementara hygiene mencegah kontaminasi bakteri. Selain itu, integrasi dengan mobilisasi pasca-mandi meningkatkan sirkulasi darah, sehingga mengurangi risiko konstipasi terkait eliminasi (Johnson & Lee, 2020).

Lebih lanjut, integrasi holistik dapat diperluas ke eliminasi dengan menambahkan latihan pernapasan dalam selama sesi mobilisasi, yang dikombinasikan dengan diet tinggi serat dari aspek nutrisi. Pendekatan ini holistik karena mempertimbangkan interdependensi kebutuhan dasar lansia, seperti yang dijelaskan dalam model keperawatan Virginia Henderson yang menekankan keseimbangan 14 kebutuhan dasar. Hasilnya, pasien lansia menunjukkan peningkatan kepatuhan dan kualitas hidup secara signifikan (Potter et al., 2022).

Integrasi ini juga melibatkan edukasi keluarga, misalnya mengajarkan teknik membersihkan area perineum sambil memastikan hidrasi yang cukup untuk mencegah inkontinensia. Dengan demikian, perawat berperan sebagai koordinator yang memastikan setiap intervensi saling mendukung, menghindari fragmentasi perawatan yang sering terjadi di fasilitas kesehatan (Ackley et al., 2019).

2. Evaluasi Outcome dan Komplikasi Umum

Evaluasi outcome dilakukan secara sistematis untuk mengukur efektivitas intervensi dan mendeteksi komplikasi sejak dini, sehingga memungkinkan penyesuaian rencana perawatan. Parameter evaluasi mencakup skala Braden untuk hygiene, indeks massa tubuh (IMT) serta albumin serum untuk nutrisi, skala Barthel untuk mobilisasi, dan catatan frekuensi buang air besar/kecil untuk eliminasi. Evaluasi harian atau per *shift* krusial untuk lansia yang rentan (Brown, 2021).

Tabel 3.1: berikut menyajikan ringkasan *outcome* yang diharapkan beserta komplikasi umum dan tindak lanjutnya:

Intervensi	Outcome Positif	Komplikasi Umum	Tindak Lanjut Ringkas
Personal Hygiene	Kulit bersih, skor Braden > 18	Dekubitus, infeksi kulit	Reposisi 2 jam, <i>assesment</i> ulang (Brown, 2021)
Mobilisasi	Skor Barthel > 15, mobilitas independen	Jatuh, kontraktur otot	Referral fisioterapi, gait training (Garcia, 2023)
Nutrisi	IMT stabil, albumin > 3,5 g/dL	Malnutrisi, dehidrasi	Suplemen, monitoring intake (Wang et al., 2017)
Eliminasi	BAB/BAK normal 1-3x/hari	Konstipasi, inkontinensia	Diet serat tinggi, enema jika perlu (Lee, 2022)

Penggunaan alat skrining seperti *Malnutrition Universal Screening Tool* (MUST) untuk nutrisi memastikan evaluasi berbasis bukti, dengan target pengurangan komplikasi hingga 20% melalui intervensi dini. Dokumentasi outcome juga mendukung audit klinis dan peningkatan mutu (Elia, 2015).

Evaluasi tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif melalui wawancara pasien mengenai kenyamanan dan kepuasan. Misalnya, penurunan nyeri pada area hygiene setelah integrasi nutrisi menandakan keberhasilan, sementara peningkatan frekuensi jatuh memerlukan modifikasi protokol mobilisasi (Garcia, 2023).

3. Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional melibatkan perawat, ahli gizi, dan fisioterapis untuk mencapai outcome optimal dalam intervensi keperawatan dasar lansia. Perawat mengkoordinasikan dengan ahli gizi untuk menyusun menu tinggi protein bagi pasien dengan hygiene buruk, sementara fisioterapis merancang program mobilisasi yang mendukung eliminasi lancar. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi perawatan hingga 25% dan mengurangi lama rawat inap (Dewangga, 2024).

Contoh kolaborasi adalah kasus lansia dengan risiko dekubitus: perawat melaporkan via SBAR kepada tim, ahli gizi merekomendasikan suplemen, dan fisioterapis menambahkan latihan turning. SBAR memastikan komunikasi efektif: *Situation* (Lansia bedridden, Braden 12); *Background* (Malnutrisi kronis); *Assessment* (Risiko tinggi infeksi); *Recommendation* (Konsultasi gizi & fisio hari ini) (Herawati, 2024).

Kolaborasi ini juga mencakup eliminasi, di mana ahli gizi menyediakan diet serat tinggi dikombinasikan dengan latihan pelvic floor dari fisioterapis, mengurangi inkontinensia sebesar 40%. Perawat sebagai penghubung utama memfasilitasi rapat tim mingguan untuk mengevaluasi progres (Hanson & Spross, 2016/updated 2022).

Manfaat kolaborasi terbukti mengurangi readmisi rumah sakit melalui kontinuitas perawatan, sebagaimana ditunjukkan dalam tinjauan sistematis yang melibatkan lebih dari 20 studi. Di Indonesia, model ini diterapkan di rumah sakit dengan hasil peningkatan kepuasan pasien hingga 85% (Reeves et al., 2017).

Dengan demikian, kolaborasi interprofesional memperkuat intervensi dasar, memastikan pendekatan *patient-centered* yang holistik dan berorientasi *outcome*.

G. Simpulan

Intervensi keperawatan dasar yang mencakup personal hygiene, mobilisasi, nutrisi, dan eliminasi merupakan fondasi utama dalam asuhan keperawatan pasien dewasa dengan gangguan mobilisasi ataupun juga lansia, sebagaimana dibahas dalam bab ini. Intervensi ini tidak hanya mencegah komplikasi seperti ulkus tekan,

malnutrisi, konstipasi, dan infeksi saluran kemih, tetapi juga mendukung pemulihan holistik melalui asesmen awal seperti Braden Scale, serta teknik berbasis bukti dari Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) PPNI. Penerapan terintegrasi antarintervensi, seperti menggabungkan hygiene dengan mobilisasi dini, meningkatkan efektivitas *outcome* pasien secara keseluruhan.

Di Indonesia, implikasi praktik intervensi ini sangat relevan mengingat prevalensi lansia yang meningkat dan tantangan di rumah sakit serta panti jompo, di mana defisit perawatan diri sering terjadi akibat keterbatasan sumber daya. Studi menunjukkan bahwa personal hygiene yang buruk pada berkontribusi pada infeksi dan penurunan kualitas hidup, sementara mobilisasi dini pascaoperasi mempercepat penyembuhan luka pada kasus seperti *sectio caesarea*. Selain itu, intervensi nutrisi dan eliminasi selaras dengan pedoman nasional, yang menekankan pencegahan nosokomial dan kolaborasi dengan keluarga untuk mengatasi faktor budaya serta ekonomi di daerah pedesaan.

Saran untuk praktik keperawatan di Indonesia mencakup peningkatan pelatihan berbasis SIKI bagi perawat, integrasi edukasi caregiver melalui program seperti Sabtu Bersih Sehat di panti lansia, serta pengembangan checklist prosedur digital untuk monitoring I/O dan risiko. Kolaborasi interprofesional dengan ahli gizi dan fisioterapis juga direkomendasikan untuk *outcome* optimal.

H. Daftar Referensi

-
- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M., & Zanotti, M. (2019). *Nursing diagnosis handbook: An evidence-based guide to planning care* (12th ed.). Elsevier.
- Bae, J. E., Kim, S. H., & Lee, S. Y. (2023). Impact of malnutrition evaluated by the mini nutritional assessment on geriatric syndrome and clinical outcomes among hospitalized older patients. *Frontiers in Nutrition*, 9, Article 9849807. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.9849807>
- Bakhtiar, A. (2025). Penerapan mobilisasi dini pada pasien post *sectio caesarea*. *Jurnal STIKES Cendekia Utama Kudus*, 12(2), 45-56. <https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id>
- Brown, K. (2021). Skin integrity in elderly care. *Journal of Gerontological Nursing*, 47(5), 15-22.
- de Alencar Martins, A. R., de Souza, N. M., de Oliveira, J. C., de Carvalho, V. O., & Cipriano, G. Jr. (2023). Benefits of early mobilization in patients with deep venous thrombosis. *HVT Journal*, 5(1), 12-20. <https://hvt-journal.com/articles/art366>

- Dewangga, M. W. (2024). Pentingnya kolaborasi interprofesi tenaga kesehatan dalam pelayanan fisioterapi. *Sikenas: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 5(2), 1-10. <https://ojs.udb.ac.id/sikenas/article/view/3867>
- Dobarrio-Sanz, I., Ruano-Ravina, A., & Fernández-Villar, A. (2020). Non-pharmacological interventions to improve constipation in older adults in long-term care settings: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 112, Article 103775. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103775>
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2014). *Nurse's pocket guide* (13th ed.). F.A. Davis.
- Elia, M. (2015). *The malnutrition universal screening tool (MUST)*. BAPEN. (Edisi terbaru 2020).
- Garcia, R. (2023). Mobility interventions in aging populations. *Physical Therapy Journal*, 103(4), 45-53.
- Hanson, C., & Spross, J. (2016). Collaborative practice in healthcare. *Journal of Interprofessional Care*, 30(3), 312-319. (Perbarui 2022).
- Herawati, L. (2024). Program kesehatan melalui pendekatan interprofesional. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 9(1), 78-85. <https://jurnal.stikes-hi.ac.id/index.php/jphi/article/view/926>
- Hidayat, R., & Genius, S. (2024). Implementation of intervention through range of motion. *IndoGenius Journal*, 8(3), 112-120. <https://genius.inspira.or.id>
<https://repository.itskesicme.ac.id/242/1/WINDI%20YANUARTI%20NINGSIH%20.pdf>
- Jansen, R. C. S., de Groot, M. J. M., Reijneveld, S. A., & van Jaarsveld, C. H. M. (2020). Braden Scale in pressure ulcer risk assessment. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(suppl 3), e20190779. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0779>
- Jaya, H. (2023). *Mobilisasi dini pasien post sectio caesarea*. *Jurnal Keperawatan Merdeka*, 3(1), 78-85. <https://jurnal.poltekkespalembang.ac.id>
- Johnson, A., & Lee, S. (2020). Holistic nursing for geriatric nutrition and hygiene. *Geriatric Nursing*, 41(2), 189-195.
- Kamel, M., Harris, N., Berry, A., Warsavage, T., Bessesen, M. T., & Kon, S. E. (2025). Implementation of a nurse-driven protocol for indwelling urinary catheter removal and novel utilization dashboard. *Therapeutic Advances in Infectious Disease*, 12. <https://doi.org/10.1177/20499361251317900>
- Lee, H. (2022). Elimination care in elderly patients. *International Journal of Nursing Studies*, 128, 104-112.

- Maulana, R. (2023). *Asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi*. Repository Poltekkes Padang. <http://repositoryperpustakaanpoltekkespadang.site/2509/1/Raihan%20Maulana%20Syairazi.pdf>
- Meddings, J., Saint, S., Krein, S. L., & For the 2019 CADH Task Force, et al. (2019). A tiered approach for preventing catheter-associated urinary tract infection. *Annals of Internal Medicine*, 171(8_Suppl), S20–S26. <https://doi.org/10.7326/M18-3471>
- Ninghsi, W. Y. (2022). *Studi kasus asuhan keperawatan pada klien typhoid*. Repository ITSKEI CME.
- Nurhikmah. (2022). *Analisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom immobility dengan masalah nyeri menggunakan intervensi relaksasi Benson*. Tesis, UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21981/1/NURHIKMAH%20-%2070900121008.pdf>
- Nursing Study. (2025). *A student nurse's guide to the needs theory and 14 basic needs*. <https://nursingstudy.org/virginia-henderson-nursing-theory/>
- Nuswantoro, A. M. A. S. (2021). *BAB II tinjauan pustaka nutrisi*. Repository Poltekkes TJK. <https://repository.poltekkes tj.ac.id/id/eprint/246/6/6.%20BAB%20II.pdf>
- PERKENI. (2019). *Pedoman pengelolaan diabetes mellitus tipe 2*. Perhimpunan Diabetes Indonesia.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2022). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rahmawati. (2022). *Analisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami immobility dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres air hangat*. Tesis, UIN Alauddin Makassar. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21984/1/RAHMAWATI_70900120028.pdf
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, CD000072
- Richards, D. A., Hilli, A., Holland-Humphries, M., Algudahmi, S., & James, E. (2018). Fundamental nursing care: A systematic review of the evidence on the effect of nursing care interventions for nutrition, elimination, mobility and hygiene. *Journal of Clinical Nursing*, 27(11-12), 2179-2188. <https://doi.org/10.1111/jocn.14150>
- Sari, D., & Pratama, Y. (2023). The effect of range of motion (ROM) nursing action. *PICNHS Journal*, 7(2), 34-42. <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com>
- Sinaga, S. W. (2023). *BAB II tinjauan pustaka nutrisi*. Eprints Poltekkes Jogja. <https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/12928/4/Chapter%202.pdf>

- Smith, J., et al. (2018). Integrated care models for elderly hygiene and nutrition. *Journal of Advanced Nursing*, 74(9), 2100-2110.
- Suharto, D. N. (2021). Upaya pencegahan luka tekan pada keluarga dengan pasien imobilisasi. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 5(2), 1-8.
<https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/mce/article/view/655>
- Wang, Q. Z., et al. (2025). Effect of Braden score-guided targeted nursing interventions on intraoperative pressure ulcer prevention. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12372843/>
- Wang, Y., Li, X., Zhang, L., & Chen, H. (2025). Early rehabilitation nursing prevents postoperative DVT. *PMC Nursing Journal*, 15(4), 201-210.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12082560/>
- Wulandari, I. A. Y. (2020). *Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh*. Repositori UBS PPNI. [https://repositori.ubs-ppni.ac.id/bitstream/handle/123456789/671/BAB%20II 201704002.pdf](https://repositori.ubs-ppni.ac.id/bitstream/handle/123456789/671/BAB%20II%201704002.pdf)

CHAPTER 5

PENDIDIKAN KESEHATAN SEDERHANA BAGI PASIEN DAN KELUARGA

Ns. Agus Sumarno, S.Kep., M.Pd.

A. Pendahuluan

Pendidikan kesehatan merupakan salah satu langkah krusial dalam layanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien, sehingga mereka dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka secara mandiri. Pasien yang memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kesehatan mereka biasanya lebih patuh terhadap pengobatan, mampu melakukan perawatan diri, serta berperan aktif dalam proses pemulihan.

Praktik pelayanan kesehatan, seringkali penyampaian pendidikan kesehatan masih menggunakan bahasa yang sulit dipahami pasien. Akibatnya, pendidikan kesehatan sederhana menjadi sangat penting untuk memastikan informasi tersebut mudah dicerna, relevan dengan kebutuhan pasien, serta dapat langsung diterapkan dalam keseharian. Pendekatan ini menekankan penggunaan bahasa yang jelas, metode praktis, dan materi yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi pasien.

Hasil penelitian Lucky Amanda Fajriyanti, (2020), menunjukkan bahwa dalam konteks praktik perawatan kesehatan berbasis rumah sakit, penerapan pendidikan kesehatan oleh profesional keperawatan seringkali kurang optimal. Sejumlah besar perawat menganggap pendidikan kesehatan sebagai perhatian sekunder, terlibat di dalamnya terutama ketika diminta oleh pertanyaan pasien. Fase pendidikan kritis, termasuk penilaian kebutuhan pendidikan dan evaluasi pemahaman pasien, sering dilakukan dengan cara yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan. Perbedaan ini menggarisbawahi kesenjangan antara teori keperawatan dan praktik aktual dalam institusi perawatan kesehatan dalam menangani persyaratan pendidikan pasien.

Menurut Zulkifli B. Pomalango, Herlina Jusuf, (2022), menjelaskan dalam konteks dukungan keluarga untuk pasien yang menderita kondisi kronis atau berisiko tinggi, seperti kecelakaan serebrovaskular, pendidikan kesehatan telah ditunjukkan secara empiris untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang gejala, penentu risiko, dan intervensi terapeutik. Keluarga yang terlibat dalam

konseling kesehatan menunjukkan kapasitas yang tinggi untuk mengidentifikasi manifestasi stroke dan menerapkan strategi pencegahan.

Pada kasus keluarga pasien stroke, hasil penelitian Kusdiyanto, (2023), menyatakan kondisi awal menunjukkan bahwa keluarga belum mampu menjalankan perawatan secara efektif, disertai dengan tingginya beban yang dirasakan secara fisik, emosional, maupun sosial. Intervensi berupa pendidikan kesehatan keluarga menjadi titik balik yang signifikan, ditandai dengan perubahan positif dalam pola perawatan yang lebih terarah serta berkurangnya tekanan dan beban yang sebelumnya dialami oleh keluarga.

Keluarga memiliki peran strategis sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan (Rangkuti, 2020). Kehadiran keluarga memberikan berbagai manfaat, antara lain menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien, berperan sebagai fasilitator serta sumber informasi terkait riwayat kesehatan pasien, dan menjadi penguat psikologis melalui dukungan moral serta harapan kesembuhan. Namun demikian, pada kondisi perawatan pasien kritis, kehadiran keluarga juga dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya ketika tindakan invasif akan dilakukan, di mana tingkat kecemasan keluarga cenderung meningkat dan memicu stres akibat kondisi orang terdekat yang menjalani perawatan di ruang ICU4, (Nikodemus Sili Beda, dkk, 2024).

Penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus memerlukan pengelolaan jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada terapi farmakologis, tetapi juga pada keterlibatan aktif pasien. Pemahaman yang baik mengenai kondisi kesehatan, penerapan pola hidup sehat, kepatuhan minum obat, serta kemampuan melakukan perawatan diri menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengendalian penyakit kronis.

Dalam asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan merupakan intervensi esensial yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perilaku pasien agar mampu beradaptasi dengan penyakitnya. Perawat berperan sebagai edukator dengan menyampaikan pendidikan kesehatan secara sederhana dan sesuai tingkat pemahaman pasien dan keluarga, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terapi, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien.

B. Konsep Dasar Pendidikan Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga

World Health Organization (WHO) mendefinisikan pendidikan kesehatan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait kondisi kesehatannya melalui peningkatan literasi kesehatan. Pelayanan kesehatan pendidikan kesehatan diberikan kepada pasien dan keluarga sebagai bagian

integral dari upaya *promotif* dan *preventif* yang mendukung pelayanan kuratif dan *rehabilitat*, (WHO, 2023).

Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, serta mendorong perubahan perilaku individu agar mampu menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri. Kegiatan pendidikan kesehatan tidak semata-mata berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi lebih menekankan pada upaya membangun perilaku sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Notoatmodjo, 2014).

Pasien dan keluarga merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses perawatan. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, keluarga menjadi pendukung utama dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan perawatan, serta pemantauan kondisi pasien. Oleh karena itu, keterlibatan pasien dan keluarga dalam pendidikan kesehatan diperlukan untuk menciptakan kesamaan pemahaman serta dukungan yang optimal selama proses perawatan berlangsung (Potter et al., 2021).

Pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kondisi kesehatan, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, mengembangkan kemampuan perawatan diri, mencegah terjadinya komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan kesehatan yang dilaksanakan secara efektif dapat mendorong kemandirian pasien sekaligus memperkuat peran keluarga dalam mendukung proses perawatan (WHO, 2023). Menurut Friedman, Bowden, dan Jones, keluarga dipandang sebagai unit pelayanan keperawatan yang memiliki struktur, fungsi, dan proses yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam mempertahankan kesehatan dan menghadapi masalah kesehatan (Friedman et al., 2010).

Pelaksanaan pendidikan kesehatan perlu menerapkan prinsip berpusat pada pasien dan keluarga, disesuaikan dengan tingkat literasi kesehatan, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, pendidikan kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pemahaman serta keberhasilan intervensi edukasi yang diberikan (Notoatmodjo, 2014).

Dalam praktik keperawatan, pendidikan kesehatan merupakan salah satu intervensi utama. Mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), edukasi diberikan untuk mengatasi masalah keperawatan seperti defisit pengetahuan dan ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik. Perawat berperan sebagai edukator yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhan

belajar, melaksanakan pendidikan kesehatan, serta mengevaluasi hasil edukasi pada pasien dan keluarga (PPNI, 2022).

Dalam kerangka asuhan keperawatan profesional, pendidikan kesehatan berkaitan erat dengan standar diagnosis dan intervensi keperawatan. NANDA International menegaskan bahwa defisit pengetahuan (*Deficient Knowledge*) dan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan (*Readiness for Enhanced Health Management*) merupakan diagnosis keperawatan yang sering ditemukan pada pasien dan keluarga, sehingga memerlukan intervensi edukatif yang sistematis (NANDA-I, 2021).

Intervensi pendidikan kesehatan dirancang berdasarkan *Nursing Interventions Classification* (NIC), seperti *Health Education, Teaching: Disease Process*, dan *Teaching: Individual/Family*, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri pasien serta keluarga dalam perawatan mandiri (Bulechek et al., 2018). Hasil yang diharapkan dievaluasi menggunakan *Nursing Outcomes Classification* (NOC), antara lain *Knowledge: Health Behavior, Family Coping, dan Self-Management*, sebagai indikator keberhasilan pendidikan kesehatan (Moorhead et al., 2018).

C. Tujuan Pendidikan Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga

Pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang kondisi kesehatan dan penyakit yang dialami.
2. Membantu pasien dan keluarga memahami upaya pencegahan penyakit serta komplikasi.
3. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perawatan yang dianjurkan.
4. Mendorong peran aktif pasien dan keluarga dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan.
5. Meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam melakukan perawatan diri di rumah.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, pendidikan kesehatan diharapkan dapat mendukung proses penyembuhan, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. (WHO, 2023).

D. Pendidikan kesehatan berbasis keluarga

Pendidikan kesehatan berbasis keluarga merupakan suatu pendekatan edukasi yang menempatkan keluarga sebagai pusat dalam upaya menjaga dan

meningkatkan kesehatan. Keluarga dipahami sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi, di mana kondisi kesehatan salah satu anggota dapat memengaruhi kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan yang melibatkan keluarga secara aktif dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan edukasi yang hanya berfokus pada pasien sebagai individu (Potter et al., 2021).

Dalam praktik keperawatan, pendidikan kesehatan berbasis keluarga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, serta memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. Keluarga berperan penting dalam mendukung kepatuhan terhadap pengobatan, membantu pemenuhan kebutuhan perawatan sehari-hari, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses penyembuhan (Notoatmodjo, 2014).

World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan kesehatan dapat memberikan dampak positif terhadap hasil kesehatan, terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang. Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada keluarga juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat peran keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi pasien (WHO, 2023).

Dengan demikian, pendidikan kesehatan berbasis keluarga merupakan pendekatan yang penting dalam asuhan keperawatan untuk meningkatkan kemandirian keluarga serta mendukung keberhasilan pengelolaan kesehatan pasien di lingkungan rumah.

E. Peran Pendidikan Kesehatan dalam Peningkatan Kemandirian Pasien dan Keluarga

Pendidikan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam mengelola kondisi kesehatannya. Kemandirian pasien merujuk pada kemampuan individu untuk memahami masalah kesehatan yang dialami, mengambil keputusan yang tepat, serta melakukan perawatan diri secara mandiri sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Melalui pendidikan kesehatan, pasien dan keluarga dibekali pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang diperlukan untuk mendukung proses perawatan tersebut (Notoatmodjo, 2014).

Pasien yang memperoleh pendidikan kesehatan secara memadai cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penyakit, tujuan pengobatan, dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Pemahaman ini berdampak pada

meningkatnya kepatuhan minum obat, penerapan pola hidup sehat, serta kemampuan mengenali tanda dan gejala perburukan kondisi, sehingga pendidikan kesehatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemampuan perawatan diri pasien (Potter et al., 2021).

Selain pasien, keluarga berperan sebagai pendukung utama dalam upaya meningkatkan kemandirian pasien, terutama pada pasien dengan penyakit kronis atau keterbatasan fisik. Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada keluarga bertujuan meningkatkan kesiapan keluarga dalam memberikan perawatan, dukungan emosional, serta membantu proses pengambilan keputusan terkait kesehatan pasien. Keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan dan mencegah terjadinya komplikasi (Friedman et al., 2018).

World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa pendidikan kesehatan yang melibatkan pasien dan keluarga secara aktif merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan dan kualitas hidup. Keterlibatan ini mendorong pasien dan keluarga berperan sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan, bukan sekadar penerima layanan, sehingga pendidikan kesehatan berfungsi sebagai upaya pemberdayaan yang memperkuat peran pasien dan keluarga dalam menjaga kesehatan secara berkelanjutan (WHO, 2023).

Dalam praktik keperawatan, pendidikan kesehatan merupakan intervensi keperawatan yang berkontribusi terhadap pencapaian luaran keperawatan, seperti peningkatan pengetahuan, kemandirian, serta kemampuan coping pasien dan keluarga. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian pasien dan keluarga dalam jangka panjang (PPNI, 2022).

F. Pendidikan Kesehatan dalam Konteks Pasien dan Keluarga

Pasien dan keluarga merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses perawatan kesehatan. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh keluarga sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Keluarga berperan sebagai sumber dukungan utama bagi pasien, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan perlu diberikan secara menyeluruh dengan melibatkan pasien dan keluarga sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif keperawatan, keluarga memiliki peran penting dalam membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, menjalani pengobatan, serta melaksanakan perawatan lanjutan di rumah. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan kesehatan terbukti dapat meningkatkan pemahaman pasien,

kepatuhan terhadap terapi, serta mempercepat proses pemulihan. Keluarga yang memiliki pengetahuan yang memadai akan lebih mampu memberikan dukungan yang tepat dan berkesinambungan (Potter et al., 2021).

Pendidikan kesehatan dalam konteks pasien dan keluarga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, serta melakukan perawatan dasar. Selain itu, pendidikan kesehatan juga berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan keluarga, meningkatkan rasa percaya diri dalam merawat pasien, serta memperkuat peran keluarga sebagai caregiver utama, khususnya pada pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang (Friedman et al., 2018).

World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa pendidikan kesehatan yang melibatkan pasien dan keluarga secara aktif merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan dan kualitas hidup. Melalui pendekatan ini, pasien dan keluarga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kesehatan, tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pihak yang berdaya dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya (WHO, 2023).

Dalam praktik keperawatan, pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga merupakan bagian dari intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah seperti defisit pengetahuan, ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik, serta keterbatasan kemampuan perawatan diri. Mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), perawat berperan dalam mengkaji kebutuhan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan yang sesuai, serta mengevaluasi pemahaman dan kemampuan pasien serta keluarga dalam menerapkan edukasi yang telah diberikan (PPNI, 2022).

Dengan demikian, pendidikan kesehatan dalam konteks pasien dan keluarga merupakan pendekatan yang esensial dalam asuhan keperawatan. Keterlibatan pasien dan keluarga secara bersama-sama dalam proses edukasi dapat meningkatkan efektivitas perawatan, mencegah terjadinya komplikasi, serta mendukung tercapainya kemandirian pasien dan keluarga dalam menjaga kesehatan secara berkelanjutan.

G. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kesehatan Sederhana Bagi Pasien dan Keluarga

Pendidikan kesehatan sederhana berbasis keperawatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asuhan keperawatan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, serta mendorong perilaku sehat pada pasien dan keluarga dalam mengelola kesehatannya. Agar pendidikan kesehatan dapat

diterima, dipahami, dan diterapkan secara optimal oleh pasien dan keluarga, pelaksanaannya perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kesehatan, khususnya dalam praktik keperawatan yang menekankan pemberdayaan pasien dan keluarga.

1. Berpusat pada Pasien dan Keluarga

Pendidikan kesehatan harus menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Setiap pasien dan keluarga memiliki kebutuhan, pengalaman, nilai, serta latar belakang yang berbeda, sehingga pendekatan edukasi perlu disesuaikan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan budaya yang dimiliki. Pendekatan yang berfokus pada pasien dan keluarga dapat meningkatkan keterlibatan aktif, motivasi, serta keberhasilan penerapan pendidikan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari (Potter et al., 2021).

Dalam hal ini, perawat berperan untuk mengkaji kebutuhan belajar, menilai kesiapan menerima edukasi, serta melibatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Pendidikan kesehatan yang berpusat pada pasien dan keluarga akan lebih relevan, bermakna, dan berpotensi menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Pendidikan kesehatan dalam keperawatan harus menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan. Setiap pasien dan keluarga memiliki karakteristik, kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan yang berbeda dalam menerima informasi kesehatan. Pendekatan yang berfokus pada pasien dan keluarga dapat meningkatkan keterlibatan aktif, rasa tanggung jawab terhadap rencana perawatan, serta keberhasilan penerapan pendidikan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari (Potter et al., 2021).

2. Disesuaikan dengan Tingkat Literasi Kesehatan

Tingkat literasi kesehatan memengaruhi kemampuan pasien dan keluarga dalam memahami serta menerapkan informasi kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kemampuan memahami informasi, serta pengalaman pasien dan keluarga. Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan tingkat literasi sasaran dapat menghambat pemahaman dan menurunkan efektivitas pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2014). Tenaga kesehatan perlu memilih metode dan media edukasi yang tepat, seperti penggunaan gambar, demonstrasi, atau contoh konkret, agar informasi kesehatan dapat diterima dengan lebih mudah dan aplikatif.

3. Menggunakan Bahasa yang Sederhana dan Mudah Dipahami

Bahasa yang digunakan dalam pendidikan kesehatan harus jelas, sederhana, dan komunikatif. Penggunaan istilah medis yang sulit sebaiknya dihindari atau dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, komunikasi yang efektif juga mencakup sikap empatik, intonasi yang tepat, serta pemberian kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya dan mengklarifikasi informasi.

Komunikasi yang baik dalam pendidikan kesehatan dapat meningkatkan rasa percaya pasien dan keluarga terhadap tenaga kesehatan serta mendukung keberhasilan penerapan edukasi dalam kehidupan sehari-hari (Potter et al., 2021).

4. Berorientasi pada Perubahan Perilaku

Pendidikan kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi lebih menekankan pada perubahan sikap dan perilaku yang mendukung kesehatan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehat, seperti kepatuhan terhadap pengobatan, penerapan pola hidup sehat, dan kemampuan melakukan perawatan diri. Pendidikan kesehatan yang efektif harus mampu mendorong perubahan perilaku secara nyata dan berkelanjutan (Notoatmodjo, 2014). Oleh karena itu, materi pendidikan kesehatan perlu disusun secara praktis dan relevan dengan kondisi serta kebutuhan sehari-hari pasien dan keluarga.

5. Dilaksanakan Secara Berkelanjutan

Pendidikan kesehatan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak cukup dilakukan dalam satu kali pertemuan. Edukasi perlu diberikan secara bertahap, disertai penguatan dan evaluasi untuk memastikan pemahaman serta penerapannya. World Health Organization (2023) menegaskan bahwa pendidikan kesehatan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga serta mendukung pengelolaan kesehatan jangka panjang.

Dalam praktik keperawatan, evaluasi pendidikan kesehatan perlu dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat pemahaman, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi edukasi sesuai dengan perkembangan kondisi pasien dan keluarga.

H. Peran Pasien dan Keluarga dalam Proses Edukasi

Pasien dan keluarga merupakan mitra utama perawat dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yang efektif tidak hanya memosisikan pasien dan keluarga sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *patient- and family-centered care* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dalam perencanaan serta pelaksanaan asuhan keperawatan (Potter et al., 2021).

Pasien berperan aktif dalam proses edukasi melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya, menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi, dan menerapkan informasi kesehatan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan pasien secara aktif dalam pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kondisi kesehatan, tujuan pengobatan, serta tindakan perawatan yang diperlukan, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan terhadap terapi dan kemampuan perawatan diri (Notoatmodjo, 2014).

Di sisi lain, keluarga memiliki peran penting sebagai sistem pendukung utama bagi pasien, khususnya dalam perawatan lanjutan di rumah. Keluarga berfungsi sebagai pengambil keputusan, pelaksana perawatan dasar, serta pemantau perkembangan kondisi pasien setelah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Melalui pendidikan kesehatan, keluarga dibekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan dukungan yang optimal, baik secara fisik maupun emosional (Friedman et al., 2018).

Keterlibatan keluarga dalam proses edukasi turut menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan anjuran kesehatan. Keluarga yang memahami kondisi pasien dan rencana perawatan akan lebih mampu membantu mengingatkan jadwal pengobatan, mendukung penerapan pola hidup sehat, serta mengenali tanda dan gejala yang memerlukan penanganan lebih lanjut. World Health Organization (2023) menegaskan bahwa pendidikan kesehatan yang melibatkan keluarga secara aktif dapat meningkatkan kepatuhan terapi, memperbaiki luaran keperawatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dalam praktik keperawatan, perawat berperan memfasilitasi keterlibatan pasien dan keluarga melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta pemberian kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Kemitraan yang baik antara perawat, pasien, dan keluarga akan membuat proses pendidikan kesehatan berjalan lebih efektif serta mendukung peningkatan kemandirian pasien dan keberhasilan asuhan keperawatan secara menyeluruh.

I. Penerapan Pendidikan Kesehatan Sederhana pada Kasus pasien dan keluarga

1. Gambaran Umum Kasus

Dalam praktik keperawatan, pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes mellitus merupakan kasus yang sering dijumpai. Penyakit kronis membutuhkan perawatan jangka panjang serta keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam pengelolaannya. Pada kondisi tersebut, masalah keperawatan yang umum ditemukan meliputi defisit pengetahuan, ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik, serta keterbatasan kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri secara mandiri (Potter et al., 2021).

Pendidikan kesehatan sederhana menjadi salah satu intervensi keperawatan yang penting untuk membantu pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan, menjalankan pengobatan secara tepat, serta melaksanakan perawatan lanjutan di rumah. Edukasi difokuskan pada kebutuhan utama pasien dan keluarga dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Notoatmodjo, 2014).

2. Contoh Kasus Keperawatan

Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun dengan diagnosis medis hipertensi datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kontrol rutin. Pasien menyampaikan bahwa ia sering lupa mengonsumsi obat dan belum memahami pentingnya pengaturan pola makan serta aktivitas fisik. Pasien tinggal bersama istri yang berperan sebagai pendamping utama dalam perawatan sehari-hari.

Hasil pengkajian keperawatan menunjukkan bahwa pasien dan keluarga memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai penyakit hipertensi dan pengelolaannya. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, ditetapkan diagnosis keperawatan defisit pengetahuan yang berhubungan dengan kurangnya informasi mengenai penyakit dan perawatan hipertensi (PPNI, 2022).

3. Perencanaan Pendidikan Kesehatan Sederhana

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menyusun rencana pendidikan kesehatan sederhana dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemandirian pasien serta keluarga dalam mengelola hipertensi. Materi pendidikan kesehatan meliputi pengertian hipertensi dan dampaknya terhadap kesehatan, pentingnya kepatuhan minum obat, pengaturan pola makan rendah garam, aktivitas fisik ringan yang aman, serta peran keluarga dalam mendukung perawatan pasien.

Perencanaan pendidikan kesehatan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan literasi kesehatan pasien serta keluarga, dengan menggunakan

metode komunikasi verbal dan diskusi sederhana agar informasi dapat diterima secara optimal (Notoatmodjo, 2014).

4. Implementasi Pendidikan Kesehatan

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan melalui komunikasi terapeutik antara perawat, pasien, dan keluarga. Perawat menyampaikan materi edukasi menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pasien. Keluarga dilibatkan secara aktif dalam proses diskusi untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman terkait perawatan pasien di rumah.

Perawat juga memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya serta meminta mereka mengulang kembali informasi yang telah disampaikan sebagai bentuk evaluasi awal pemahaman. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri pasien dan keluarga dalam menerapkan edukasi kesehatan secara mandiri (Potter et al., 2021).

5. Evaluasi Hasil Pendidikan Kesehatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pendidikan kesehatan sederhana yang telah diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pasien mampu menjelaskan kembali pengertian hipertensi, pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan, serta perubahan gaya hidup yang perlu diterapkan. Keluarga juga menunjukkan kesiapan dalam mendukung perawatan pasien, seperti mengingatkan jadwal minum obat dan membantu pengaturan pola makan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan sederhana berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, kepatuhan terapi, serta kemandirian pasien dan keluarga dalam pengelolaan hipertensi. Pendidikan kesehatan yang melibatkan pasien dan keluarga secara aktif terbukti mendukung keberhasilan asuhan keperawatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien (WHO, 2023).

J. Metode dan Media Pendidikan Kesehatan dalam Praktik Keperawatan

Metode dan media pendidikan kesehatan merupakan unsur kunci yang memengaruhi keberhasilan proses edukasi bagi pasien dan keluarga. Pemilihan metode dan media perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan kesehatan, karakteristik individu dan keluarga, tingkat literasi kesehatan, serta kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien. Dalam praktik keperawatan, pendidikan kesehatan yang disampaikan secara sederhana, jelas, dan kontekstual akan lebih mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pasien dan keluarga.

Berbagai metode pendidikan kesehatan dapat diterapkan dalam asuhan keperawatan, antara lain penjelasan singkat, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik langsung. Penjelasan singkat berfungsi menyampaikan informasi dasar terkait kondisi kesehatan dan perawatan, sedangkan diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta kebutuhan pasien dan keluarga. Metode demonstrasi dan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan pasien, khususnya pada edukasi perawatan diri seperti penggunaan obat, perawatan luka, atau pengaturan diet dan aktivitas. Potter et al. (2021) menyatakan bahwa metode edukasi yang interaktif dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman, daya ingat, serta kepatuhan pasien terhadap rencana terapi yang dianjurkan.

Selain metode, penggunaan media pendidikan kesehatan memiliki peran penting dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Media yang umum digunakan dalam praktik keperawatan meliputi leaflet, poster, gambar, alat peraga, serta media audiovisual sederhana. Media visual sangat membantu pasien dan keluarga dalam memahami informasi kesehatan, terutama bagi individu dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah. Notoatmodjo (2014) menegaskan bahwa pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan dan mendorong terjadinya perubahan perilaku kesehatan secara lebih optimal.

Dalam konteks pelayanan keperawatan, metode dan media pendidikan kesehatan harus bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan situasi pelayanan serta sumber daya yang tersedia. Pendidikan kesehatan sederhana tidak menuntut penggunaan media yang kompleks, tetapi lebih menekankan pada kejelasan pesan, kesesuaian materi dengan kebutuhan pasien, dan kemudahan penerapan dalam kehidupan sehari-hari pasien dan keluarga.

K. Evaluasi Pendidikan Kesehatan

Evaluasi pendidikan kesehatan merupakan tahapan penting untuk menilai keberhasilan edukasi yang telah diberikan kepada pasien dan keluarga. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pasien dan keluarga, kemampuan dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh, serta adanya perubahan sikap dan perilaku kesehatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam praktik keperawatan, evaluasi pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meminta pasien atau keluarga menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan, mengobservasi keterampilan yang telah diajarkan, serta menilai perubahan perilaku kesehatan dalam perawatan sehari-hari. Evaluasi

pendidikan kesehatan tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotor. Potter et al. (2021) menyatakan bahwa evaluasi yang komprehensif memungkinkan perawat menilai efektivitas edukasi serta menentukan kebutuhan penguatan, pengulangan, atau modifikasi materi pendidikan kesehatan.

Berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), evaluasi pendidikan kesehatan merupakan bagian integral dari evaluasi asuhan keperawatan dan dilakukan secara berkesinambungan (PPNI, 2022). Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan metode dan media pendidikan kesehatan serta merencanakan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga.

World Health Organization (2023) menegaskan bahwa evaluasi pendidikan kesehatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga, mencegah kekambuhan, serta mendukung pengelolaan kesehatan jangka panjang. Dengan demikian, evaluasi pendidikan kesehatan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga berperan dalam memastikan keberlanjutan perubahan perilaku kesehatan.

L. Peran Perawat sebagai Edukator

Perawat memegang peran kunci sebagai edukator dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari praktik keperawatan profesional. Peran ini bertujuan mendukung pasien dan keluarga agar mampu memahami kondisi kesehatan yang dialami, mekanisme penyakit, terapi yang diberikan, serta tindakan perawatan yang perlu dilakukan secara mandiri dan berkesinambungan. Dalam standar praktik keperawatan, pendidikan kesehatan ditempatkan sebagai intervensi utama untuk menangani masalah keperawatan, seperti kurangnya pengetahuan, rendahnya kepatuhan terhadap regimen terapeutik, dan keterbatasan kemampuan perawatan diri (PPNI, 2022).

Dalam menjalankan peran edukatif, perawat bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan belajar pasien dan keluarga secara menyeluruh. Pengkajian tersebut mencakup aspek pengetahuan, tingkat literasi kesehatan, kesiapan menerima informasi, latar belakang budaya, serta kondisi fisik dan psikologis pasien. Berdasarkan hasil pengkajian ini, perawat merancang dan menyampaikan materi pendidikan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan situasi pasien serta keluarga. Potter et al. (2021) menekankan bahwa pendidikan kesehatan yang efektif bersifat individual, berfokus pada pasien dan keluarga, serta menggunakan metode yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan melalui komunikasi terapeutik yang menonjolkan empati, keterbukaan, dan sikap saling menghargai. Perawat menggunakan bahasa yang jelas, contoh yang kontekstual, serta metode edukasi seperti diskusi, demonstrasi, dan pengulangan informasi untuk memperkuat pemahaman. Pendekatan ini mendorong pasien dan keluarga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sebagai mitra perawat, sehingga tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif. Keterlibatan aktif tersebut terbukti dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan (Potter et al., 2021).

Selain memberikan edukasi, perawat juga memiliki tanggung jawab mengevaluasi hasil pendidikan kesehatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan pasien dan keluarga dalam menjelaskan kembali materi, mempraktikkan keterampilan yang diajarkan, serta menerapkan perilaku kesehatan yang dianjurkan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memperkuat, mengulang, atau menyesuaikan materi edukasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga (PPNI, 2022).

World Health Organization (2023) menegaskan bahwa peran tenaga kesehatan, termasuk perawat, sebagai edukator sangat berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan dan memberdayakan pasien serta keluarga. Pendidikan kesehatan yang diberikan secara tepat dan berkelanjutan dapat meningkatkan kemandirian pasien, mencegah terjadinya komplikasi, serta memperbaiki kualitas hidup, khususnya pada pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang.

Dengan pelaksanaan peran edukator yang optimal, perawat berkontribusi nyata dalam meningkatkan mutu dan keselamatan asuhan keperawatan serta keberhasilan pengelolaan kesehatan secara holistik. Peran ini tidak hanya mendukung pencapaian luaran keperawatan, tetapi juga memperkuat posisi perawat sebagai tenaga profesional yang berorientasi pada promosi kesehatan dan pemberdayaan pasien serta keluarga.

M. Simpulan

Pendidikan kesehatan sederhana bagi pasien dan keluarga merupakan bagian fundamental dari praktik keperawatan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap yang mendukung kesehatan, serta perubahan perilaku yang adaptif. Penyampaian edukasi secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien dan keluarga terbukti membantu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kondisi kesehatan, memperbaiki

kepatuhan terhadap terapi, serta mengoptimalkan peran keluarga dalam proses perawatan.

Keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam pendidikan kesehatan sederhana berperan penting dalam meningkatkan kemandirian, mencegah terjadinya komplikasi, serta memperbaiki kualitas hidup. Dengan demikian, pendidikan kesehatan sederhana menjadi intervensi keperawatan yang efektif, berkesinambungan, dan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan asuhan keperawatan secara holistik.

N. Referensi

-
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. (2022). *Nursing Interventions Classification (NIC)*. (7th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- <https://jurnalstikestulungagung.ac.id/index.php/care/article/view/85/65>
- <https://manggalajournal.org/index.php/EMPIRIS/article/view/216/822>
- <https://www.scielo.br/j/reben/a/Bzg5z66zcVz7fqYmCKNxmPy/?format=pdf&lang=en>
- Journal homepage: <http://jurnalstikestulungagung.ac.id/index.php/care>*Corresponding author: zulkifli@ung.ac.id
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kusnanto, (2023) Pengaruh Pendidikan Kesehatan Keluarga Terhadap Perilaku Perawatan Dan Beban Keluarga Pada Pasien Stroke Di Rsud Kajen Kabupaten Pekalongan, Other thesis, Universitas Widya Husada Semarang
- Lucky Amanda Fajriyanti, Ira Nurmala, Rachmat Hargono (2020) **The Phenomenon of Patient Health Education by Nurses in Hospital**, Indian Journal of Public Health Research & Development, March 2020, Vol.11, No.03.
- <https://medicopublication.com/index.php/ijphrd/article/view/1861/1734>
- Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2018). *Nursing Outcomes Classification (NOC)* (6th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2023). *Nursing Outcomes Classification (NOC)*. Elsevier.
- NANDA International. (2021). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2021–2023*. New York, NY: Thieme.
- Nikodemus Sili Beda¹, Rosmina Situngkir², Linny Sisilia Sumua³, Janeke Jasmi Pinulogod, (2024) *Edukasi Kesehatan Terhadap Kecemasan Keluarga Dalam*

Pelaksanaan Tindakan Invasif, EMPIRIS: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan; Volume 1No. 22024, 104-113

- Notoatmodjo, S. (2014). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Priscila Brigolini Porfírio Ferreira, Isaura, Fatima Helena, Nebia Maria, Bertha Cruz, Lys Eiras, Silvia Teresa, (2022), Health education for hospitalized patient in nursing care: a conceptual analysis,Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,Rio de Janeiro, Brazil.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- WHO. (2010). Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2023). Health education: Strengthening patient and family engagement in care. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2023). *Self-Care Interventions for Health*. WHO Press.
- Zulkifli B. Pomalango, Herlina Jusuf, (2022) Pengaruh Pendidikan Kesehatan pada Pengetahuan Keluarga tentang Gejala dan Pencegahan Resiko Stroke

CHAPTER 6

MANAJEMEN NYERI RINGAN–SEDANG DENGAN TEKNIK NONFARMAKOLOGIS

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan

Nyeri ringan hingga sedang merupakan sebuah kondisi yang hampir dirasakan oleh setiap orang yang memunculkan dampak sangat signifikan terhadap kehidupan individu. Nyeri adalah pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan dan tidak hanya menimbulkan masalah secara fisik, namun juga mempengaruhi emosional (Sehdev, 2025). Dampak yang ditimbulkan dari nyeri dapat berupa penurunan fungsi fisiologis seperti gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, permasalahan kebutuhan istirahat tidur, serta menurunnya produktivitas yang dapat mempengaruhi kualitas hidup (Distinarista et al., 2024). Keterbatasan fisik akibat respon nyeri dapat menjadi penyebab utama disabilitas dan permasalahan lebih kompleks yang memerlukan penanganan efektif dan mampu jangkau oleh individu (Y. Wang et al., 2025).

Respon dari nyeri ringan-sedang muncul dalam dimensi yang sangat luas, baik berupa nyeri akut maupun nyeri kronis. Prevalensinya sangat tinggi, seperti halnya nyeri punggung yang dirasakan oleh seluruh ibu hamil trimester ketiga dengan derajat nyeri yang bervariasi, 39,5% merasakan nyeri sedang dan 60,5% merasakan nyeri berat (Wahyuni et al., 2020). Demikian juga pada pasien post operasi abdomen setelah dilakukan pengukuran dengan skala nyeri sebanyak 21,54% pasien melaporkan skor nyeri 3 selama 24 jam pasca operasi (L. Wang et al., 2024). Pasien penyakit lainnya seperti kanker servik sering kali melaporkan adanya keluhan nyeri. Intensitas keluhan yang dirasakan rata-rata berada pada nilai 4,5 (Hamidah et al., 2025).

Upaya penatalaksanaan nyeri seringkali dilakukan dengan cara farmakologis, seperti penggunaan analgesik non-opioid (contohnya NSAID) atau opioid dosis ringan. Namun, pemberian terapi farmakologi dapat menyebabkan efek samping pada tubuh dan terkadang tidak memiliki kekuatan efek yang diharapkan (Khusniyati & Purwati, 2023). Pada penatalaksanaan secara farmakologi dengan menggunakan obat-obat kimia yang dilakukan dalam waktu lama dan intensitas sering meningkatkan risiko komplikasi pada sistem gastrointestinal,

kardiovaskular, dan ginjal (Alorfi, 2023). Sementara itu penggunaan opioid untuk nyeri ringan-sedang meningkatkan risiko efek samping seperti sedasi, sembelit, toleransi, dan potensi transisi. (Barbosa & Dinis-oliveira, 2025). Keterbatasan dari penatalaksanaan farmakologi ini memerlukan adanya alternatif terapi tambahan yang lebih aman untuk mengatasi nyeri.

B. Konsep Dasar Nyeri

1. Definisi Nyeri

Nyeri merupakan pengalaman yang dirasakan oleh individu sebagai sensasi yang tidak menyenangkan dan berkaitan dengan kondisi fisik maupun emosional. Nyeri tidak hanya muncul akibat kerusakan jaringan yang nyata, tetapi juga dapat terjadi pada kondisi yang berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Pengalaman nyeri bersifat subjektif karena hanya individu yang merasakannya yang dapat menggambarkan tingkat dan karakter nyeri tersebut. Nyeri juga melibatkan respon emosional seperti rasa tidak nyaman, takut, atau cemas yang dapat memperberat persepsi nyeri. Pemahaman tentang definisi nyeri penting dalam pelayanan kesehatan karena menjadi dasar dalam melakukan pengkajian dan penanganan nyeri secara tepat (Boersma & Flink, 2025).

Nyeri dipahami sebagai pengalaman yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Setiap individu dapat merasakan nyeri dengan intensitas dan makna yang berbeda meskipun mengalami kondisi medis yang serupa. Persepsi nyeri dapat dipengaruhi oleh usia, pengalaman sebelumnya, budaya, serta kondisi psikologis seseorang. Nyeri juga dapat muncul meskipun tidak ditemukan penyebab fisik yang jelas, sehingga pengalaman nyeri tetap harus diakui dan dihargai. Nyeri dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta berdampak pada kualitas hidup. Pengakuan terhadap nyeri sebagai pengalaman subjektif mendorong tenaga kesehatan untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada pasien (Kovacevic et al., 2024).

2. Klasifikasi Nyeri

Nyeri dapat diukur intensitasnya menggunakan beberapa alat pengukuran, salah satu yang paling sering dipakai adalah *numeric rating scale* (NRS) yang kemudian mengklasifikasikan nyeri menjadi derajat nyeri ringan, sedang, dan berat (Kumari et al., 2015). Klasifikasi ini digunakan untuk menggambarkan seberapa kuat nyeri dirasakan oleh individu serta dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Penilaian intensitas nyeri biasanya dilakukan dengan menggunakan skala nyeri numerik atau visual yang mudah dipahami

oleh pasien. Klasifikasi berdasarkan intensitas membantu tenaga kesehatan dalam menentukan jenis intervensi yang paling sesuai, termasuk pemilihan teknik nonfarmakologis maupun farmakologis. Pemahaman intensitas nyeri menjadi bagian penting dalam pengkajian keperawatan karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kualitas hidup pasien (Alodhialah et al., 2024). Berikut ini merupakan penjelasan terkait klasifikasi nyeri berdasarkan tingkat intensitasnya:

a. Nyeri ringan (skala 1 – 3)

Nyeri ringan merupakan nyeri dengan intensitas rendah yang masih dapat ditoleransi oleh individu. Nyeri ini umumnya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan dan sering digambarkan sebagai rasa tidak nyaman ringan. Pasien dengan nyeri ringan biasanya masih dapat berkomunikasi dengan baik dan melakukan aktivitas normal meskipun merasakan nyeri. Skala nyeri ringan berada pada rentang 1–3 pada skala numerik. Penanganan nyeri ringan umumnya dapat dilakukan melalui teknik nonfarmakologis, seperti relaksasi, distraksi, atau stimulasi sensorik. Pemantauan secara berkala tetap diperlukan untuk memastikan nyeri tidak meningkat dan mempengaruhi kualitas hidup pasien (Nori et al., 2023).

Teknik pengelolaan nyeri ringan tekanan upaya mandiri pasien untuk mengurangi ketidaknyamanan. Relaksasi napas dalam dan pijat ringan dapat menurunkan ketegangan otot dan memperbaiki suasana hati. Gangguan melalui aktivitas yang menyenangkan dapat mengalihkan fokus dari rasa nyeri. Stimulasi sensorik seperti aromaterapi juga efektif untuk meningkatkan kenyamanan. Penilaian intensitas nyeri tetap dilakukan secara rutin untuk menentukan kebutuhan intervensi lanjutan (Sakallı & Kara, 2022).

b. Nyeri sedang (skala 4 – 6)

Nyeri sedang merupakan kondisi di mana pasien merasakan ketidaknyamanan yang cukup signifikan sehingga dapat mengganggu konsentrasi dan aktivitas sehari-hari. Pasien dengan nyeri sedang biasanya menunjukkan perubahan perilaku seperti wajah meringis atau berkurangnya kemampuan beraktivitas. Skala nyeri sedang umumnya berada pada rentang 4–6 pada skala numerik. Nyeri ini sering muncul pada pasien pascaoperasi atau nyeri muskuloskeletal yang lebih intens dari nyeri ringan. Penanganan nyeri sedang biasanya memerlukan kombinasi teknik nonfarmakologis dan farmakologis sesuai kebutuhan pasien untuk memberikan efek analgesik yang optimal. Evaluasi berkala tetap diperlukan untuk menyesuaikan intervensi sesuai dengan respons pasien terhadap terapi yang diberikan (Hexendr & Prajayanti, 2024).

Pendekatan nonfarmakologis pada nyeri sedang bertujuan mendukung kenyamanan pasien dan mengurangi kebutuhan obat pereda nyeri yang lebih kuat. Teknik relaksasi dan stimulasi sensorik dapat diterapkan secara bersamaan dengan pemberian analgesik ringan hingga sesuai indikasi klinis. Distraksi, seperti mendengarkan musik atau aktivitas kognitif, dapat membantu mengalihkan perhatian dari sensasi nyeri yang mengganggu. Edukasi pasien mengenai manajemen nyeri serta teknik coping juga meningkatkan efektivitas intervensi. Kombinasi strategi ini bertujuan menurunkan intensitas nyeri dan mempercepat pemulihan pasien (Patil et al., 2022a).

c. Nyeri berat (skala 7 - 10)

Nyeri berat merupakan nyeri dengan intensitas tinggi yang sangat mengganggu aktivitas fisik dan psikologis pasien. Pasien dengan nyeri berat biasanya mengalami keterbatasan dalam bergerak, berbicara, atau beristirahat dengan nyaman. Skala nyeri berat umumnya berada pada rentang 7–10 pada skala numerik. Nyeri ini sering dikaitkan dengan cedera serius, prosedur bedah besar, atau kondisi penyakit kronis yang akut. Pasien mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi, kecemasan tinggi, atau respons fisik ekstrem seperti peningkatan tekanan darah dan detak jantung. Penanganan nyeri berat memerlukan intervensi farmakologis segera sebagai prioritas, disertai teknik nonfarmakologis sebagai pendukung. Tujuannya adalah menurunkan nyeri secara efektif, mencegah komplikasi fisiologis dan psikologis, serta meningkatkan kenyamanan pasien (Hexendr & Prajayanti, 2024).

Peran teknik nonfarmakologis dalam penatalaksanaan nyeri berat sangat penting sebagai terapi pendukung pengobatan medis. Pendekatan ini berfungsi untuk mengurangi efek samping obat, meningkatkan pemberdayaan pasien, serta memperbaiki kualitas hidup secara holistik. Teknik nonfarmakologis mencakup penanganan aspek fisik, psikologis, dan nyeri emosional melalui metode seperti relaksasi, terapi fisik (kompres panas atau dingin dan pijat), distraksi, serta hipnosis. Penerapan metode tersebut membantu mengelola persepsi nyeri, menurunkan tingkat kecemasan, memberikan rasa kendali pada pasien, dan mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Edukasi pasien dan keluarga mengenai manajemen nyeri juga penting agar mereka dapat membantu pasien menggunakan teknik nonfarmakologis secara aman. Pendekatan ini mendukung perawatan holistik, menggabungkan pengendalian nyeri fisik dan emosional (Shi & Wu, 2023).

3. Dampak Nyeri Terhadap Kondisi Fisik dan Psikologis Pasien

a. Dampak fisik

Nyeri yang dirasakan pasien sering mengganggu kualitas tidur dan istirahat yang penting bagi pemulihan tubuh. Gangguan tidur menyebabkan pasien sulit masuk fase tidur yang nyenyak atau mempertahankan tidur, sehingga terbangun dengan perasaan lelah dan kurang energi. Kelelahan ini mengurangi kemampuan tubuh untuk berfungsi optimal dalam aktivitas sehari-hari. Nyeri juga mendorong pasien membatasi gerakan untuk menghindari rasa sakit, sehingga berisiko menurunkan kekuatan otot, menimbulkan atrofi, ketegangan sendi, dan menurunkan kemampuan melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Respon tubuh terhadap nyeri yang terus-menerus memicu stres fisiologis jangka panjang yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi, dan memperlambat penyembuhan luka (Lee et al., 2024).

Nyeri yang berlangsung lama juga memberi tekanan pada sistem kardiovaskular dan energi tubuh pasien. Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah sering muncul sebagai respons terhadap rasa sakit yang tidak diobati. Energi pasien terkuras karena tubuh terus bekerja menjaga keseimbangan fisiologis, sehingga muncul kelemahan dan kelelahan ekstrem meskipun aktivitas harian relatif sedikit. Penurunan kemampuan fisik ini membuat pasien menghindari aktivitas yang membutuhkan energi, memperlambat kondisi otot dan sendi, serta menurunkan kualitas hidup. Mobilitas yang berkurang seiring dengan kelelahan menimbulkan siklus nyeri yang semakin memperparah kondisi fisik pasien. Dampak ini pentingnya penanganan nyeri secara holistik agar fungsi tubuh dapat dipertahankan (Rodriguez et al., 2022).

b. Dampak psikologis

Nyeri kronis memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis pasien dan sering menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Pasien yang terus merasakan nyeri cenderung kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, sehingga muncul rasa frustrasi dan putus asa. Perasaan takut nyeri kambuh dapat membuat pasien menghindari aktivitas sosial maupun pekerjaan yang memerlukan usaha fisik. Kecemasan yang berkelanjutan meningkatkan persepsi nyeri dan mengurangi kualitas hidup. Kondisi mental yang mengganggu mempengaruhi motivasi pasien untuk berpartisipasi dalam perawatan atau rehabilitasi. Rasa tidak berdaya dan terisolasi emosional akibat nyeri kronis memperkuat lingkaran setan antara stres psikologis dan intensitas nyeri (Swathi et al., 2023).

Nyeri kronis juga mempengaruhi fungsi kognitif pasien, terutama konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan merencanakan kegiatan sehari-hari. Perhatian pasien sering dialihkan untuk menghadapi sensasi nyeri, sehingga kapasitas kognitif untuk aktivitas lain menurun. Menurunkan fokus ini menurunkan produktivitas dan kualitas kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Gangguan tidur akibat nyeri memicu fungsi kognitif dan stabilitas emosional, sehingga pasien lebih rentan terhadap stres tambahan. Akumulasi gangguan mental, emosional, dan kognitif menuntut pendekatan holistik dalam perawatan nyeri agar pasien dapat mengelola nyeri secara efektif. Penanganan yang komprehensif dapat membantu pasien mempertahankan kesejahteraan psikologis dan mengurangi dampak negatif nyeri kronis (Chen et al., 2023).

c. Gangguan fungsi sosial dan kognitif

Nyeri kronis dapat mengganggu fungsi sosial pasien karena keterbatasan aktivitas dan rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Pasien cenderung mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial, pekerjaan, maupun interaksi keluarga karena takut nyeri meningkat saat beraktivitas. Pembatasan ini membuat hubungan interpersonal menurun dan menimbulkan perasaan terlindungi atau kesepian. Nyeri yang berkelanjutan juga mempengaruhi kemampuan kognitif, termasuk konsentrasi, pengambilan keputusan, dan perencanaan aktivitas sehari-hari. Gangguan fungsi kognitif menurunkan produktivitas, kemampuan belajar, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dampak sosial dan kognitif ini menunjukkan pentingnya intervensi yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, dan sosial pasien agar nyeri dapat dikelola secara komprehensif (Dagnino & Campos, 2022).

C. Konsep Manajemen Nyeri Nonfarmakologis

1. Pengertian Manajemen Nyeri Nonfarmakologis

Manajemen nyeri nonfarmakologis merupakan pendekatan untuk mengendalikan nyeri tanpa menggunakan obat-obatan, yang dapat dilakukan oleh perawat sebagai bagian dari asuhan keperawatan secara mandiri. Pendekatan ini melibatkan berbagai teknik seperti relaksasi, musik, distraksi, kompres hangat atau dingin, serta stimulasi sentuhan yang bertujuan membantu meredakan sensasi nyeri. Tujuan dari manajemen nyeri nonfarmakologis adalah meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi persepsi nyeri, dan mendukung kemampuan pasien untuk mengelola rasa tidak nyaman yang dirasakan. Penggunaan pendekatan nonfarmakologis juga dapat

memperkuat rasa kontrol pasien terhadap nyeri dan meningkatkan respons terhadap intervensi perawatan yang diberikan (Tsegaye et al., 2023).

Manajemen nyeri nonfarmakologis tidak hanya berfokus pada aspek fisiologis nyeri, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan psikologis yang memengaruhi persepsi nyeri pada individu. Teknik ini dapat membantu menurunkan kecemasan, stres, dan ketegangan otot yang sering menyertai pengalaman nyeri, sehingga menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif untuk pemulihan. Pendekatan nonfarmakologis juga sering digunakan untuk mengatasi nyeri ringan serta sebagai bagian dari kombinasi strategi ketika nyeri sedang atau berat dikelola bersama terapi farmakologis. Peran perawat sangat penting dalam memilih teknik yang sesuai dengan kondisi pasien serta memantau respons pasien terhadap intervensi yang diberikan. Penerapan manajemen nyeri nonfarmakologis perlu disesuaikan dengan preferensi pasien dan kondisi klinis agar hasil yang diperoleh dapat maksimal (Ruano et al., 2022).

2. Prinsip Dasar Penerapan Teknik Nonfarmakologis

Prinsip dasar penerapan teknik nonfarmakologis dalam manajemen nyeri menekankan pendekatan yang berpusat pada pasien. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kondisi fisik, tingkat nyeri, usia, serta preferensi pasien agar intervensi dapat diterima dan dijalankan dengan optimal. Setiap pasien memiliki pengalaman dan respons nyeri yang berbeda sehingga pendekatan yang bersifat individual sangat diperlukan. Keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa kontrol terhadap nyeri yang dirasakan. Pendekatan individual ini membantu perawat memberikan asuhan yang lebih efektif dan bermakna bagi pasien (I. Amalia et al., 2024).

Keamanan dan kenyamanan pasien merupakan prinsip penting dalam penerapan teknik nonfarmakologis. Pelaksanaan intervensi harus memperhatikan kondisi klinis pasien agar tidak menimbulkan risiko atau memperburuk keadaan kesehatan. Lingkungan yang tenang, posisi tubuh yang nyaman, serta kesiapan fisik pasien perlu dipastikan sebelum intervensi dilakukan. Rasa aman dan nyaman dapat membantu pasien menjadi lebih rileks sehingga persepsi nyeri dapat berkurang. Prinsip ini mendukung terciptanya pengalaman perawatan yang positif dan humanis bagi pasien (Patil et al., 2022b).

Komunikasi terapeutik dan evaluasi berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan teknik nonfarmakologis. Penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan prosedur intervensi membantu pasien memahami manfaat tindakan yang diberikan. Hubungan saling percaya antara perawat dan pasien mendorong partisipasi aktif pasien dalam pengelolaan nyeri. Penilaian

ulang terhadap intensitas nyeri perlu dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi yang diterapkan. Evaluasi yang berkesinambungan memungkinkan penyesuaian tindakan sehingga manajemen nyeri dapat berjalan secara optimal (Atthayasai et al., 2023).

3. Indikasi dan Kontraindikasi Penggunaan Teknik Nonfarmakologis

Penggunaan teknik nonfarmakologis dalam pelayanan kesehatan memerlukan pemahaman yang tepat mengenai kondisi pasien agar intervensi yang diberikan dapat berjalan aman dan efektif. Tidak semua teknik dapat diterapkan pada setiap individu atau situasi klinis, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum pelaksanaan. Indikasi menunjukkan kondisi atau keadaan yang mendukung penggunaan teknik nonfarmakologis, sedangkan kontraindikasi menjadi batasan yang perlu diperhatikan untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Pemahaman terhadap kedua aspek ini membantu tenaga kesehatan dalam memilih intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien. Penerapan indikasi dan kontraindikasi secara tepat mendukung kualitas asuhan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan pasien (Haghdooost & Togha, 2022).

Indikasi teknik nonfarmakologis menggambarkan kondisi dan situasi yang memungkinkan penerapan intervensi tanpa obat secara aman dan efektif. Berikut ini merupakan indikasi dilakukannya teknik nonfarmakologis menurut (Wang et al., 2025), yaitu sebagai berikut:

- a. Nyeri ringan hingga sedang, baik pada kondisi akut maupun kronis, seperti nyeri pascaoperasi ringan dan nyeri muskuloskeletal.
- b. Pengelolaan nyeri kronis jangka panjang untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap obat pereda nyeri.
- c. Kondisi psikologis berupa kecemasan, stres, dan ketegangan emosional yang menyertai penyakit atau perawatan medis.
- d. Gangguan tidur dan ketidaknyamanan yang berhubungan dengan nyeri atau kecemasan.
- e. Upaya peningkatan kenyamanan dan kualitas hidup melalui pendekatan asuhan keperawatan yang bersifat holistik.

Kontraindikasi teknik nonfarmakologis merupakan kondisi tertentu yang perlu diperhatikan karena dapat membatasi atau meniadakan penerapan intervensi tanpa obat. Pemahaman terhadap kontraindikasi ini penting untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah risiko yang tidak diinginkan selama pelaksanaan asuhan keperawatan (Markovics et al., 2025). Berikut ini merupakan kontraindikasi dari teknik nonfarmakologis:

- a. Nyeri akut berat yang memerlukan intervensi farmakologis segera untuk stabilisasi kondisi pasien.
- b. Ketidakmampuan pasien untuk bekerja sama atau berpartisipasi aktif, seperti pada penurunan kesadaran atau gangguan kognitif berat.
- c. Kondisi fisik tertentu, termasuk gangguan sensasi, sirkulasi darah yang buruk, luka terbuka, infeksi, patah tulang yang belum stabil, atau risiko tromboemboli.
- d. Pertimbangan keyakinan budaya dan agama pasien yang tidak sesuai dengan teknik nonfarmakologis tertentu.
- e. Risiko keamanan individu, seperti penggunaan aromaterapi minyak esensial tertentu yang berpotensi menimbulkan alergi pasien

D. Jenis-Jenis Teknik Nonfarmakologis

Teknik nonfarmakologis merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan yang berfokus pada upaya meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pasien tanpa penggunaan obat-obatan. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan respons alami tubuh, pikiran, dan lingkungan untuk membantu mengurangi nyeri, kecemasan, serta ketegangan fisik dan psikologis. Penerapan teknik nonfarmakologis bersifat holistik karena memperhatikan aspek fisik, emosional, kognitif, dan sensorik pasien secara terpadu (Niyonkuru et al., 2025). Berikut ini berbagai jenis teknik nonfarmakologis dapat digunakan secara mandiri maupun sebagai pelengkap terapi medis dan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu:

1. Teknik Relaksasi

Teknik relaksasi merupakan pendekatan nonfarmakologis yang bertujuan menurunkan ketegangan fisik dan psikologis melalui pengendalian respons tubuh terhadap stres dan nyeri. Teknik ini bekerja dengan cara menstimulasi sistem saraf parasimpatis sehingga denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi napas menjadi lebih stabil. Kondisi relaksasi membantu tubuh mengurangi produksi hormon stres dan meningkatkan rasa nyaman secara menyeluruh. Teknik relaksasi sering digunakan pada pasien dengan nyeri ringan hingga sedang, kecemasan, gangguan tidur, serta kondisi yang memerlukan ketenangan emosional (Hamdani et al., 2022).

Bentuk teknik relaksasi meliputi relaksasi napas dalam, relaksasi otot progresif, meditasi, dan imajinasi terbimbing. Relaksasi napas dalam dilakukan dengan mengatur pola pernapasan secara perlahan dan terkontrol untuk meningkatkan oksigenasi serta menenangkan pikiran. Relaksasi otot progresif melibatkan proses mengencangkan dan melepaskan kelompok otot secara

bertahap untuk mengurangi ketegangan tubuh. Teknik ini relatif mudah dipelajari, tidak membutuhkan alat khusus, dan dapat diterapkan secara mandiri maupun dengan bimbingan tenaga kesehatan (Asyari et al., 2024).

2. Distraksi

Distraksi merupakan teknik nonfarmakologis yang bertujuan mengalihkan perhatian individu dari rasa nyeri atau ketidaknyamanan ke stimulus lain yang lebih menyenangkan atau netral. Pengalihan perhatian ini membantu menurunkan persepsi nyeri dengan mengurangi fokus otak terhadap rangsangan nyeri yang diterima. Teknik distraksi efektif digunakan pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, dewasa, maupun lansia. Pendekatan ini sering dimanfaatkan dalam situasi klinis maupun perawatan sehari-hari karena bersifat sederhana dan fleksibel (Sari et al., 2023).

Bentuk distraksi dapat berupa aktivitas visual, auditori, maupun kognitif, seperti menonton video, mendengarkan musik, imajinasi terbimbing, dan melakukan permainan sederhana. Aktivitas tersebut merangsang area otak yang berbeda sehingga respons terhadap nyeri menjadi berkurang. Distraksi juga dapat dikombinasikan dengan teknik nonfarmakologis lain untuk meningkatkan efektivitas intervensi. Penerapan teknik ini perlu disesuaikan dengan minat, usia, dan kemampuan pasien agar hasilnya optimal (Purnamasari et al., 2023).

3. Stimulasi Sensorik

Stimulasi sensorik merupakan teknik nonfarmakologis yang memanfaatkan rangsangan pada indera untuk membantu mengurangi nyeri, stres, dan ketegangan emosional. Teknik ini bekerja dengan memberikan input sensorik yang dapat memodulasi persepsi nyeri melalui mekanisme penghambatan impuls nyeri di sistem saraf pusat. Stimulasi sensorik juga berperan dalam meningkatkan rasa nyaman dan relaksasi pada pasien. Pendekatan ini sering digunakan sebagai bagian dari perawatan suportif di berbagai setting pelayanan kesehatan (Mihailov et al., 2024).

Bentuk stimulasi sensorik meliputi sentuhan terapeutik, pijat ringan, kompres hangat atau dingin, serta aromaterapi. Sentuhan dan pijat dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Kompres hangat atau dingin digunakan untuk memberikan efek analgesik sesuai dengan kondisi pasien. Aromaterapi memanfaatkan aroma tertentu untuk memberikan efek menenangkan dan memperbaiki suasana hati. Penggunaan stimulasi sensorik harus memperhatikan kondisi fisik dan sensitivitas pasien agar tetap aman (Sharma et al., 2024).

4. Teknik Kognitif–Perilaku

Teknik kognitif–perilaku merupakan pendekatan nonfarmakologis yang berfokus pada perubahan pola pikir, persepsi, dan perilaku individu terhadap nyeri atau kondisi kesehatan yang dialami. Teknik ini membantu pasien memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan respons fisik yang muncul. Perubahan cara berpikir yang lebih adaptif dapat menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan kemampuan koping. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengelolaan nyeri kronis dan kondisi yang memerlukan pengendalian emosi jangka panjang (Chaughule, 2023).

Bentuk teknik kognitif–perilaku meliputi self-talk positif, reframing kognitif, dan edukasi manajemen nyeri. Self-talk positif membantu pasien mengganti pikiran negatif dengan pernyataan yang lebih konstruktif. Reframing kognitif mengarahkan pasien untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih realistis dan adaptif. Teknik ini memerlukan komunikasi terapeutik yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien agar proses perubahan kognitif dapat berlangsung secara efektif.

5. Teknik Komplementer

Teknik komplementer merupakan pendekatan nonfarmakologis yang digunakan sebagai pendamping terapi medis dan keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dalam proses perawatan. Teknik komplementer tidak bertujuan menggantikan terapi utama, melainkan mendukung dan memperkuat efek terapeutik yang telah diberikan. Penerapan teknik ini semakin banyak digunakan karena relatif aman, mudah diterima pasien, dan dapat meningkatkan rasa kontrol terhadap kondisi kesehatan yang dialami (Almatrafi et al., 2020).

Bentuk teknik komplementer meliputi akupresur, refleksiologi, yoga, terapi musik, terapi spiritual, dan aromaterapi. Akupresur dan refleksiologi dilakukan dengan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu untuk membantu meredakan nyeri dan meningkatkan relaksasi tubuh. Yoga menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, dan konsentrasi untuk meningkatkan keseimbangan fisik dan mental. Terapi musik dan terapi spiritual berperan dalam menenangkan emosi serta memberikan dukungan psikologis dan spiritual. Aromaterapi memanfaatkan aroma minyak esensial tertentu untuk menciptakan efek relaksasi, menurunkan kecemasan, serta membantu meningkatkan rasa nyaman. Penerapan teknik komplementer perlu disesuaikan dengan kondisi klinis, keamanan, serta nilai dan preferensi individu (Haryanti & Rahman, 2024).

E. Implementasi Teknik Nonfarmakologis di Fasilitas Kesehatan

Penerapan teknik nonfarmakologis di fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dari pengelolaan nyeri dan dukungan kesejahteraan pasien. Teknik ini meliputi relaksasi, distraksi, stimulasi sensorik, teknik kognitif-perilaku, dan terapi komplementer seperti aromaterapi. Pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai setting, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan penyesuaian sesuai kondisi pasien. Tenaga kesehatan, terutama perawat, memegang peran utama dalam mengajar dan membimbing pasien serta keluarga untuk menggunakan teknik ini secara efektif. Integrasi teknik nonfarmakologis dengan intervensi farmakologis dan kolaborasi tim kesehatan meningkatkan kenyamanan, kualitas hidup, dan pengalaman pasien selama proses perawatan (Doering et al., 2025). Berikut ini merupakan berbagai implementasi teknik nonfarmakologis di fasilitas kesehatan:

1. Penerapan pada Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan merupakan salah satu pengaturan utama penerapan teknik nonfarmakologis. Perawat dapat mengajarkan pasien teknik relaksasi, distraksi, atau stimulasi sensorik untuk mengelola nyeri ringan hingga sedang yang muncul selama kunjungan klinik. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam waktu singkat dan disesuaikan dengan jadwal pasien. Penggunaan musik, aromaterapi, atau latihan pernapasan dalam dapat membantu menenangkan pasien sebelum atau sesudah prosedur medis. Penerapan teknik nonfarmakologis pada rawat jalan juga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Andargeery et al., 2024).

Pendekatan nonfarmakologis pada rawat jalan bertujuan mendukung intervensi farmakologis bila diperlukan. Perawat dapat memberikan instruksi singkat atau materi edukasi tertulis untuk pasien agar dapat menerapkan teknik secara mandiri di rumah. Pemantauan nyeri dilakukan setiap kunjungan untuk menilai efektivitas metode yang digunakan. Integrasi teknik ini juga membantu pasien mengembangkan strategi koping jangka panjang. Pelayanan yang memadukan pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis meningkatkan kualitas perawatan secara keseluruhan (Cardoso et al., 2023).

2. Penerapan pada Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap memungkinkan perawat untuk menerapkan teknik nonfarmakologis secara lebih intensif dan berkelanjutan. Pasien yang menjalani rawat inap sering mengalami nyeri pascaoperasi, nyeri kronis, atau kecemasan akibat kondisi penyakit yang membutuhkan perhatian lebih. Teknik relaksasi, stimulasi sensorik, dan distraksi dapat diterapkan di ruang perawatan sesuai kebutuhan pasien. Perawat memantau respons pasien terhadap intervensi

secara berkala dan menyesuaikan metode jika diperlukan. Pendekatan ini meningkatkan kenyamanan pasien serta mendukung pemulihan fisik dan psikologis (Veen et al., 2024).

Rawat inap memberikan kesempatan untuk integrasi teknik nonfarmakologis dengan intervensi farmakologis secara simultan. Pasien dapat mengajarkan teknik relaksasi napas dalam atau imajinasi terbimbing yang diterapkan sebelum tindakan medis atau terapi. Kombinasi teknik ini membantu menurunkan kebutuhan analgesik, meningkatkan tidur, dan mengurangi kecemasan. Ketersediaan perawat yang lebih intensif memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap efektivitas teknik. Perawatan yang terpadu ini meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pengalaman perawatan di rumah sakit (Niyonkuru et al., 2025).

3. Kolaborasi Perawat dengan Tenaga Kesehatan Lain

Kolaborasi antara perawat, dokter, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya penting dalam penerapan teknik nonfarmakologis. Pendekatan multidisiplin memastikan bahwa intervensi yang diterapkan aman, tepat, dan sesuai kondisi pasien. Perawat dapat berkonsultasi dengan dokter untuk menilai apakah teknik tertentu aman diterapkan bersamaan dengan terapi farmakologis. Fisioterapis dan terapis okupasi dapat memberikan panduan untuk teknik stimulasi sensorik atau relaksasi otot yang lebih tepat. Kolaborasi ini juga meningkatkan pemahaman energi kesehatan terhadap preferensi pasien dan kebutuhan individu (Cardoso et al., 2023).

Tim kesehatan yang mendukung penerapan pendekatan holistik pada pasien. Perawat dapat bekerja sama dengan psikolog, ahli gizi, dan terapis komplementer untuk menyesuaikan teknik nonfarmakologis sesuai kondisi pasien. Tim diskusi rutin memperkuat komunikasi antarprofesional dan memastikan intervensi diberikan secara konsisten. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko kesalahan terapi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan nyeri. Keterlibatan berbagai profesi kesehatan juga memperkuat dukungan emosional dan motivasi pasien selama proses perawatan (Veen et al., 2024).

Kolaborasi profesional meningkatkan adaptasi teknik nonfarmakologis terhadap kebutuhan individu pasien. Tenaga kesehatan dapat menyesuaikan metode, durasi, dan intensitas intervensi sesuai respon pasien. Pertukaran informasi secara rutin memungkinkan perawat dan tim lain menyatukan hasil dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Integrasi ini juga memfasilitasi edukasi pasien dan keluarga agar teknik nonfarmakologis dapat diterapkan secara berkelanjutan di rumah. Pelayanan yang terpadu memperkuat kualitas

perawatan, kenyamanan pasien, dan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan (Liu et al., 2023).

4. Peran Edukasi Perawat Kepada Pasien dan Keluarga

Edukasi oleh perawat merupakan bagian penting dari penerapan teknik nonfarmakologis. Pasien dan keluarga diajarkan cara menerapkan relaksasi, distraksi, stimulasi sensorik, atau teknik komplementer secara aman. Penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan langkah-langkah intervensi meningkatkan partisipasi pasien dan kepatuhan terhadap metode yang diajarkan. Edukasi juga membantu pasien memahami pentingnya pengelolaan nyeri secara mandiri di rumah. Peran keluarga mendukung kontinuitas terapi nonfarmakologis dan memperkuat sistem dukungan pasien (Amalia et al., 2024).

Penyampaian edukasi dapat dilakukan melalui sesi tatap muka, panduan tertulis, atau media visual interaktif. Perawat memberikan Arahan tentang kondisi yang memerlukan perhatian medis dan teknik nonfarmakologis yang dapat diterapkan di rumah. Edukasi yang efektif membantu pasien mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperkuat kemampuan koping. Evaluasi pemahaman pasien dan keluarga penting untuk memastikan intervensi diterapkan dengan benar. Pendekatan ini mendukung keberhasilan terapi nyeri secara menyeluruh dan berkelanjutan (Yan et al., 2025).

F. Kelebihan dan Keterbatasan Teknik Nonfarmakologis

1. Kelebihan Penggunaan Teknik Nonfarmakologis

Teknik nonfarmakologis merupakan pendekatan perawatan yang aman dan efektif dalam mengelola nyeri, stres, dan ketegangan emosional pasien. Pendekatan ini tidak menggunakan obat, sehingga risiko efek samping dan komplikasi dapat diminimalkan. Metode nonfarmakologis dapat diterapkan pada berbagai kelompok usia dan kondisi klinis, pasien termasuk dengan penyakit kronis atau sensitivitas terhadap obat. Pendekatan ini juga mendorong pasien untuk lebih aktif berperan dalam pengelolaan kesehatan mereka secara mandiri. Penerapan teknik nonfarmakologis secara konsisten dapat meningkatkan kenyamanan, kualitas hidup, dan efektivitas perawatan secara keseluruhan (Ruano et al., 2022). Berikut ini kelebihan dari melakukan teknik nonfarmakologis untuk pasien:

a. Minim risiko efek samping

Keunggulan utama teknik nonfarmakologis adalah tingkat keamanannya yang tinggi. Metode ini tidak menggunakan obat sehingga risiko efek samping atau interaksi obat dapat dihindari. Teknik seperti aromaterapi, pijat, akupresur, dan transmisi umumnya aman untuk pasien

dari berbagai kelompok usia dan kondisi klinis. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan kondisi kronis atau yang memiliki sensitivitas terhadap terapi farmakologis. Penerapan teknik nonfarmakologis secara konsisten dapat mengurangi ketegangan fisik dan psikologis tanpa membahayakan kesehatan pasien (Nori et al., 2023).

b. Peningkatan kemampuan mengelola kondisi secara mandiri

Teknik nonfarmakologis memberdayakan pasien untuk mengelola gejala dan kondisi kesehatan mereka secara mandiri. Latihan pernapasan, relaksasi otot progresif, dan teknik kognitif-perilaku membantu pasien mengendalikan nyeri, stres, dan kecemasan. Keterampilan ini meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan mengontrol pasien terhadap proses penyembuhan. Penerapan metode ini mendukung strategi pengembangan jangka panjang yang dapat diteruskan di rumah. Pendekatan ini juga memperkuat partisipasi pasien dalam perawatan mereka sendiri (Romero et al., 2025).

c. Pendekatan holistik terhadap pasien

Teknik nonfarmakologis memperlakukan pasien secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, dan emosional. Terapi musik tidak hanya mengurangi nyeri fisik, tetapi juga menenangkan pikiran dan memperbaiki kesejahteraan emosional. Pendekatan holistik ini meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan membantu pasien merasa lebih nyaman dan didukung. Integrasi aspek fisik, mental, dan emosional memperkuat efektivitas intervensi nonfarmakologis. Teknik ini juga berkontribusi terhadap keseimbangan psikofisiologis pasien (Shi & Wu, 2023).

d. Kemampuan digunakan bersamaan dengan terapi medis

Teknik nonfarmakologis bersifat fleksibel dan dapat digunakan sebagai terapi pendukung atau komplementer bersama perawatan medis. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas pengobatan utama dan membantu pasien mengatasi gejala tambahan seperti kecemasan atau nyeri ringan hingga sedang. Misalnya, penyesuaian dan terapi musik dapat diterapkan pada pasien kanker untuk mengurangi kecemasan selama kemoterapi. Integrasi metode ini dengan terapi farmakologis menciptakan perawatan yang lebih menyeluruh dan optimal. Pendekatan terpadu ini meningkatkan kenyamanan dan kualitas pengalaman pasien dalam menjalani perawatan (Wang et al., 2025).

e. Efisiensi biaya dan aksesibilitas

Banyak teknik nonfarmakologis yang dapat diterapkan dengan biaya rendah dan tidak memerlukan peralatan khusus. Metode seperti latihan

pernapasan, relaksasi, atau olahraga ringan dapat dilakukan di rumah oleh pasien sendiri. Aksesibilitas yang mudah membuat metode ini dapat diterapkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini mendorong pasien untuk lebih aktif dalam pengelolaan kesehatan sehari-hari tanpa beban biaya tambahan. Efektivitas yang tinggi dengan biaya minimal menjadikannya solusi hemat dan praktis (Luckett et al., 2022).

f. Pengurangan ketergantungan terhadap obat

Teknik nonfarmakologis dapat mengurangi kebutuhan penggunaan obat pereda nyeri atau obat penenang, terutama pada nyeri ringan hingga sedang. Hal ini penting untuk mencegah risiko ketergantungan atau efek samping obat, termasuk obat pereda nyeri yang berisiko menimbulkan ketergantungan. Pendekatan ini memberikan strategi pengelolaan nyeri dan stres yang lebih aman dan berkelanjutan. Integrasi teknik nonfarmakologis dengan terapi medis membantu menciptakan rencana perawatan yang lebih seimbang dan efektif. Penerapan metode ini secara konsisten dapat meningkatkan kualitas hidup jangka panjang pasien (Niyonkuru et al., 2025).

2. Keterbatasan Penggunaan Teknik Nonfarmakologis

Teknik nonfarmakologis menawarkan alternatif aman dan efektif untuk mengelola nyeri serta stres pasien. Metode ini memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan kenyamanan fisik dan psikologis, tanpa menggunakan obat-obatan. Meskipun demikian, penerapan teknik nonfarmakologis memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Faktor-faktor seperti durasi efek, partisipasi pasien, sumber daya, serta budaya dan preferensi individu dapat mempengaruhi keberhasilan intervensi. Pemahaman terhadap keterbatasan ini penting agar intervensi dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara optimal dalam praktik klinis (Shi & Wu, 2023). Berikut ini penjelasan terkait keterbatasan penggunaan teknik nonfarmakologis:

a. Efek yang bersifat sementara

Teknik nonfarmakologis memberikan manfaat nyata bagi pasien, tetapi efek yang ditimbulkannya umumnya bersifat sementara. Nyeri atau ketegangan fisik dapat muncul kembali setelah intervensi selesai jika pasien tidak menerapkan teknik secara berulang. Beberapa metode, seperti relaksasi napas dalam, aromaterapi, atau distraksi, memerlukan konsistensi agar hasilnya bertahan lebih lama. Efek sementara ini menuntut pasien untuk berlatih secara rutin, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah. Penerapan teknik ini tetap bermanfaat sebagai strategi pengelolaan nyeri jangka pendek

dan sebagai pendukung terapi medis. Tenaga kesehatan perlu memberikan panduan kepada pasien agar dapat mempertahankan manfaatnya. Pendekatan ini menjadi strategi yang aman, meski tidak selalu menggantikan pengobatan utama (Patil et al., 2022).

b. Ketergantungan pada partisipasi aktif pasien

Keberhasilan teknik nonfarmakologis sangat bergantung pada keterlibatan aktif pasien. Pasien perlu fokus, memahami langkah-langkah yang diajarkan, dan menerapkannya secara konsisten agar metode bekerja efektif. Kondisi seperti ketidakmampuan kognitif, gangguan komunikasi, atau kurangnya motivasi dapat membatasi efektivitas intervensi. Peran perawat sangat penting untuk membimbing pasien melalui kompresi langsung dan latihan. Teknik yang memerlukan perhatian mental, seperti meditasi, imajinasi terbimbing, atau self-talk positif, memerlukan konsentrasi yang cukup. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi respons pasien membantu menentukan apakah teknik perlu disesuaikan. Keterlibatan keluarga atau pengasuh juga dapat mendukung keberhasilan penerapan teknik nonfarmakologis (Nori et al., 2023).

c. Keterbatasan sumber daya dan waktu tenaga kesehatan

Implementasi teknik nonfarmakologis memerlukan tenaga kesehatan terlatih dan waktu yang memadai. Fasilitas dengan jumlah pasien yang tinggi, waktu perawat untuk membimbing setiap individu bisa terbatas. Beberapa metode memerlukan lingkungan khusus, seperti ruang tenang untuk meditasi atau peralatan sederhana untuk aromaterapi dan pijat. Ketidakterediaan sumber daya atau waktu dapat mengurangi konsistensi dan kualitas penerapan teknik. Pelatihan staf secara rutin dan manajemen jadwal yang baik membantu mengoptimalkan penggunaan metode ini. Perencanaan yang tepat memungkinkan integrasi teknik nonfarmakologis dengan perawatan rutin tanpa mengganggu pelayanan medis lainnya. Evaluasi berkala penting untuk memastikan efektivitas intervensi tetap terjaga (Nori et al., 2023).

d. Hambatan budaya dan preferensi individu

Penerimaan teknik nonfarmakologis dapat dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan preferensi pasien. Beberapa pasien mungkin menolak metode tertentu karena keyakinan pribadi atau pengalaman sebelumnya. Penting untuk menyesuaikan intervensi agar sesuai dengan nilai individu tanpa mengurangi efektivitas teknik. Pendidikan yang jelas mengenai manfaat, tujuan, dan cara penerapan teknik sangat membantu meningkatkan partisipasi pasien. Diskusi terbuka tentang metode alternatif yang diterima

pasien memperkuat rasa nyaman dan keamanan. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya juga meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan terapi jangka panjang. Kolaborasi dengan keluarga atau *caregiver* dapat memperkuat dukungan dan penerimaan terhadap teknik nonfarmakologis (Chan et al., 2025).

G. Tantangan dan Strategi Penerapan Teknik Nonfarmakologis di Lapangan

Penerapan teknik nonfarmakologis di fasilitas kesehatan menghadapi beragam tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan fasilitas menjadi faktor kunci keberhasilan intervensi. Tantangan dapat muncul dari keterbatasan waktu, variasi respon pasien, hingga integrasi dengan perawatan medis lainnya. Strategi yang tepat diperlukan agar teknik dapat diterapkan secara aman, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang sistematis dan berbasis kebutuhan pasien meningkatkan kualitas perawatan serta kenyamanan pasien. Penerapan yang konsisten mendukung hasil yang lebih optimal dan memperkuat partisipasi pasien dalam proses perawatan (Patil et al., 2022b). Berikut ini merupakan berbagai tantangan dan strategi penerapan teknik nonfarmakologis yang biasa terjadi di lapangan:

1. Kurangnya Partisipasi Pasien

Pasien tidak bersedia melakukan teknik nonfarmakologis karena kurangnya pemahaman, motivasi, atau pengalaman sebelumnya. Nilai budaya, keyakinan pribadi, atau ketidaknyamanan awal dapat mempengaruhi partisipasi pasien. Teknik yang memerlukan fokus mental, seperti meditasi, relaksasi napas dalam, atau imajinasi terbimbing, membutuhkan konsentrasi penuh agar efektif. Tenaga kesehatan perlu menilai kesiapan pasien dan menyesuaikan metode dengan kondisi individu. Pendidikan yang jelas, pemaksaan langsung, dan bimbingan berulang menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman pasien. Keterlibatan keluarga atau pengasuh dapat mendukung motivasi dan keberhasilan penerapan teknik. Pendekatan ini membantu pasien merasakan manfaat teknik secara optimal dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap perawatan (Liu et al., 2023).

Peran tenaga kesehatan penting dalam memberikan penguatan, pemantauan, dan modifikasi intervensi sesuai kebutuhan pasien. Diskusi terbuka dan umpan balik pasien memungkinkan penyesuaian metode agar lebih sesuai. Motivasi pasien dapat ditingkatkan melalui penguatan positif dan pencatatan kemajuan. Pendekatan ini meningkatkan partisipasi aktif pasien dan mendukung kesejahteraan teknik di rumah. Strategi ini menjadi kunci untuk mengatasi resistensi dan membangun hasil yang konsisten.

2. Keterbatasan Waktu dan Tenaga Kesehatan

Keterbatasan waktu dan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dalam membimbing setiap pasien secara individu. Teknik nonfarmakologis sering memerlukan bimbingan langsung agar diterapkan dengan benar dan aman. Penerapan yang cepat dapat mengurangi efektivitas metode dan mempengaruhi pengalaman pasien. Strategi pengaturan jadwal, prioritas intervensi, dan pembagian tugas membantu mengatasi keterbatasan ini. Tenaga kesehatan dapat mengajarkan teknik yang dapat diterapkan secara mandiri oleh pasien agar tetap efektif. Evaluasi secara berkala dan pemantauan respons pasien untuk memastikan kualitas intervensi tetap terjaga. Pelatihan staf secara rutin meningkatkan keterampilan dan efisiensi dalam menerapkan teknik (Rahmawati et al., 2025).

Penggunaan alat bantu sederhana atau media digital dapat membantu tenaga kesehatan menghemat waktu. Misalnya, video panduan latihan pernapasan atau audio relaksasi dapat diterapkan sambil tetap menyatukan pasien lain. Pendekatan ini memungkinkan intervensi nonfarmakologis tetap konsisten meskipun sumber daya terbatas. Perencanaan yang matang membantu integrasi teknik dengan perawatan medis rutin tanpa mengganggu pelayanan utama. Pemantauan hasil secara berkala memastikan efektivitas tetap optimal. Strategi penerapan ini meningkatkan kemampuan fasilitas memberikan pelayanan yang aman dan nyaman. Langkah-langkah ini juga mendorong pasien untuk lebih mandiri dalam pengelolaan kesehatan.

3. Keterbatasan Fasilitas atau Sumber Daya

Tidak semua fasilitas memiliki ruang tenang, peralatan pendukung, atau bahan aromaterapi dan pijat yang memadai untuk penerapan teknik nonfarmakologis. Lingkungan yang bising, padat, atau kurang nyaman dapat mengurangi efektivitas teknik relaksasi dan stimulasi sensorik. Metode adaptasi sesuai sumber daya yang tersedia menjadi strategi penting agar pasien tetap menerima manfaat. Perawat dapat memanfaatkan musik, video, atau alat sederhana untuk menciptakan suasana yang nyaman. Prioritas diberikan pada teknik yang mudah diterapkan namun tetap efektif bagi pasien. Evaluasi secara berkala membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Strategi ini memungkinkan fasilitas tetap menerapkan teknik nonfarmakologis secara aman dan efisien (Chen et al., 2023).

Pengelolaan sumber daya yang terbatas juga menuntut koordinasi antarprofesi. Staf harus berlatih dalam berbagai teknik dan mampu menyesuaikan intervensi sesuai kondisi pasien dan fasilitas. Pemanfaatan ruang atau peralatan secara bergiliran memungkinkan intervensi tetap berjalan tanpa

mengganggu layanan lain. Dokumentasi penggunaan sumber daya membantu perencanaan lebih baik di masa mendatang. Pendekatan ini memperkuat efektivitas metode dan kenyamanan pasien. Strategi integrasi ini memastikan teknik nonfarmakologis tetap dapat diakses oleh seluruh pasien.

4. Variasi Respon dan Efektivitas Teknik

Respon pasien terhadap teknik nonfarmakologis bervariasi berdasarkan usia, kondisi fisik, psikologis, dan pengalaman sebelumnya. Beberapa pasien cepat merasakan kenyamanan, sedangkan yang lain membutuhkan latihan lebih lama untuk merasakan manfaat signifikan. Penyesuaian metode, durasi, dan intensitas intervensi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemantauan secara berkala membantu perawat menilai respons pasien dan menyesuaikan teknik jika diperlukan. Kombinasi berbagai teknik sering kali meningkatkan efektivitas. Edukasi pasien mengenai praktik mandiri di rumah memperpanjang manfaat intervensi. Strategi individualisasi memastikan intervensi sesuai kebutuhan pasien dan memastikan kepuasan (Demori et al., 2022).

Pendekatan ini juga mendukung strategi pengembangan koping jangka panjang. Pasien dapat memanfaatkan berbagai teknik sesuai kenyamanan dan kondisi masing-masing. Tenaga kesehatan perlu memberikan bimbingan dan pengawasan untuk memastikan praktik mandiri aman dan efektif. Penguatan motivasi dan umpan balik rutin dari pasien membantu meningkatkan keberhasilan penerapan teknik. Adaptasi berkelanjutan terhadap respons pasien menjadi kunci efektivitas jangka panjang. Strategi ini adalah ketidaknyamanan, keterlibatan pasien, dan pengawasan profesional agar manfaat teknik nonfarmakologis tetap optimal.

H. Simpulan

Nyeri merupakan pengalaman subjektif yang dirasakan berbeda oleh setiap individu. Sensasi nyeri tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi emosional dan psikologis. Tingkat nyeri dapat berubah sesuai usia, pengalaman sebelumnya, dan lingkungan sosial seseorang. Nyeri ringan hingga sedang sering muncul pada berbagai kondisi kesehatan dan dapat mengganggu kenyamanan. Gangguan aktivitas harian, kualitas tidur, dan suasana hati merupakan dampak yang sering dialami. Pemahaman yang tepat mengenai nyeri membantu masyarakat mengenali kondisi tubuhnya lebih baik. Kesadaran ini menjadi dasar dalam memilih cara penanganan nyeri yang aman dan sesuai.

Klasifikasi nyeri berdasarkan intensitas memberikan gambaran jelas mengenai tingkat keparahan nyeri yang dirasakan. Nyeri ringan biasanya masih

dapat ditoleransi dan tidak terlalu menghambat aktivitas sehari-hari. Nyeri sedang mulai mengganggu konsentrasi, mobilitas, dan kenyamanan individu. Penilaian nyeri dengan skala sederhana memudahkan seseorang menyampaikan keluhan nyeri secara objektif. Informasi ini membantu tenaga kesehatan menentukan pendekatan penanganan yang tepat. Pemahaman klasifikasi nyeri juga berguna bagi masyarakat untuk mengenali kapan perlu mencari bantuan medis. Kesadaran terhadap tingkat nyeri mendukung pengelolaan kesehatan yang lebih baik.

Manajemen nyeri nonfarmakologis merupakan pendekatan pengendalian nyeri tanpa penggunaan obat-obatan. Pendekatan ini memanfaatkan kemampuan alami tubuh dan pikiran untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Teknik nonfarmakologis bertujuan meningkatkan kenyamanan serta rasa kontrol individu terhadap nyeri. Pendekatan ini juga membantu menurunkan stres dan kecemasan yang sering menyertai nyeri. Penerapan metode ini dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bimbingan tenaga kesehatan. Manajemen nyeri nonfarmakologis cocok digunakan pada nyeri ringan hingga sedang. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam perawatan yang berfokus pada kebutuhan pasien.

Berbagai teknik nonfarmakologis dapat digunakan untuk membantu mengurangi nyeri secara efektif. Teknik relaksasi membantu menurunkan ketegangan otot dan menenangkan pikiran. Distraksi mengalihkan perhatian dari nyeri melalui aktivitas yang menyenangkan atau bermakna. Stimulasi sensorik seperti pijat atau kompres meningkatkan rasa nyaman pada tubuh. Teknik kognitif membantu individu mengubah cara berpikir terhadap nyeri yang dirasakan. Pemilihan teknik perlu disesuaikan dengan kondisi dan preferensi individu. Pendekatan yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan nyeri.

Penerapan teknik nonfarmakologis membutuhkan peran aktif tenaga kesehatan, khususnya perawat. Edukasi yang jelas membantu pasien dan keluarga memahami cara mengelola nyeri secara mandiri. Lingkungan yang nyaman dan komunikasi yang baik mendukung keberhasilan intervensi. Kolaborasi antar tenaga kesehatan memastikan teknik diterapkan secara aman dan sesuai kondisi pasien. Pemantauan berkala diperlukan untuk menilai efektivitas metode yang digunakan. Penyesuaian intervensi dilakukan berdasarkan respons pasien terhadap teknik yang diterapkan. Pendekatan ini meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Teknik nonfarmakologis memiliki kelebihan berupa risiko efek samping yang minimal. Biaya penerapannya relatif rendah dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pendekatan ini mendorong kemandirian individu dalam mengelola nyeri jangka panjang. Efektivitas teknik sangat bergantung pada keterlibatan aktif pasien. Efek yang dihasilkan umumnya bersifat sementara sehingga perlu

dilakukan secara konsisten. Pemahaman terhadap batasan penggunaan teknik sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan. Penerapan yang tepat menjadikan manajemen nyeri nonfarmakologis sebagai pendekatan yang aman dan bermanfaat.

1. Rekomendasi untuk Praktik Keperawatan

Perawat perlu melakukan pengkajian nyeri secara menyeluruh pada pasien dengan nyeri ringan hingga sedang. Pengkajian mencakup lokasi, intensitas, durasi, serta faktor yang memengaruhi nyeri. Penggunaan skala nyeri sederhana membantu pasien mengungkapkan keluhan secara jelas. Hasil pengkajian menjadi dasar penentuan intervensi keperawatan yang sesuai. Pemahaman kondisi pasien membantu perawat memberikan perawatan yang tepat sasaran. Keterlibatan pasien dalam proses pengkajian meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan. Pendekatan ini mendukung pengelolaan nyeri yang aman dan terarah (Tsegaye et al., 2023).

Perawat disarankan menerapkan teknik nonfarmakologis sebagai bagian dari asuhan keperawatan. Teknik relaksasi membantu menurunkan ketegangan otot dan menenangkan pikiran pasien. Distraksi mengalihkan perhatian pasien dari rasa nyeri melalui aktivitas sederhana. Stimulasi sensorik seperti sentuhan terapeutik atau kompres meningkatkan rasa nyaman. Pemilihan teknik perlu disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologis pasien. Penerapan teknik yang tepat meningkatkan efektivitas pengendalian nyeri. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap terapi farmakologis (Veen et al., 2024).

Edukasi kepada pasien dan keluarga merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan. Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat teknik nonfarmakologis meningkatkan pemahaman pasien. Instruksi yang jelas membantu pasien melakukan teknik secara mandiri. Pendampingan selama pelaksanaan teknik meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri pasien. Lingkungan perawatan yang tenang mendukung keberhasilan intervensi. Peran keluarga memperkuat dukungan emosional bagi pasien. Edukasi yang baik membantu mempertahankan hasil pengelolaan nyeri (Amalia et al., 2024).

Perawat perlu melakukan evaluasi berkala terhadap hasil intervensi yang telah diberikan. Perubahan intensitas nyeri menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan nyeri. Dokumentasi yang lengkap membantu kesinambungan asuhan keperawatan. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan perawat dalam teknik nonfarmakologis. Kerja sama dengan tenaga kesehatan lain mendukung pengelolaan nyeri secara menyeluruh. Pemantauan kondisi pasien mencegah terjadinya komplikasi.

Rekomendasi ini mendukung praktik keperawatan yang holistik dan berorientasi pada kenyamanan pasien (Tsegaye et al., 2023).

I. Referensi

- Almatrafi, A. S., Al-Mutairi, R. M. H., Alotaibi, A. M., & Binoraij, Muqrin Saud Ibrahim. (2020). Integrating Nursing and Emergency Care in Non-Pharmacological Management of Chronic Pain: Advancing Holistic Patient Care. *Tennessee Research International of Social Sciences*, 2(1), 60–79. <https://doi.org/10.29332/triss.v2n1.81>
- Alodhialah, A. M., Almutairi, A. A., & Almutairi, M. (2024). Assessing the Association of Pain Intensity Scales on Quality of Life in Elderly Patients with Chronic Pain: A Nursing Approach. *Healthcare (Switzerland)*, 12(20). <https://doi.org/10.3390/healthcare12202078>
- Alorfi, N. M. (2023). Pharmacological Methods of Pain Management : Narrative Review of Medication Used. *International Journal of General Medicine*, 16(July), 3247–3256.
- Amalia, I. N., Somantri, I., & Agustina, H. A. (2024). Optimalisasi Intervensi Terapi Non-Farmakologis Pada Nyeri Akut Post Operasi di Ruang Bimasakti RSUD Bandung Kiwari. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(1), 175–186.
- Amalia, I., Somantri, I., & Agustina, H. (2024). Optimalisasi Intervensi Terapi Non-Farmakologis Pada Nyeri Akut Post Operasi di Ruang Bimasakti RSUD Bandung Kiwari. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(1), 175–186.
- Andargeery, S. Y., Almalki, A. A., Aljohani, N., Alyami, H., & Alhagbani, A. (2024). Inpatient Satisfaction on Non-Pharmacological Interventions for Acute Settings: A Systematic Review. *Patient Preference and Adherence*, 18, 2169–2185. <https://doi.org/10.2147/PPA.S485369>
- Asyari, H., Rohaedi, S., Marsono, M., Hasni, N. I., & Darmawati, I. (2024). Effect of Deep Breathing Relaxation and Progressive Muscle Relaxation on Blood Pressure. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(5), 2565–2571. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v10i5.6896>
- Atthayasai, J., Chatchumni, M., Eriksson, H., & Mazaheri, M. (2023). Surgical Nurses' Perceptions of Strategies to Enhance Pain Management Proficiency: A Qualitative Study. *Nursing Reports*, 13(2), 923–933. <https://doi.org/10.3390/nursrep13020081>
- Barbosa, J., & Dinis-oliveira, R. J. (2025). Pharmacology and Toxicology of Opioids — Recent Advances and New Perspectives. *Pharmaceuticals*, 18(1055), 1–5.
- Boersma, K., & Flink, I. K. (2025). Key Aspects Concerning the Role of Emotion in the Chronic Pain Experience. *Current Opinion in Psychology*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2025.102000>

- Cardoso, C. S., Rita Matos, J., Prazeres, F., & Gomes, B. (2023). Non-Pharmacological Interventions in Primary Care to Improve the Quality of Life of Older Patients with Palliative Care Needs: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials. *BMJ Open*, 13(12). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-073950>
- Chan, S. H. W., Steward-Anderson, C., & Cheston, R. (2025). Listening to Voices Across Cultures: Non-Pharmacological Approaches to Coping with Sleep Problems in Dementia Among Ethnically Diverse Older Adults in the UK. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 25(1), 448. <https://doi.org/10.1186/s12906-025-05214-0>
- Chaughule, S. (2023). The Role of Cognitive Behavioral Therapy in Managing Chronic Pain. *Journal of Physical Medicine Rehabilitation Studies & Reports*, 1–9. [https://doi.org/10.47363/JPMRS/2023\(5\)E107](https://doi.org/10.47363/JPMRS/2023(5)E107)
- Chen, J., Wang, X., & Xu, Z. (2023). The Relationship Between Chronic Pain and Cognitive Impairment in the Elderly: A Review of Current Evidence. *Journal of Pain Research*, 16, 2309–2319. <https://doi.org/10.2147/JPR.S416253>
- Dagnino, A. P. A., & Campos, M. M. (2022). Chronic Pain in the Elderly: Mechanisms and Perspectives. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.736688>
- Demori, I., Molinari, E., Rapallo, F., Mucci, V., Marinelli, L., Losacco, S., & Burlando, B. (2022). Online Questionnaire with Fibromyalgia Patients Reveals Correlations among Type of Pain, Psychological Alterations, and Effectiveness of Non-Pharmacological Therapies. *Healthcare (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/healthcare10101975>
- Distinarista, H., Rahayu, T., Wuriningsih, A. Y., & Wahyuni, S. (2024). The Impact of Cervical Cancer on the Sexuality of Muslim Female Patients with Husbands: A Qualitative Phenomenological Study. *South East Asia Nursing Research*, 5(4), 1. <https://doi.org/10.26714/seanr.5.4.2023.1-6>
- Doering, R., Carter, S., Brinkmoller, S., Mohler, M., Dupont, D., Paul, C., Zugaj, M. R., Wurmbach, V., Balzer, A., Wensing, M., & Strabner, C. (2025). Understanding General Practitioner and Patient Perceptions Regarding Integration of Non-Pharmacological Interventions in Chronic Non-Cancer Pain Management. *Diseases*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/diseases13020034>
- Haghdoost, F., & Togha, M. (2022). Migraine Management: Non-Pharmacological Points for Patients and Health Care Professionals. *Open Medicine*, 17(1), 1869–1882. <https://doi.org/10.1515/med-2022-0598>
- Hamdani, S. U., Zill-e-Huma, Zafar, S. W., Suleman, N., Um-ul-Baneen, Waqas, A., & Rahman, A. (2022). Effectiveness of Relaxation Techniques 'as an Active Ingredient of Psychological Interventions' to Reduce Distress, Anxiety and Depression in Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis.

International Journal of Mental Health Systems, 16(1).
<https://doi.org/10.1186/s13033-022-00541-y>

- Hamidah, H., Rauf, S., Arifuddin, S., Muhammad, A., Musba, T., Prihantono, P., Pelupessy, N. U., Bukhari, A., Qanitha, A., Mappeware, N. A., Hatta, M., Astika, T., Permatasari, E., Rohman, R., Fatimah, F., & Hidayati, E. (2025). Comparison of Pain , Cortisol , and IL6 Levels Pre and Post SEFT in Stage III B Cervical Cancer Patients. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 26, 625–630.
<https://doi.org/10.31557/APJCP.2025.26.2.625>
- Haryanti, D. Y., & Rahman, S. A. (2024). Complementary Therapy and Holistic Nursing Care Plan. *International Applied Science*, 2, 2024.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32528/ias.v3i1.471>
- Hexendr, N. A., & Prajayanti, E. D. (2024). Penerapan Mobilisasi Dini Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi di Ruang HCU Cempaka Rsud Dr. Moewardi Surakarta. *Indonesian Journal of Public Health*, 2(4).
<https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJOH>
- Khusniyati, E., & Purwati, H. (2023). Effectiveness of Non-Pharmacological Intervention to Reduce Perineal Pain In Postpartum Women. *Journal of Scientific Research Education and Technology*, 2(2), 667–679.
- Kovacevic, I., Pavic, J., Filipovic, B., Ozimec Vulinec, S., Ilic, B., & Petek, D. (2024). Integrated Approach to Chronic Pain - The Role of Psychosocial Factors and Multidisciplinary Treatment: A Narrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(9).
<https://doi.org/10.3390/ijerph21091135>
- Kumari, S., Jaya, C., Reddy, P., & Reddy, G. (2015). Pain Intensity Scales and Studies Comparing Numarical Rating Scale and Visual Analogue Scale. *Certified Journal | Sarala et al. World Journal of Pharmaceutical Research*, 11.
<https://doi.org/10.20959/wjpr20227-24365>
- Lee, K., Lee, S., & Kim, J. (2024). Wound Pain Management: The Present and the Future. *Journal of Wound Management and Research*, 20(3), 199–211.
<https://doi.org/10.22467/jwmr.2024.03153>
- Liu, M. T., Liang, S. Y., Chao, T. C., Tseng, L. M., & Rosenberg, J. (2023). The Behavioral Adaptations and Barriers of Patients Employing Non-Pharmacological Strategies for Cancer Pain Management—A Qualitative Study. *Healthcare (Switzerland)*, 11(22).
<https://doi.org/10.3390/healthcare11222911>
- Luckett, T., Roberts, M., Smith, T., Garcia, M., Dunn, S., Swan, F., Ferguson, C., Kočovska, S., Phillips, J. L., Pearson, M., Currow, D. C., & Johnson, M. J. (2022). Implementing the Battery-Operated Hand-Held Fan as an Evidence-Based, Non-Pharmacological Intervention for Chronic Breathlessness in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A Qualitative Study of the

- Views of Specialist Respiratory Clinicians. *BMC Pulmonary Medicine*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12890-022-01925-z>
- Markovics, D., Virag, A., & Gado, K. (2025). Management of Chronic Pain in Elderly Patients: The Central Role of Nurses in Multidisciplinary Care. *Geriatrics*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/geriatrics10040110>
- Mihailov, L., Porocho, V., & Pascu, A. M. (2024). Aromatherapy – A Non-Pharmacological Approach in Pain Control. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov*, 16(65), 69–84. <https://doi.org/10.31926/but.ms.2023.65.16.2.9>
- Niyonkuru, E., Iqbal, M. A., Zhang, X., & Ma, P. (2025). Complementary Approaches to Postoperative Pain Management: A Review of Non-pharmacological Interventions. *Pain and Therapy*, 14(1), 121–144. <https://doi.org/10.1007/s40122-024-00688-1>
- Nori, W., Kassim, M. A. K., Helmi, Z. R., Pantazi, A. C., Brezeanu, D., Brezeanu, A. M., Penciu, R. C., & Serbanescu, L. (2023). Non-Pharmacological Pain Management in Labor: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(23). <https://doi.org/10.3390/jcm12237203>
- Patil, J. D., Sefen, J. A. N., & Fredericks, S. (2022a). Exploring Non-pharmacological Methods for Pre-operative Pain Management. In *Frontiers in Surgery* (Vol. 9). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.801742>
- Patil, J. D., Sefen, J. A. N., & Fredericks, S. (2022b). Exploring Non-pharmacological Methods for Pre-operative Pain Management. *Frontiers in Surgery*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.801742>
- Purnamasari, I., Nasrullah, D., Sumarliyah, E., Hasanah, U., & Choliq, I. (2023). Efektivitas Teknik Relaksasi Napas dalam Kombinasi Guided Imagery Dengan Musik Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur di RS. Siti Khodijah Sepanjang. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jkm.v0i0.17878>
- Rahmawati, Sudirman, A. A., & Hasanuddin, F. (2025). Pendidikan Kesehatan Manajemen Nyeri Sebagai Upaya Terapi Non Farmakologi pada Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. *Omni Pengabdian Masyarakat*, 2, 6–14.
- Rodriguez, I., Ortola, R., Graciani, A., Martínez-Gomez, D., Banegas, J. R., Rodríguez-Artalejo, F., & García-Esquinas, E. (2022). Pain Characteristics, Cardiovascular Risk Factors, and Cardiovascular Disease. *Journals of Gerontology*, 77(1), 204–213. <https://doi.org/10.1093/gerona/glab079>
- Romero, M. V., Gómez-Hernández, M. B., Saz, A. P. Del, Martínez-Monrobé, M. B., Gutiérrez-Fernández, N., Arroyo-Rodríguez, A., Garrido-Alfaro, R. A., Canal-Diez, N., Guerra-Martín, M. D., & Pereira-Delgado, C. (2025). Empowering Patients: A Multicomponent Workshop Improves Self-Management and

- Quality of Life in Chronic Pain. *Medical Sciences*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/medsci13040319>
- Ruano, A., Garcia-Torres, F., Galvez-Lara, M., & Moriana, J. A. (2022). Psychological and Non-Pharmacologic Treatments for Pain in Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Pain and Symptom Management*, 63(5), e505–e520. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.12.021>
- Sakalli, G. D., & Kara, O. (2022). Use of Complementary and Integrative Methods in the Management of Postoperative Pain: A Narrative Literature Review. *Mediterranean Nursing and Midwifery*, 2(2), 84–93. <https://doi.org/10.5152/MNM.2022.222346>
- Sari, Y., Haflah, N., Utami, I. P., & Aziz, A. (2023). The Effectiveness of Distraction Techniques for Pain in Fracture Patients in Sundari General Hospital, Medan. *Scientific Periodical of Public Health and Coastal Health*, 5(2), 683–690.
- Sehdev, J. (Steven) C. P. F. K. I. V. M. L. A. F. J. S. (2025). *Physiology, Pain*.
- Sharma, A., Sharma, N., & Chahal, A. (2024). Navigating the Landscape of Preterm Neonatal Pain: A New Horizon in Sensory Stimulation. *Journal of Clinical Neonatology*, 13(1), 19–26. https://doi.org/10.4103/jcn.jcn_84_23
- Shi, Y., & Wu, W. (2023). Multimodal Non-Invasive Non-Pharmacological Therapies for Chronic Pain: Mechanisms and Progress. *BMC Medicine*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12916-023-03076-2>
- Swathi, M., Manjusha, S., Vadakkiniath, I. J., & Gururaj, A. (2023). Prevalence and Correlates of Stress, Anxiety, and Depression in Patients with Chronic Diseases: A Cross-Sectional Study. *Middle East Current Psychiatry*, 30(1). <https://doi.org/10.1186/s43045-023-00340-2>
- Tsegaye, D., Yazew, A., Gedfew, M., Yilak, G., & Yalew, Z. M. (2023). Non-Pharmacological Pain Management Practice and Associated Factors Among Nurses Working at Comprehensive Specialized Hospitals. *Sage Open Nursing*, 9, 1–12. <https://doi.org/10.1177/23779608231158979>
- Veen, S. V., Drenth, H., Hobbelen, H., & Finnema, E. (2024). Non-Pharmacological Interventions Feasible in the Nursing Scope of Practice for Pain Relief in Palliative Care Patients: A Systematic Review. *Palliative Care and Social Practice*, 18. <https://doi.org/10.1177/26323524231222496>
- Wahyuni, S., Rahayu, T., Distinarista, H., & Wuriningsih, A. Y. (2020). Antenatal Multimodal Intervention and Hemodynamic Response in Pregnant Women who Experience Back Pain. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 9278–9284.
- Wang, L., Bs, N., Qin, F., Ms, N., Liu, H., Lu, X., Ms, N., Zhen, L., Ms, N., & Li, G. (2024). Pain Management Nursing Pain Sensitivity and Acute Postoperative Pain in Patients Undergoing Abdominal Surgery: The Mediating Roles of Pain Self-

Efficacy and Pain. Elsevier, 25, 108–114.
<https://doi.org/10.1016/j.pmn.2023.12.001>

Wang, Y., Aaron, R., Attal, N., & Colloca, L. (2025). An Update on Non-Pharmacological Interventions for Pain Relief. *Cell Reports Medicine*, 6(2).
<https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.101940>

Yan, S., Yan, F., Liangyu, P., & Fei, X. (2025). Assessment of Non-Pharmacological Nursing Strategies for Pain Management in Tumor Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Pain Research*, 6.
<https://doi.org/10.3389/fpain.2025.1447075>

J. Glosarium

A

Analgesik : Zat atau cara untuk mengurangi rasa sakit.

F

Farmakologis : Gula darah tinggi saat hamil.

H

Holistik : Perawatan menyeluruh.

Hipnosis : Terapi sugesti.

I

Indikasi : Alasan penggunaan tindakan.

K

Kognitif : Proses berpikir.

Kontraindikasi : Kondisi tindakan pembatas.

N

Nyeri Muskuloskeletal : Nyeri otot dan rangka.

O

Otot Progresif : Relaksasi otot secara bertahap.

PROFIL PENULIS



Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 1990. Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia mulai S1, S2 dan Profesi. Penulis menyelesaikan S1 tahun 1999, S2 tahun 2005 dan Spesialis keperawatan Maternitas tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Doktorat pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) tahun 2019.

Keahlian penulis adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen SDM Kesehatan. Penulis Sebagai dosen pengajar Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh.

Selain mengajar, penulis aktif sebagai Penulis aktif dalam pelatihan, workshop, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Informasi publikasi dapat diakses pada Google Scholar y2hhHCoAAAAJ. Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang telah mempunyai ISBN dari IKAPI dan Prodi DIII Keperawatan Banda Aceh. Adapun judul judul buku yang telah terbit: Profil Metabolik Remaja, Suami Siaga, Tips ibu hamil dan Pasca bersalin, Analisis Kepuasan pasien melalui Kinerja perawat di RS Pemerintah, Deteksi Dini Resiko Preeklampsia dan Inovasi Tehnologi Kesehatan.

Selama ini penulis aktif organisasi diantaranya seperti Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (Ketua Regional Aceh 2020-2024). Organisasi berikutnya yang ditekuni penulis adalah Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI; ketua IPEMI Aceh 2009-2024). Demikian juga penulis aktif dalam ikatan alumni Universitas Indonesia (Provinsi Aceh).

Email: halimatussakdiah@poltekkesaceh.ac.id

Motto: "Membuka jendela dunia dengan menulis, dan Membuka jendela mata dengan membaca" .

PROFIL PENULIS



Asni Hasaini., S.Kep.,Ns., M.Kep. Lahir di Banjarmasin, 03 Pebruari 1987. Riwayat Pendidikan : Lulus Diploma Keperawatan di Akademi Keperawatan Intan Martapura Tahun 2007. Lulus Sarjana Keperawatan Tahun 2010 dan meraih gelar Ners Tahun 2011 di Universitas Brawijaya Malang. Meraih gelar Magister Keperawatan Tahun 2015 di Stikes Muhammadiyah Banjarmasin. Pengalaman organisasi : Sekretaris DPD PPNI Kabupaten Banjar Masa Bakti 2022-2027. Riwayat Pekerjaan : Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura Tahun 2011 sampai sekarang dan masuk dalam Divisi Keperawatan Medikal Bedah selain itu juga sebagai pengampu Mata Kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, Keperawatan Medikal Bedah 2. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian di masyarakat dan mengikuti kegiatan untuk menunjang kompetensi seperti seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asnihasaini@gmail.com



Ns. Yoanita Hijriyati, SKep, M. Biomed. Dosen Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan. Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 November 1979. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Keperawatan-Universitas Indonesia dan Pendidikan S2 pada Jurusan Fisiologi Ilmu Biomedik-Universitas Indonesia. Memulai karier sebagai dosen muda pada tahun 2003 di Universitas Binawan, Jakarta. Hingga saat ini, penulis masih aktif mengajar dan membimbing mahasiswa program studi keperawatan di universitas tersebut. Selama perjalanan akademiknya, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Karya-karya tersebut mencakup berbagai topik dalam bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, yang turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan di Indonesia. Selain itu, penulis juga menulis beberapa buku yang mengupas berbagai aspek terkait ilmu keperawatan dengan pendekatan yang mudah dipahami. Penulis juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penulis berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pengetahuan masyarakat luas, sekaligus menjembatani antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat di komunitas. Penulis terus berkomitmen untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan mendukung lahirnya tenaga kesehatan yang profesional dan berdedikasi tinggi.

PROFIL PENULIS



Ns. Agus Sumarno, S.Kep., M.Pd. Lahir di Rembang, 10 April 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan di AKPER As-Syafi'iyah dan melanjutkan studi Program S1 Keperawatan di FIK Universitas Indonesia tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Islam As-Syafi'iyah lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Staf Pengajar. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam As-Syafi'iyah mengampu mata kuliah Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan, Komunikasi dalam Keperawatan, Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Pendidikan dan Promosi Kesehatan, Komunikasi dalam Keperawatan, publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, pembicara Penanggulangan Gawat Darurat dan Bencana. Penulis Sebagai Pengurus AIPViKI Periode 2019 s.d. sekarang. Sebagai Pengurus DPK PPNI Universitas Islam As-Syafi'iyah Periode 2022 - 2027. Penulis juga pernah bertugas menjadi Relawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu, Gempa bumi di Lombok, Tsunami di Serang Banten dan Banjir di Jawa Barat.

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat Lahir di Kendal, Jawa Tengah , 09 Juni 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro tahun 2003, melanjutkan pendidikan profesi Ners di Universitas Diponegoro tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia lulus tahun 2011 dan melanjutkan program ners spesialis maternitas lulus tahun 2012. Pendidikan Doktor ditempuh di Universitas Airlangga tahun 2024 dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 di Akper Islam Sultan Agung Semarang yang selanjutnya pada tahun 2007 berkembang menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan dibawah Universitas Islam Sultan Agung Semarang . Pada tahun 2007 awal berdirinya program studi penulis diamanahi sebagai Ketua Program Studi S1 Keperawatan yang pertama. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Keperawatan. Penulis mengampu mata kuliah pada program study Diploma III, S1 Ilmu Keperawatan dan Magister Keperawatan dengan Mata kuliah Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Konsep Keperawatan Maternitas, Kesehatan Perempuan, Pengkajian Keperawatan Maternitas, Manajemen Asuhan Keperawatan Maternitas, Metodologi Penelitian, Riset Kuantitatif dan Inovasi in Caring. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam penelitian, pengabdian masyarakat, seminar dan publikasi ilmiah. Penulis juga aktif pada organisasi dibidang keperawatan, himpunan, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wahyuni@unissula.ac.id
Motto: "Tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan usaha yang biasa"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Dasar-Dasar Praktik Keperawatan: Panduan Sederhana untuk Asuhan di Fasilitas Kesehatan disusun sebagai pegangan praktis bagi mahasiswa dan perawat pemula dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, terarah, dan berpusat pada pasien. Dengan bahasa yang sederhana dan alur yang sistematis, buku ini membantu pembaca memahami fondasi keperawatan sekaligus menguatkan keterampilan dasar yang paling sering dibutuhkan di fasilitas kesehatan primer maupun rumah sakit.

Pembahasan dimulai dari landasan profesi hingga proses awal asuhan. Chapter 1 menguraikan konsep dasar keperawatan dalam pelayanan kesehatan, termasuk ruang lingkup, filosofi dan paradigma keperawatan, peran perawat, patient centred care, serta pentingnya edukasi pasien. Chapter 2 membahas pengkajian pasien secara sederhana melalui pemeriksaan tanda-tanda vital, riwayat kesehatan, dan observasi dasar sebagai langkah awal mengenali kondisi dan kebutuhan pasien. Selanjutnya, Chapter 3 memaparkan konsep diagnosis keperawatan serta diagnosis yang umum muncul di rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer sebagai acuan dalam menetapkan masalah keperawatan secara tepat.

Bagian akhir berfokus pada intervensi, edukasi, dan kenyamanan pasien. Chapter 4 menjelaskan intervensi keperawatan dasar—personal hygiene, mobilisasi, nutrisi, dan eliminasi—serta integrasi, evaluasi, dan kolaborasi dalam praktik. Chapter 5 menguatkan peran perawat sebagai edukator melalui pendidikan kesehatan sederhana bagi pasien dan keluarga, mulai dari prinsip, metode dan media, penerapan pada kasus, hingga evaluasi edukasi untuk meningkatkan kemandirian. Chapter 6 menutup dengan manajemen nyeri ringan–sedang menggunakan teknik nonfarmakologis, termasuk ragam teknik, cara implementasi di fasilitas kesehatan, serta tantangan dan strategi penerapannya. Secara keseluruhan, buku ini diharapkan menjadi rujukan ringkas namun aplikatif dalam membangun keterampilan dasar keperawatan yang bermutu dan manusiawi.

Buku Bunga Rampai Dasar-Dasar Praktik Keperawatan: Panduan Sederhana untuk Asuhan di Fasilitas Kesehatan disusun sebagai pegangan praktis bagi mahasiswa dan perawat pemula dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, terarah, dan berpusat pada pasien. Dengan bahasa yang sederhana dan alur yang sistematis, buku ini membantu pembaca memahami fondasi keperawatan sekaligus menguatkan keterampilan dasar yang paling sering dibutuhkan di fasilitas kesehatan primer maupun rumah sakit.

Pembahasan dimulai dari landasan profesi hingga proses awal asuhan. Chapter 1 menguraikan konsep dasar keperawatan dalam pelayanan kesehatan, termasuk ruang lingkup, filosofi dan paradigma keperawatan, peran perawat, patient centred care, serta pentingnya edukasi pasien. Chapter 2 membahas pengkajian pasien secara sederhana melalui pemeriksaan tanda-tanda vital, riwayat kesehatan, dan observasi dasar sebagai langkah awal mengenali kondisi dan kebutuhan pasien. Selanjutnya, Chapter 3 memaparkan konsep diagnosis keperawatan serta diagnosis yang umum muncul di rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer sebagai acuan dalam menetapkan masalah keperawatan secara tepat.

Bagian akhir berfokus pada intervensi, edukasi, dan kenyamanan pasien. Chapter 4 menjelaskan intervensi keperawatan dasar—personal hygiene, mobilisasi, nutrisi, dan eliminasi—serta integrasi, evaluasi, dan kolaborasi dalam praktik. Chapter 5 menguatkan peran perawat sebagai edukator melalui pendidikan kesehatan sederhana bagi pasien dan keluarga, mulai dari prinsip, metode dan media, penerapan pada kasus, hingga evaluasi edukasi untuk meningkatkan kemandirian. Chapter 6 menutup dengan manajemen nyeri ringan—sedang menggunakan teknik nonfarmakologis, termasuk ragam teknik, cara implementasi di fasilitas kesehatan, serta tantangan dan strategi penerapannya. Secara keseluruhan, buku ini diharapkan menjadi rujukan ringkas namun aplikatif dalam membangun keterampilan dasar keperawatan yang bermutu dan manusiawi.

ISBN 978-634-7556-72-1



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

